



NOTA

La medicina es una ciencia sometida a un cambio constante. A medida que la investigación y la experiencia clínica amplían nuestros conocimientos, son necesarios cambios en los tratamientos y la farmacoterapia. Los editores de esta obra han contrastado sus resultados con fuentes consideradas de confianza, en un esfuerzo por proporcionar información completa y general, de acuerdo con los criterios aceptados en el momento de la publicación. Sin embargo, debido a la posibilidad de que existan errores humanos o se produzcan cambios en las ciencias médicas, ni los editores ni cualquier otra fuente implicada en la preparación o la publicación de esta obra garantizan que la información contenida en la misma sea exacta y completa en todos los aspectos, ni son responsables de los errores u omisiones ni de los resultados derivados del empleo de dicha información. Por ello se recomienda a los lectores que contrasten dicha información con otras fuentes. Por ejemplo, y en particular, se aconseja revisar el prospecto informativo que acompaña a cada medicamento que deseen administrar, para asegurarse de que la información contenida en este libro es correcta y de que no se han producido modificaciones en la dosis recomendada o en las contraindicaciones para la administración. Esta recomendación resulta de particular importancia en relación con fármacos nuevos o de uso poco frecuente. Los lectores también deben consultar a su propio laboratorio para conocer los valores normales.

No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, su tratamiento informático, la transmisión de ningún otro formato o por cualquier medio, ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, por registro y otros medios, sin el permiso previo de los titulares del copyright.

C/ Albarracín, 34; 28037 Madrid
Tfno.: (0034) 91 782 43 30 - Fax: (0034) 91 782 43 43
E-mail: editorial@grupocto.com
Página web: www.grupocto.com



Reumatología

Si una niña de 5 años presenta una artritis de una rodilla y se ha descartado una artritis infecciosa, es muy recomendable estudiar:

1. Las articulaciones sacroilíacas con radiografía simple.
2. Los anticuerpos antinucleares y el estado del iris y cuerpo ciliar.
3. El resto de la familia y realizarles un estudio de factor reumatoide.
4. No hacer nada porque el cuadro es autolimitado y no dejará secuelas.

Resp. Correcta: 2

Comentario: La causa más frecuente de afectación inflamatoria articular en la infancia es la artritis crónica juvenil, pero no es la única, por ello además de apreciar inflamación articular durante a menos 6 semanas en un paciente de menos de 16 años debemos descartar otras causas de artritis con tratamiento específico, como la infección (si es monoarticular, afecta a la rodilla y es prolongado habría que descartar tuberculosis). En este caso descartada la infección nos encontramos ante una niña de menos de 6 años con menos de 4 articulaciones afectadas, por lo que habría que sospechar una forma de comienzo oligoarticular precoz, en la que podemos encontrar AAN y HLA DR5. La complicación más grave de la enfermedad es la uveitis posterior que debe ser buscada activamente ya que su pronóstico depende diagnóstico y tratamiento precoz.

-----O-----

Valora a una paciente de 78 años que acude por dolor en columna dorsolumbar de varias semanas de evolución, por el que fue valorada por su médico de atención primaria, quien le pautó paracetamol y tramadol, sin presentar mejoría. Le solicita una radiografía de columna donde presenta acuñaamiento de L1, y revisando pruebas anteriores, encuentra una densitometría ósea de hace 6 meses donde presentaba un T-score de -2.7. Ante esto, ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Espondilodiscitis.
2. Metástasis ósea de tumor primario no conocido.
3. Mal de Pott.
4. Fractura por fragilidad.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La paciente presenta una fractura por fragilidad, teniendo pruebas diagnósticas pruebas compatibles con osteoporosis. La fractura vertebral es la fractura más frecuente en pacientes con osteoporosis.

-----O-----

¿Cuándo está indicado el drenaje articular percutáneo en la artritis séptica?:

1. Solo en el momento del diagnóstico.
2. Sólo cuando persiste la fiebre y el dolor a pesar del tratamiento antibiótico.
3. Solo en la artritis séptica por *Staphylococcus aureus*.
4. Al menos una o dos veces diarias durante los primeros días.

Resp. Correcta: 4

Comentario: El tratamiento de la artritis séptica es un tema importante, debes aprender lo más básico: gérmenes más frecuentes y el antibiótico que lo cubre. Este tipo de preguntas con opciones que incluyen las palabras "sólo" o "nunca" te facilitan elegir la respuesta acertada. Las artritis sépticas se tratan con antibióticos, pero su acceso es difícil a estos tejidos, y el derrame purulento perpetúa la inflamación. Debe drenarse el pus todos los días mediante artrocentesis mientras persista el derrame, la primera semana. A partir de entonces si cursa desfavorablemente, se drenará por métodos más agresivos (artrotomía, artroscopia).

-----o-----

Un varón de 40 años de consulta por presentar dolor lumbar de larga evolución, que no ha mejorado con tratamiento analgésico convencional. Le solicita una radiografía de columna lumbosacra para iniciar el estudio en la que se objetiva sacroileítis bilateral. Ante la entidad que sospecha ¿con cual de los siguientes antígenos esta más asociados?

1. HLA B57
2. HLA DQ2
3. DLA B5
4. HLA B27

Resp. Correcta: 4

Comentario: Pregunta muy sencilla sobre las espondiloartropatías, en concreto la espondilitis anquilosante en la que te solicitan que valores cual es el marcador inmune más relacionado y debes saber que es el HLA B27

-----o-----

Una paciente de 27 años consulta por presentar desde hace 4 meses un cuadro de oligoartritis en tobillo derecho y rodilla izquierda. No recuerda antecedentes de interés ni otros síntomas asociados. En la exploración se objetiva, a parte del cuadro oligoarticular, tendinitis aquilea izquierda y fascitis plantar bilateral. No presenta lesiones cutáneas. No presenta dolor axial. Analíticamente destaca PCR 2 mg/dl, VSG 30 mm. ANA negativo, FR 14 UI/L, HLA B27 positivo. ¿Ante estos datos, qué enfermedad le parece MÁS probable?

1. Artritis reactiva.
2. Artritis reumatoide.
3. Espondiloartritis indiferenciada.
4. Espondilitis anquilosante.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Ante un paciente con un cuadro de oligoartritis crónica asimétrica de miembros inferiores hay que sospecha, en primer lugar, una espondiloartritis. Más aún si lleva asociado otros síntomas como entesitis, dactilitis o uveítis anterior. En este caso, teniendo en cuenta la falta de antecedente infeccioso, así como de clínica axial o gastrointestinal el cuadro más probable es el de espondiloartritis indiferenciada.

-----o-----

Una paciente de 43 años ha sido diagnosticada de LES desde hace años con afectación articular, cutánea y renal (glomerulonefritis proliferativa focal). Los síntomas se han

controlado con dosis bajas (10 mg/día) de corticoides, que recibe desde hace varios meses. Actualmente presenta desde hace 3 semanas dolor en rodilla derecha que cede con el reposo y aumenta con los movimientos. No ha percibido signos inflamatorios en dicha articulación ni síntomas a otro nivel. La analítica muestra VSG normal, leucopenia y linfopenia discretas. La radiografía de rodillas no muestra alteraciones. Se realiza Resonancia magnética nuclear (IMAGEN). ¿Cuál le parece el diagnóstico más probable de esta enferma?

1. Osteodistrofia renal.
2. Osteomielitis por neumococo.
3. Osteonecrosis aséptica.
4. Actividad articular de su enfermedad de base.

Resp. Correcta: 3

Comentario: El comentario se realiza en vídeo.

-----o-----

El órgano que con más frecuencia se afecta clínica y anatomopatológicamente en la panarteritis nodosa es:

1. Sistema nervioso central.
2. Tracto gastrointestinal.
3. Corazón.
4. Riñón.

Resp. Correcta: 4

Comentario: En la PAN clásica el órgano más frecuentemente afectado es el riñón, con desarrollo de isquemia glomerular debido a afectación de arterias arqueadas renales, con desarrollo de HTA y deterioro de función renal... Por detrás de la afectación renal y en orden de frecuencia aparece afectación musculoesquelética (artralgias, artritis...), cutánea (púrpura, nódulos, livedo reticularis...) digestiva (dolor abdominal, vómitos, hemorragias, infarto, perforación...), cardíaca (ICC, IAM, pericarditis), genitourinaria (dolor testicular u ovárico) y afectación del SNC (ACV, alteraciones del estado mental y convulsiones)

-----o-----

Varón de 48 años de edad que acude a consulta remitido por su médico de cabecera por un cuadro de malestar general, pérdida de peso y artromialgias de 2 meses de evolución. Ocasionalmente refiere dolor abdominal con náuseas y vómitos que no se relacionan con la ingesta. Aporta analítica con anemia normocítica normocrómica (Hb 11,2 g/dl, Hcto. 32%), leucocitosis con neutrofilia sin desviación izquierda, deterioro leve de la función renal (creatinina 1,7) y elevación de la velocidad de sedimentación globular (VSG 65 mm/h). En la exploración de ambos miembros inferiores es evidente una lesión cutánea sugestiva de livedo reticularis. ¿Cuál de las siguientes opciones es FALSA?:

1. La ausencia de sinusitis y afectación pulmonar descartar razonablemente la enfermedad de Wegener.
2. La determinación del antígeno Australia es positiva en el 80% de los casos.
3. La actitud correcta es el ingreso para el estudio.

4. El diagnóstico de la entidad es anatomopatológico.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Nos hallamos ante un paciente con un cuadro muy sugestivo de vasculitis: artromialgias, pérdida de peso, afectación intestinal con dolor abdominal, afectación cutánea como livedo reticularis y afectación renal. Además la analítica resulta poco aclaratoria, ya que la anemia, la leucocitosis y la elevación de la VSG pueden relacionarse con muchos procesos en fase aguda. Así que revisando las opciones que te dan, es cierto que ante un cuadro así, la ausencia de eosinofilia (y también de asma), te descarta razonablemente la posibilidad de un Churg- Strauss. Por otro lado, la ausencia también de afectación de vías respiratorias superiores, pulmonar, y la ausencia de C- ANCA, también te hace pensar en un Wegener como muy poco probable, así que, fundamentalmente pensaríamos que nos encontramos ante un cuadro de PAN clásica o PAN microscópica (más probable una clásica ya que no existe afectación pulmonar). Independientemente, de las posibilidades, estamos ante un cuadro potencialmente muy grave si pensamos en una vasculitis sistémica, por lo que deberíamos ingresar al paciente, estudiarlo y solicitar una biopsia de algún órgano afectado en cuanto sea posible. Aunque estuviésemos ante una PAN clásica, que es la que más frecuentemente se relaciona con la hepatitis B, la asociación aparece sólo en un 30% de los casos aproximadamente.

-----O-----

Acude a su consulta a la mujer de 26 años que refiere desde hace varias semanas dolor en las muñecas y articulaciones de las manos de forma simétrica, siendo el dolor más intenso por las mañanas, refiriendo mejoría largo del día. Ante estos hallazgos ¿cuál cree que es la el diagnóstico más probable?

1. Lupus eritematoso sistémico
2. Enfermedad mixta del tejido conectivo
3. Artritis reumatoide
4. Artrosis

Resp. Correcta: 3

Comentario: Pregunta sencilla y básica sobre la AR, nos presentan un caso clínico, que simplemente por la exploración física debemos ser capaces de diagnosticar

-----O-----

Con respecto al uso de la PET-TC en enfermedades autoinmunes, señale la afirmación CORRECTA:

1. Presenta utilidad en vasculitis, especialmente en las asociadas a ANCA.
2. En pacientes con síntomas sistémicos (febrícula, astenia, hiporexia, artromialgias) permite la detección de actividad inflamatoria preclínica.
3. En las vasculitis de grandes vasos ha demostrado una sensibilidad y especificidad similares a la ecografía-Doppler en la detección de arteritis de la temporal y sus ramas.
4. El radiofármaco más utilizado es Tc-99m (isómero metaestable del tecnecio).

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La PET-TC es una prueba que combina la Medicina Nuclear a través del uso, habitualmente, de 18F-FDG (glucosa marcada radiactivamente) y la definición anatómica de la TC. Permite conocer las estructuras o

lesiones que son metabólicamente más activos. En el campo de las enfermedades autoinmunes todavía tiene una utilidad por definir, pero parece tener utilidad en pacientes con vasculitis de grandes vasos (las vasculitis ANCA son de pequeño vaso), pues puede detectar inflamación de la pared vascular, si bien debe diferenciarse correctamente de la aterosclerosis, así como valorar otras causas cuando sea preciso. Se ha utilizado en algunos casos para valorar la respuesta al tratamiento. La ecografía-Doppler demuestra una elevada sensibilidad mediante el “signo del halo”, si bien no puede sustituir a la biopsia (*gold-standard*, máxima especificidad); sí es cierto que puede servir para apoyar el diagnóstico y/o guiar la biopsia. Por su parte, la PET-TC valora con mucha dificultad las arterias craneales como la temporal y las arterias renales, por su cercanía al cerebro y a los riñones, que son órganos que captan gran cantidad de 18F-FDG de forma fisiológica, interfiriendo en la valoración. Es cierto que la PET-TC se solicita en casos de síntomas sistémicos y constitucionales, pudiendo desenmascarar neoplasias, infecciones y en ocasiones hallazgos que sugieren autoinmunidad, como, por ejemplo, incremento de captación de 18F-FDG en pared de aorta y sus ramas (vasculitis), artritis con datos de actividad (espondilitis, sacroileítis, etc.), entre otros (respuesta 2 correcta).

-----O-----

El síndrome de Kelley-Seegmiller es debido a:

1. Déficit de ácido inosínico.
2. Déficit de fosforribosil pirofosfato sintetasa.
3. Déficit parcial de hipoxantina-guanina fosforribosiltransferasa.
4. Déficit de dioxiadénina.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Dentro de las causas que producen hiperuricemia por aumento de síntesis de ácido úrico, se incluyen una serie de alteraciones genéticas en el ciclo de degradación de las purinas. El déficit de hipoxantina-guanina fosforribosiltransferasa (HGPRT) es una alteración genética ligada al cromosoma X que produce hiperuricemia. Cuando el déficit es completo, se produce la enfermedad de Lesch-Nyhan, que cursa con hiperuricemia y trastornos neurológicos asociados: coreoatetosis y automutilaciones. Cuando el déficit es parcial, la enfermedad sólo es parcial, no tiene clínica neurológica y la conocemos como síndrome de Kelley-Seegmiller.

-----O-----

El mixoma auricular puede simular una enfermedad del tejido conjuntivo o una vasculitis sistémica. Señale cuál de los siguientes hallazgos NO se observa en esta entidad:

1. Fenómeno de Raynaud.
2. Artralgias/mialgias erráticas.
3. Hipergammaglobulinemia.
4. Anticuerpos anti-DNA positivos.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Los mixomas son los tumores primarios cardíacos más frecuentes. Aparte de la clínica de obstrucción valvular o de embolias sistémicas, pueden dar síntomas generales como fiebre, pérdida de peso, caquexia, exantemas, malestar general, acropaquias, artralgias o mialgias erráticas, fenómeno de Raynaud, elevación de reactantes de fase aguda, trombopenia o trombocitosis, hipergammaglobulinemia, anemia hemolítica o policitemia y leucocitosis, lo que provoca que en algunas ocasiones sean confundidos con

endocarditis o enfermedades del tejido conectivo. Lo que no provocan estos tumores es la positivización de anticuerpos anti- DNA.

Una paciente de 36 años consulta por presentar desde hace más de 8 años episodios de palidez y posteriormente cianosis de dedos de manos y pies desencadenados por la exposición al frío. Estos episodios se acompañan de “acorchamiento” y posteriormente dolor en las áreas afectadas. En estos años ha desarrollado, en los pulpejos de los dedos, ulceraciones dolorosas que evolucionan de forma tórpida y han condicionado la aparición de cicatrices en “mordedura de rata”. Refiere en los últimos meses disnea de moderados-grandes esfuerzos. En la exploración física presenta engrosamiento de la piel de 3.er y 4.º dedos de ambas manos. En el estudio de esta paciente no sería de utilidad una de las siguientes pruebas:

1. Ecocardiograma.
2. TAC pulmonar alta resolución.
3. Capilaroscopia.
4. Aortografía.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

En un varón de 45 años, sin enfermedad renal asociada, que presenta el 10º episodio de podagra en los últimos 2 años, trataría la hiperuricemia, una vez superado el episodio agudo, con:

1. Alopurinol y colchicina.
2. Benzbromarona y colchicina
3. Benzbromarona y alopurinol, si la excreción renal de ácido úrico en 24 horas es menor de 700 mg.
4. Alopurinol.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Es evidente la necesidad del tratamiento de la hiperuricemia en este paciente ante la recurrencia habitual de episodios de artritis aguda. Una vez que la inflamación aguda remite, el tratamiento de la hiperuricemia debes plantearlo con alupurinol asociado a colchicina los 6-12 primeros meses.

¿Cuál de las siguientes afirmaciones que reflejan las características clínicas de la artritis reumatoide es correcta?:

1. La afectación de la columna lumbar es más frecuente que la cervical.
2. La afectación de las articulaciones interfalángicas distales es más frecuente que las proximales.

3. La artritis reumatoide es/más frecuente en los hombres en áreas rurales
4. Es una poliartritis de más de 6 semanas de duración.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Una pregunta ciertamente sencilla sobre las manifestaciones clínicas de la artritis reumatoide. Veamos opción por opción.

R1: La afectación de la columna cervical es más frecuente que la lumbar (al revés que en la espondilitis anquilosante). Recuerda que la subluxación atloaxoidea es típica de la artritis reumatoide.

R2: La afectación interfalángica es, característicamente, proximal. La afectación de las articulaciones metacarpofalángicas distales se afectan muy rara vez en esta enfermedad (sí que se alteran en la artropatía psoriásica, donde además suele haber onicopatía).

R3: La artritis reumatoide es más frecuente en mujeres.

R4: Aunque no recuerdes exactamente el número de semanas que debe persistir la artritis para considerarse criterio, sí sabes que la artritis reumatoide es una enfermedad crónica, por lo que la respuesta 4 no debería sorprenderte.

R5: La afectación oftalmológica típica de la artritis reumatoide no es la uveítis, sino el ojo seco (por el Sjögren secundario, la más frecuente), la episcleritis y la escleritis (rara, pero típica).

-----o-----

Chico de trece años que refiere episodios de dolor abdominal, no filiados, y artralgiar erráticas en codos, rodillas. codos y muñecas. En las últimas 24 horas le han aparecido manchas rojizas en muslos. Lo más destacado de la exploración física es la existencia de púrpura palpable en nalgas y muslos. No presenta anemia, las plaquetas son normales, la IgA está elevada y el aclaramiento de creatinina es normal. Se objetiva proteinuria de 1 gr/24 horas y 50-70 hematíes por campo. en la biopsia renal se observa proliferación mesangial y depósitos de IgA (+++) e IgG(+). El diagnóstico más probable es

1. Vasculitis tipo PAN microscópica.
2. Lupus eritematoso sistémico.
3. Enfermedad de Wegener.
4. Síndrome de Schönlein-Henoch.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Esta pregunta nos presenta un caso clínico típico de síndrome de Schonlein-Henoch o vasculitis IgA.

Nos hablan de un chico menor de 15 años, por artralgiar y dolor abdominal con lesiones en muslos, glúteos y miembros inferiores en general.

Además a nivel analítico nos hablan de hematuria y proteinuria con creatinina normal (GN leve) y nos hablan de elevación de IgA.

Por todos estos datos la opción correcta es la 4

-----O-----

El diagnóstico definitivo de amiloidosis, tras un alto índice de sospecha clínica, requiere la confirmación anatomopatológica del depósito de amiloide en los tejidos. La maniobra diagnóstica que actualmente se considera de elección por su alto rendimiento es:

1. La biopsia renal.
2. La biopsia hepática.
3. La biopsia cutánea.
4. La punción aspirativa de grasa abdominal.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Pregunta muy fácil. El diagnóstico específico de amiloidosis depende de la demostración de la presencia de depósitos de amiloide. Para ello, se requiere obtener una muestra tisular, siendo la más adecuada la aspiración de grasa subcutánea abdominal. Todas las muestras tisulares obtenidas deben teñirse con rojo Congo y examinarse bajo luz polarizada para observar la típica birrefringencia verde.

-----O-----

Una paciente de treinta años con LES presenta erupción malar, poliartralgias, derrame pleural bilateral y trombopenia intensa de 5.000 plaquetas por mm³. ¿Cuál es el tratamiento inicial de elección?:

1. AINEs a dosis altas.
2. Ciclofosfamida.
3. Prednisona 1 mg por Kg de peso y día.
4. Esplenectomía.

Resp. Correcta: 3

Comentario: En este paciente la manifestación clínica que requiere más atención para su tratamiento es la presencia de trombopenia severa que puede producir hemorragias graves que pueden comprometer la vida del paciente. La actitud terapéutica en la trombopenia en el lupus se puede esquematizar de la siguiente forma: - Por encima de 50.000 plaquetas: seguimiento clínico. - Entre 30.000 y 50.000 plaquetas: prednisona a dosis de 0,5 mg/kg/día. - Por de bajo de 30.000 plaquetas: prednisona a dosis de 1 mg/kg/día. Si en 2- 3 semanas no hay respuesta, añadir azatioprina. Si persiste la trombopenia se administraran inmunoglobulinas endovenosas y/o danazol. También puede ser necesaria la realización de esplenectomía.

-----O-----

En una paciente con artritis reumatoide establecida que presenta derrame pleural se realiza punción aspiración del líquido. Señale el hallazgo de laboratorio NO compatible con esta manifestación clínica:

1. Proteínas aumentadas.
2. Descenso de LDH.
3. Aumento de ADA.

4. Descenso de complemento.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La pleuritis es la manifestación cardiopulmonar más frecuente de la AR. Sin embargo, no es tan habitual ni tan evidente como en el LES. Las características del líquido pleural de la AR son, curiosamente, muy similares a las del derrame pleural tuberculoso. En ambos casos, se trata de un exudado y por lo tanto mostrará aumento de la LDH (superior al 50% del nivel plasmático) y aumento de las proteínas con celularidad variable, a menudo abundante y de predominio mononuclear. También comparten ambos derrames pleurales la disminución de la glucosa y los niveles elevados de ADA (adenosindeaminasa). Desde el punto de vista teórico, la diferencia radica en que los niveles de complemento en líquido pleural están disminuidos en la AR, a diferencia de la TBC. La utilidad de esta diferenciación no se planteará ante un paciente con derrame pleural y síntomas articulares, ya que estos últimos son muy distintos en ambas enfermedades: poliartritis simétrica de manos (AT) vs monoartritis crónica (TBC). El diagnóstico de certeza se realizará mediante el cultivo en medio de Lowenstein del líquido pleural. También es útil la biopsia pleural, que mostrará granulomas en el caso de la TBC.

-----o-----

Mujer de 70 años con antecedente de cáncer de mama hace diez años. Actualmente en tratamiento con zoledronato y en seguimiento por su oncólogo sin complicaciones hasta el momento actual. Se presenta en el Servicio de Urgencias de nuestro hospital porque presenta exposición mandibular sin otras complicaciones asociadas. Se decide realizar una prueba de imagen que ayude a esclarecer el diagnóstico. La TC mandibular evidencia una zona de esclerosis que coincide con la región de exposición mandibular. ¿Qué le parece CIERTO al respecto de su sospecha clínica?

1. Es muy posible que se encuentre en relación con el tratamiento con zoledronato.
2. Es una paciente con antecedentes oncológicos, así que la primera sospecha diagnóstica debería ir encaminada a descartar una metástasis.
3. Seguramente se trate de un flemón dentario subperióstico.
4. Es un efecto secundario habitual del tratamiento quimio y radioterápico al que se habrá sometido esta paciente.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Es muy importante que recuerdes la relación de los bifosfonatos con la osteonecrosis de los maxilares. Repasa estos conceptos, ya que esta pregunta puede considerarse como de dificultad moderada.

-----o-----

¿Cuál de las siguientes alteraciones radiológicas NO es propia de la artritis reumatoide?:

1. Osteoporosis en banda.
2. Esclerosis subcondral.
3. Disminución del espacio articular.
4. Subluxaciones.

Resp. Correcta: 2

Comentario: La lesión radiológica más típica y trascendente en la artritis reumatoide es la presencia de erosiones que sin duda es un marcador de la severidad de la enfermedad. De forma más precoz se puede apreciar disminución uniforme del espacio articular (a diferencia de lo que ocurre en los procesos degenerativos en los que la disminución es irregular), y osteoporosis yuxtarticular (osteoporosis en banda), que se considera, al igual que las erosiones, un criterio diagnóstico de la enfermedad. Todo ello puede provocar en fases avanzadas de la enfermedad la aparición de destrucciones articulares extensas. La esclerosis subcondral propia de procesos degenerativos como la artrosis no es típica de la AR.

-----O-----

En el tratamiento de un paciente con artritis reactiva, el paciente persiste con síntomas pese al cambio de AINEs a metotrexato. ¿Qué fármaco emplearía a continuación para el tratamiento de la enfermedad?

1. Micofenolato de mofetilo.
2. Dexametasona.
3. Hidroxicloroquina.
4. Infliximab.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

En casos refractarios, para el tratamiento de la artritis reactiva está indicado el empleo de antiTNF.

-----O-----

Un varón de 64 años asintomático presenta en la radiografía de la columna dorsal y lumbar intensa osificación de los ligamentos longitudinales anterior y posterior así como extensas excrescencias óseas de distribución irregular entre algunas vértebras, las sacroilíacas son normales. La exploración física no muestra limitaciones de la movilidad. Presenta HLA B27 negativo y factor reumatoide positivo a título bajo. El diagnóstico más verosímil en este paciente es:

1. Espondilitis anquilosante
2. Espondiloartrosis.
3. Espondilitis reumatoide.
4. Hiperostosis anquilosante vertebral difusa.

Resp. Correcta: 4

Comentario: La imagen característica que nos describen es propia de la hiperostosis anquilosante vertebral difusa, un proceso frecuentemente asintomático propio de varones de edad avanzada. La lesión radiológica típica de la Espondilitis anquilosante son los sindesmofitos, formaciones más "finas" uniformes y simétricas. En la espondiloartrosis la lesión radiológica son los osteofitos. Y en la enfermedad de Paget lo típico es la vertebra "en marco". En cuanto a la Artritis reumatoide no es propia de ella la afectación del esqueleto axial excepto a nivel de la columna cervical.

-----O-----

Mujer de 55 años que desde hace un año presenta, de forma asociada al frío, episodios

de palidez en los dedos y enrojecimiento posterior junto con artralgiás de manos. También nos comenta tos seca, disnea y crepitantes en bases pulmonares. Respecto al cuadro clínico de la paciente, es FALSO que:

1. Los bloqueantes del calcio son eficaces en el tratamiento de esta entidad.
2. Los bloqueantes beta son eficaces para mejorar la sintomatología periférica que padece la paciente.
3. El fenómeno de Raynaud es la manifestación inicial más frecuente en estas entidades.
4. Las pruebas de función respiratoria son compatibles con las que podríamos encontrar en una enfermedad intersticial pulmonar.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Nos presentan un caso clínico típico de esclerodermia y debemos conocer los principios básicos del tratamiento de esta enfermedad y principalmente debes saber que no hay que utilizar los betabloqueantes, ya que están contraindicados en el fenómeno de Raynaud.

-----O-----

Paciente de 60 años, sin historia de artritis previa, que acude por la aparición de proliferación ósea y engrosamiento de las articulaciones interfalángicas distales con escasos signos inflamatorios, lo que nos hace sospechar:

1. Artrosis con nódulos de Heberden.
2. Artrosis con nódulos de Bouchard.
3. Artritis reumatoide con nódulos subcutáneos.
4. Gota crónica con presencia de tofos.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Veamos las opciones de respuesta:

- 1.- La ausencia de inflamación junto con proliferación ósea hace muy probable una artrosis. Los nódulos de Heberden aparecen en las articulaciones distales (respuesta 1 correcta).
- 2.- Los nódulos de Bouchard aparecen en las articulaciones interfalángicas proximales.
- 3.- Si nos hablan de escasos signos inflamatorios, difícilmente será una artritis reumatoide.
- 4.- No parece una localización muy frecuente para unos tofos gotosos. También va en contra la ausencia de artritis previa.

-----O-----

El síndrome de Lesch-Nyhan NO incluye:

1. Hiperuricemia.
2. Déficit de xantina-oxidasa.
3. Coreoatetosis.
4. Cálculos de ácido úrico.

Resp. Correcta: 2

Comentario: El síndrome de Lesh- Nyhan está ligado al cromosoma X y se produce por un déficit completo de hipoxantina fosforribosiltransferasa (HPRT). Los pacientes que presentan este síndrome tienen hiperuricemia, hiperaciduria, cálculos de ácido úrico y gota, como consecuencia de la sobre producción de urato. Igualmente se observa en ellos distintos síndromes neurológicos como automutilaciones o coreoatetosis. Como puedes observar dentro de las respuestas que te dan todas son correctas excepto el déficit enzimático que produce la enfermedad. Igualmente debes recordar que el déficit parcial de HPRT produce el síndrome de Kelley- Seegmiller.

-----O-----

Paciente con miopatía inflamatoria con anticuerpos anti-MDA5. Señale el hallazgo MENOS esperable:

1. Debilidad proximal en miembros.
2. Lesiones cutáneas en manos.
3. Neumopatía intersticial rápidamente progresiva.
4. Estudio de malignidad negativo.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Los anti-MDA5 se asocian a formas de dermatomiositis amiotópica, es decir, sin clínica muscular (marcamos la opción de respuesta 1) con neumopatía intersticial agresiva que condiciona el pronóstico; sin embargo, el riesgo de neoplasia asociada no parece estar incrementado.

-----O-----

Respecto a la afectación cutánea del LES, señale la afirmación FALSA:

1. La alopecia que se produce durante las exacerbaciones de la enfermedad suele ser transitoria.
2. Las lesiones del lupus eritematoso cutáneo subagudo curan dejando extensas cicatrices.
3. En el lupus cutáneo agudo, la inmunofluorescencia es positiva tanto en la piel lesionada como en la sana.
4. Los pacientes afectados de un lupus cutáneo crónico no suelen desarrollar la forma sistémica de la enfermedad.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

En el LES, distinguimos lesiones cutáneas agudas, subagudas y crónicas.

Dentro de las lesiones agudas, la más característica de ellas es el eritema facial en alas de mariposa o eritema en vespertilio (respuesta 1 correcta).

La alopecia es una manifestación inespecífica de la enfermedad, y puede relacionarse con la actividad de la enfermedad, siendo en ésta situación transitoria (respuesta 2 correcta). Sin embargo, si aparece por lesión cicatricial de un lupus discoide sí será una alopecia definitiva.

Cuando un paciente tiene lesiones agudas, tanto la biopsia de la piel lesionada como no lesionada suele tener depósito de inmunoglobulinas y complemento en la unión dermoepidérmica. A esta prueba se denomina test de la banda lúpica. (Respuesta 4 correcta)

Sólo el 5% de los pacientes con lupus discoide no llegan a desarrollar manifestaciones de lupus eritematoso sistémico (respuesta 5 correcta)

Así pues, la respuesta incorrecta es la 3, pues la única lesión que deja lesiones cicatriciales es el lupus discoide o crónico.

-----o-----

¿Cuál de los siguientes NO se considera criterio diagnóstico del síndrome de Behçet?:

1. Ulceraciones genitales recurrentes.
2. Uveítis.
3. Meningitis.
4. paniculitis

Resp. Correcta: 3

Comentario: Para realizar el diagnóstico de enfermedad de Behçet se precisa, como requisito indispensable, la existencia de aftas orales recidivantes, además de dos de entre los siguientes: aftas genitales recidivantes, lesiones cutáneas como eritema nodoso, pseudofoliculitis lesiones papulopustulares o lesiones acneiformes, lesiones oculares como uveítis anterior, posterior o células en el vítreo, y test de patergia positivo a las 24 o 48 horas. Recuerda que aunque no sean criterios diagnósticos, la enfermedad también puede afectar al tubo digestivo, las articulaciones, el sistema nervioso central o provocar trombosis venosas.

-----o-----

Gustavo acude a urgencias con lesiones cutáneas y malestar general de varios días de evolución. Tiene lesiones psoriasiformes en tronco con afectación de palmas y plantas. También presenta una inflamación articular asimétrica no supurativa y enrojecimiento ocular bilateral, así como erosiones en glande. En la anamnesis posterior, Gustavo reconoce un contacto sexual de riesgo 20 días antes. ¿Cuál es su diagnóstico?

1. Infección por VIH.
2. Sífilis secundaria.
3. Síndrome de Reiter.
4. Eritema multiforme.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Pregunta de dificultad moderada pues requiere la integración de conocimientos Reuma-Derma. La forma más fácil de acertar la pregunta es teniendo claro el concepto de “artritis reactiva” o, lo que es lo mismo, una artritis producida por diversos factores desencadenantes, ya sea una infección gastro-intestinal, genito-urinaria o venérea, en cuyo caso se suele denominar preferiblemente síndrome de Reiter (respuesta correcta: 3). La tríada clásica del síndrome de Reiter es uretritis, conjuntivitis (bilateral) y artritis (tipo espondiloartropatía seronegativa), pero también puede presentar entesitis, sacroileitis, uveítis, y diversas lesiones mucocutáneas. Las manifestaciones dermatológicas más típicas incluyen: la queratodermia blenorragica (lesiones psoriasiformes a nivel palmo-plantar) y la balanitis circinada en forma de placas anulares en glande. En cuanto al resto de opciones: - De tratarse de una enfermedad relacionada con la infección por el VIH, cronológicamente estaríamos ante un caso de primoinfección (“Gustavo reconoce contacto sexual de riesgo 20 días antes”), que clínicamente suele manifestarse en forma de síndrome mononucleósido (exantema, adenopatías, hepato-esplenomegalia) (respuesta 1: falsa). - Dado que la sífilis está dentro del diagnóstico diferencial de exantemas con afectación palmoplantar, nos cuentan un contacto sexual de riesgo, y clínicamente es la “Gran Imitadora” por excelencia, es lógico que hayas dudado con la

respuesta 2. Aunque la artritis no sea un hallazgo típico de sífilis, sin duda, el resto del cuadro clínico descrito podría ser compatible con un secundarismo luético. No obstante, falla la cronología: 3 semanas de incubación hubieran sido suficientes para desarrollar un chancro luético (fase de primoinfección sífilis) pero no un secundarismo (tiempo medio de 6 semanas a 3 meses, respuesta 2: falsa). - El eritema multiforme no se caracteriza por manifestarse mediante artritis (respuesta 4: falsa). Debes asociar eritema multiforme menor a lesiones violáceas dianiformes en zonas acras tras infección vírica (frecuentemente, pero no exclusivamente, herpética; el molusco contagioso es una causa relativamente frecuente de EM); y eritema multiforme mayor o SJJ a lesiones dianiformes más extensas con importante mucositis erosiva asociada tras antecedente de fármaco o neumonía por mycoplasma en niños.

-----o-----

¿Cuál de los siguientes fármacos suele emplearse en casos refractarios de enfermedad de Still del adulto?

1. Infliximab.
2. Etanercept.
3. Adalimumab.
4. Anakinra.

Resp. Correcta: 4

Comentario: En casos de enfermedad de Still del adulto refractarios a inmunosupresores convencionales anakinra y tocilizumab parecen especialmente útiles.

-----o-----

Una de las siguientes características anatomopatológicas no es propia de la panarteritis nodosa clásica

1. Afectación de capilares y vénulas
2. Marcada necrosis fibrinoide
3. Afectación parcheada predominantemente en las zonas de bifurcación arterial
4. Presencia en la pared vascular de inmunocomplejos circulantes

Resp. Correcta: 1

Comentario: En esta pregunta teórica debes conocer los aspectos anatomopatológicos más típicos de esta enfermedad.

Sabemos que la panarteritis nodosa clásica es una vasculitis necrotizante y de mediano calibre por lo tanto la opción uno afectación de capilares y vénulas debe ser falsa

-----o-----

En cuál de los siguientes huesos la incidencia de osteoporosis es mayor:

1. Vértebras.
2. Fémur.
3. Húmero.
4. Falanges proximales.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Esta pregunta se refiere a una de las cuestiones que son importantes en el capítulo de la osteoporosis, además de los factores predisponentes, la analítica y cuándo tratarla. La osteoporosis afecta al hueso trabecular, es decir, de epífisis y huesos planos (esponjoso), siendo por ello la localización más frecuente la COLUMNA VERTEBRAL, en especial la zona dorsal baja y sobre todo lumbar, pudiendo dar acúñamiento del cuerpo vertebral por fracturas. En la osteoporosis de mujeres postmenopáusicas además es típica la fractura radial (de Colles); y en la osteoporosis senil además se suelen producir fracturas de cuello femoral o de húmero proximal. Pero la nº 1 es siempre la VERTEBRAL.

-----o-----

Dada su asociación clínica, la polimialgia reumática comparte presumiblemente etiopatogenia con:

1. Vasculitis ANCA positivas.
2. Arteritis de la temporal.
3. Enfermedad de Kawasaki.
4. Artritis reumatoide.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La polimialgia reumática, consistente en dolor y rigidez en cinturas escapular y pelviana con aumento de VSG y PCR con CPK normal en mayores de 50 años, presenta asociación significativa con la arteritis de la temporal (respuesta 2 correcta). De hecho, en pacientes con síntomas de arteritis de la temporal son frecuentes también síntomas de polimialgia reumática. En un paciente que cumple criterios de polimialgia reumática deberemos preguntar por síntomas de arteritis de la temporal, pues modificará la actitud terapéutica, especialmente la afectación visual.

-----o-----

En un líquido articular infeccioso, ¿qué esperaríamos encontrar en cuanto a glucosa, proteínas y viscosidad?:

1. Glucosa y proteínas normales y viscosidad alta.
2. Glucosa N, proteínas elevadas y viscosidad baja.
3. Glucosa baja, proteínas elevadas y viscosidad baja.
4. Glucosa baja, proteínas normales y viscosidad alta.

Resp. Correcta: 3

Comentario: En el líquido no inflamatorio encontrarás una celularidad normal (< 3000 células), una viscosidad alta (propia del líquido normal) y unas proteínas y glucosa normales (proteínas en torno a 1-2 g/dl y glucosa aprox. un 10% menor que la plasmática). En un líquido inflamatorio la celularidad estará elevada (3000- 50.000), la glucosa disminuida o normal, las proteínas algo aumentadas (2- 4 g/ dl) y la viscosidad algo disminuida. En un líquido infeccioso la celularidad está muy elevada generalmente (> 50.000 células con predominio de PMN), la glucosa muy disminuida (aprox. < 50% de la glucemia), las proteínas muy elevadas (4- 6 g/ dl) y la viscosidad muy disminuida.

-----o-----

Varón de 30 años que, desde hace cinco meses, presenta un dolor a nivel de la baja espalda y glúteos, que es más acentuado a primera hora de la mañana, tardando unos

30 minutos en recuperarse de la rigidez que ello le produce, aunque si realiza sus ejercicios de estiramiento, mejora algo más rápido. Dado que su padre tiene diagnosticada una espondilitis anquilosante (EA), usted decide realizar una radiografía anteroposterior de pelvis para descartar la presencia de sacroileítis radiológica, con resultado positivo para la misma. Señale cuál de las siguientes afirmaciones le parece MÁS acertada:

1. El paciente se beneficiará de la utilización de corticoides vía oral inicialmente en dosis de 1 mg/kg/día hasta la mejoría de la sacroileítis radiológica.
2. Además de la sacroileítis, es frecuente encontrar hiperostosis lumbar, dando lugar al típico signo en “cera derretida” de la EA.
3. Además de medidas posturales y rehabilitadoras, así como el empleo de AINEs para controlar el dolor, habrá que instruir al paciente en el autodiagnóstico de una posible uveítis aguda en función de la clínica, acudiendo de inmediato al oftalmólogo en caso de sospecha.
4. Los anti-TNF tipo adalimumab no han mostrado ningún beneficio respecto a los AINEs en el tratamiento de la EA.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La hiperostosis en “cera derretida” es un signo típico de la enfermedad de Forestier, que aparece en personas de más edad que la EA y no presenta entesitis, ni positividad para HLA-B27. En cuanto al tratamiento de la EA, en fases iniciales puede controlarse con AINEs y tratamiento rehabilitador, siendo eficaces la sulfasalacina o metotrexate en la afectación extraaxial, pero no en la axial. Es importante que el paciente conozca las posibles complicaciones de su enfermedad y sepa reconocerlas a tiempo para evitar la aparición de secuelas por tratamientos tardíos y aprender a reconocer un episodio de uveítis anterior aguda, dada la rapidez de evolución de la misma en estos pacientes, y el riesgo que ello entraña (respuesta 3 correcta). Los corticoides por vía sistémica prácticamente no están indicados en ningún caso y menos a dosis tan elevadas. Los anti-TNF han demostrado ser fármacos útiles en el control de la clínica y en la evolución de la enfermedad pero, dado su alto coste y sus posibles efectos adversos, se reservan para casos más avanzados.

-----O-----

Un varón de treinta años consulta por secreción uretral, artritis de muñeca derecha y rodilla izquierda, dolor en ambos talones y lesiones vesiculosas hiperqueratósicas y costrosas en palmas y plantas. Los cultivos del líquido sinovial son negativos. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?:

1. Gonococemia diseminada.
2. Artritis reactiva.
3. Síndrome de Behçet.
4. Espondilitis anquilopoyética.

Resp. Correcta: 2

Comentario: La asociación de síntomas genitourinarios y articulares debe plantearnos el diagnóstico de enfermedad gonocócica diseminada y de artritis reactiva. En el caso que nos presentan hay varios rasgos que nos deben inclinar a la segunda posibilidad. La presencia de talalgia (debida a la entesitis del calcáneo), la presencia de lesiones cutáneas hiperqueratósicas (queratodermia blenorragica) y el líquido sinovial estéril son hallazgos propios de la artritis reactiva. En la gonococia diseminada las lesiones cutáneas (que no son palmoplantares) suelen ser pústulas, el paciente suele presentar fiebre elevada y es más frecuente en mujeres. La afectación articular suele ser una artritis migratoria más que una oligoartritis asimétrica como en

este caso.

-----O-----

¿Cuál de las siguientes vasculitis afecta TÍPICAMENTE a vasos de gran calibre?

1. Vasculitis de Churg-Strauss.
2. Panarteritis nodosa.
3. Púrpura de Schönlein-Henoch.
4. Enfermedad de Horton.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La clasificación más empleada para las vasculitis atiende al tamaño de los vasos a los que afecta. Las vasculitis que afectan a vasos de gran calibre son la arteritis de Takayasu y la arteritis de células gigantes (arteritis de la temporal o enfermedad de Horton) (respuesta 4 correcta).

-----O-----

Una mujer de 40 años es intervenida quirúrgicamente, realizándose una derivación yeyuno-cólica. A las pocas semanas desarrolla un síndrome de Raynaud, así como una erupción urticariforme, acompañados de dolor espontáneo e hipersensibilidad en rodillas, muñecas y tobillos, y tenosinovitis. FR y ANA son negativos. En relación con este caso clínico, señale la afirmación verdadera:

1. El Ag HLA B27 es previsiblemente +.
2. La patogenia responsable es por mecanismo inmune tipo I (hipersensibilidad inmediata).
3. La tetraciclina supone un tratamiento bastante eficaz.
4. Conviene realizar una minuciosa exploración neurológica para descartar las frecuentes complicaciones del SNC en este cuadro.

Resp. Correcta: 3

Comentario: En pacientes que se han sometido a cirugía de derivación intestinal se puede observar la aparición de artritis. Esta se produce desde semanas hasta años después de la intervención quirúrgica. Los pacientes suelen presentar poliartalgias, tenosinovitis o incluso artritis, y suelen presentar lesiones cutáneas en forma de una erupción urticariforme. No se encuentra asociación con el HLA B27 ni aparecen factor reumatoide o anticuerpos antinucleares. El mecanismo se supone que guarda relación con la proliferación bacteriana en las asas ciegas. Este estímulo antigénico provocaría la formación de inmunocomplejos que finalmente se depositan en el tejido sinovial dando lugar a los síntomas. Como tratamiento sintomático son útiles los AINEs y los corticoides, pero es más útil el tratamiento antibiótico del sobrecrecimiento bacteriano con tetraciclina. La reanastomosis intestinal o la resección del asa ciega todavía ofrece mejores resultados.

-----O-----

Acude a su consulta una mujer de 57 años, que presenta en ambas manos dolor e inflamación de varias semanas de evolución. Aporta una analítica solicitada por su médico de atención primaria en la que destaca PCR de 17, ANA negativos, anticuerpos antipeptido cíclico citrulinados negativos y antifosfolípidos negativos. En consulta procedes a la exploración física de la paciente destacando signos de artritis franca en

ambas manos, concretamente en la 3ª interfalángica proximal y 4ª interfalángica distal de la mano derecha junto con la 2ª y 3ª interfalángica proximal de la mano izquierda. También destaca a la exploración unas lesiones cutáneas en ambos codos de aspecto blanquecino. Ante esta situación clínica, usted, ¿que patología sospecha y que pruebas solicitaría?

1. Artritis psoriásica y realizaría radiología simple de las articulaciones afectas
2. Artritis reumatoidea y realizaría radiología simple de manos y región cervical ante la posibilidad de subluxación atloaxoidea.
3. Artritis reactiva, solicitaría serologías de yersinia y campilobacter
4. Impresiona de artrosis, realizaría una artocentesis para asegurar que no sea una artritis séptica.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Se trata de un caso claro de artritis psoriasisica (afectación poliarticular de manos, que afecta a la IFD), el resto de la autoinmunidad es negativa, aspecto que apoya aún más nuestra sospecha.

Respecto a las pruebas complementarias, lo razonable sería pedir una radiología simple con idea de valorar las erosiones articulares que podrían aparecer en esta patología

-----o-----
¿Cuál de los siguientes hallazgos es MENOS sugestivo de enfermedad relacionada con IgG4?

1. Fibrosis retroperitoneal periaórtica.
2. Colangitis esclerosante.
3. Hipodensidades corticales renales bilaterales.
4. Tumefacción unilateral de parótida.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La enfermedad relacionada con IgG4 es una enfermedad sistémica, normalmente multiorgánica. Por tanto, afecta de forma bilateral y simétrica en los órganos pares, como las glándulas salivales, los pulmones o los riñones (marcamos la opción de respuesta 4). Las lesiones típicas de esta enfermedad consisten en masas pseudotumorales con excepción de la colangitis esclerosante (estenosis de la vía biliar), por lo que si la lesión es unilateral siempre pensaremos en una patología local, a descartar en primer lugar neoplasia.

-----o-----
Mujer de 60 años que en los últimos tres meses presenta episodios de dolor en los dedos de las manos con cambios de coloración cuando se expone al frío. El resto de la anamnesis es anodino, al igual que la exploración física. Usted tiene claro que esta paciente debe ser estudiada porque el fenómeno que presenta, de iniciarse en edad adulta, se relaciona de forma SIGNIFICATIVA con:

1. Sarcoidosis.
2. Síndrome de Sjögren.
3. Lupus eritematoso sistémico.

4. Esclerosis sistémica.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Pregunta sencilla. El fenómeno Raynaud es el dato más precoz, frecuente y característico de la esclerosis sistémica (respuesta 4 correcta). Ante cualquier fenómeno de Raynaud de inicio en edad adulta debe realizarse capilaroscopia y determinación de autoanticuerpos para valorar el riesgo de progresión y la necesidad de seguimiento.

-----O-----

Si en un enfermo se hallan anticuerpos anti-Ro es probable que tenga:

1. Un síndrome antifosfolípido primario con anemia hemolítica.
2. Una artritis reumatoide con trombocitopenia.
3. Un lupus cutáneo subagudo.
4. Una esclerodermia con acusado fenómeno de Raynaud.

Resp. Correcta: 3

Comentario: La presencia de anticuerpos antiRo se relaciona con distintas situaciones en el lupus eritematoso sistémico. La asociación más evidente es con el lupus cutáneo subagudo. También tienen relación con el lupus del anciano (es decir los paciente ancianos que desarrollan lupus eritematoso tienen con alta frecuencia anticuerpos antiRo), con el lupus con anticuerpos antinucleares negativos (el 2% de los pacientes con LES tienen AAN negativos; sin embargo en la mayoría de ellos se detectan antiRo que no se ven con la inmunofluorescencia para la detección de AAN). Otra situación que se asocia a los antiRo es el lupus neonatal. En una mujer embarazada que tenga antiRo estos pueden pasar de la madre al feto durante la gestación y producir en el neonato lesiones cutáneas y más raramente bloqueo cardíaco congénito. La presencia de antiRo sin antiLa aumenta el riesgo de nefritis lúpica. Sin embargo, cuando aparecen asociados el riesgo de nefritis disminuye.

-----O-----

Varón de 50 años, en tratamiento con difenilhidantoína desde hace 20 años, que consulta por dolor crónico en ambos muslos. En la analítica destacan calcio y fósforo disminuidos y fosfatasa alcalina elevada. En la radiografía de fémur se observan "zonas de Looser-Milkman". ¿Cuál es la causa MÁS probable de sus alteraciones?

1. Malabsorción intestinal.
2. Uso crónico de difenilhidantoína.
3. Osteoporosis.
4. Hiperparatiroidismo.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Pregunta en forma de caso clínico que nos describe una osteomalacia. Analicemos la pregunta en profundidad. Nos dan dos datos típicos que nos deben ayudar a reconocer la patología del paciente, como son el dolor óseo crónico, sordo y difuso, más intenso a nivel proximal; pero lo realmente característico son las pseudofracturas de Looser-Milkman en la radiografía, que son bandas radiotransparentes que cruzan de forma perpendicular la cortical. La alteración analítica de este paciente se justifica porque está tomando de

forma crónica anticonvulsivantes (fenitoína), que interfiere en el metabolismo hepático de la vitamina D, necesario para la función de esta (calcio disminuido). Como consecuencia se produce un hiperparatiroidismo secundario para compensar el déficit, lo que aumenta las pérdidas de fósforo por el riñón y aumenta la resorción ósea, lo que eleva la fosfatasa alcalina (respuesta 2 correcta). Por tanto, dentro de las situaciones y enfermedades que se acompañan de osteomalacia, conviene dividir las en dos tipos:

1) Déficit de vitamina D, ya sea por aporte extrínseco insuficiente o por alteración de su metabolismo, lo que va a acompañarse de un hiperparatiroidismo secundario.

2) Hipofosforemia, ya sea por aporte insuficiente (por ejemplo, antiácidos) o pérdidas excesivas (por ejemplo, síndrome de Fanconi), que no se acompaña del hiperparatiroidismo secundario.

Por otra parte, debemos tener en cuenta algo que nos puede servir para todas las preguntas de tipo caso clínico: cuando nos dan algún dato, como la ingesta de algún fármaco, no es de forma gratuita. Siempre debes pensar por qué nos lo han dado.

-----o-----

En la artritis reumatoide, el antígeno de histocompatibilidad DR4 se relaciona con la presencia de:

1. Anticuerpos antinucleares.
2. Erosiones óseas.
3. Proteinuria.
4. Nódulos pulmonares.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Existe una predisposición genética a padecer artritis reumatoide, como lo demuestra la presencia de ciertos haplotipos HLA con mayor frecuencia que en la población general: El 70% de los pacientes con AR presentan el haplotipo HLA DR4, mientras que en la población general solo aparece en el 30%. También se asocia, aunque en menor medida, al HLA DR1.

Además, algunos subtipos del HLA DR4 se asocian a su vez con enfermedad más erosiva (DRB1*0401 y DRB1*0404).

-----o-----

¿En cuál de las formas de artritis crónica juvenil es más frecuente el desarrollo de amiloidosis?

1. Sistémica.
2. Oligoarticular ANA positivo.
3. Oligoarticular HLA B27 positivo.
4. Poliarticular FR positivo.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Las dos formas de ACJ que muestran tendencia a evolucionar a amiloidosis son la forma de comienzo sistémico y la forma de comienzo poliarticular seropositiva (que de hecho es el equivalente a la AR del

adulto por debajo de los 16 años). Esto se debe a que, en ellas, es donde aparece inflamación de forma más intensa y persistente. En la forma de comienzo sistémico, la presencia de proteinuria debe hacernos pensar en el desarrollo de una amiloidosis, complicación que aparece en el 5% de los casos y que entraña un empeoramiento del pronóstico.

-----O-----

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es CORRECTA en relación al tratamiento con un anti-TNF?

1. No se puede utilizar en combinación con Metotrexato.
2. No se puede utilizar en combinación con corticoides.
3. Se puede utilizar en cardiopatía isquémica.
4. Se puede utilizar en enfermedad desmielinizante.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La principal toxicidad derivada del empleo de anti-TNF es la aparición de infecciones, sobre todo TBC o hepatitis, pero también puede provocar empeoramiento de insuficiencia cardíaca (por lo que está contraindicado en insuficiencia cardíaca grave o moderada, pero no en cardiopatía isquémica específicamente). Además, se han descrito casos de enfermedad desmielinizante o de lupus inducido. También está contraindicado su uso en pacientes con antecedente tumoral reciente o linfomas. Su uso combinado con FAMEs suele mejorar la efectividad o evitar la pérdida de eficacia. Puede usarse asociado a contricones o a AINEs si el paciente lo precisa.

-----O-----

Varón de 25 años, diagnosticado de enfermedad de Crohn, que refiere dolor lumbar bilateral que empeora con el reposo y rigidez matutina. En la exploración destaca una limitación de la movilidad, así como dolor a la palpación en ambas sacroilíacas, y en la radiografía se observa un estrechamiento del espacio articular con esclerosis y algunas erosiones. Con respecto a la complicación que presenta este paciente, señale la afirmación CORRECTA:

1. Es muy infrecuente, afectando a menos del 5% de los pacientes.
2. Puede preceder a los síntomas gastrointestinales.
3. A diferencia de la espondilitis anquilopoyética, no hay asociación con el HLA-B27.
4. Su evolución está estrechamente ligada al curso clínico de la enfermedad intestinal.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Caso clínico que permite repasar la espondilitis/sacroileítis asociada a enfermedad inflamatoria intestinal. Puede preceder a los síntomas gastrointestinales (respuesta 2 correcta) De las demás opciones de respuesta podemos decir que:

- 1.- No es una manifestación muy infrecuente (afecta aproximadamente al 9- 15% de los pacientes con EII).
- 3.- En caso de afectación axial existe una asociación con el HLA-B27 entre 50- 75% (a diferencia de las formas periféricas, que no se relacionan con el HLA-B27).

4.- El curso clínico de la enfermedad no se asocia de forma tan estrecha como en la artritis periférica a los síntomas gastrointestinales.

-----O-----

Señale la afirmación INCORRECTA sobre la amiloidosis:

1. En el riñón, el glomérulo es la estructura que se afecta principalmente.
2. La hipertensión es poco frecuente, excepto en la amiloidosis crónica.
3. La infiltración de la lengua es característica de la amiloidosis secundaria.
4. La amiloidosis cardíaca es frecuente en la forma primaria.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Es una pregunta un tanto difícil, pero que te ayudará a memorizar algunos datos de este rentable tema. El riñón es el órgano más afectado, y se debe al depósito glomerular de amiloide, generando escape de proteínas y síndrome nefrótico (y por último, insuficiencia renal). Es la primera causa de muerte en la amiloidosis secundaria; la amiloidosis cardíaca es la principal causa de muerte en la forma primaria (miocardiopatía restrictiva con arritmias, bloqueos,?). El hígado se puede afectar, pero no suele ser grave, tan sólo se manifiesta por elevación de la FALc y la GGT con hepatoesplenomegalia. La macroglosia aparece sobre todo en la amiloidosis primaria, por lo que la respuesta 4 es falsa. Es típica así mismo la presencia de Petequias perioculares, el síndrome del túnel carpiano, la infiltración articular con "hombros de rugby", las pápulas céricas, la diarrea y la neuropatía.

-----O-----

Mujer de 24 años, con episodios de dolor en miembros superiores, que presenta asimetría de pulsos a la exploración. En la analítica presenta importante elevación de parámetros inflamatorios. ¿Qué patología sospecharía en primer lugar?

1. Enfermedad de Kawasaki.
2. Arteritis de Takayasu.
3. Enfermedad de Behçet.
4. Enfermedad de Horton.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Caso clínico básico que debes reconocer de la arteritis de Takayasu (respuesta 2 correcta). No debe generarte ningún tipo de dificultad este tipo de casos.

-----O-----

Mujer de 31 años, diagnosticada de LES hace 6 años, presentando durante este tiempo, como síntomas fundamentales, rash, artritis y ocasionalmente fiebre. Inicialmente tuvo proteinuria moderada, que está ausente desde hace 4 años. La paciente está embarazada de 16 semanas, y mantiene el tratamiento que recibía antes de la gestación, hidroxicloroquina 200 mg al día, fundamentalmente para el control de los síntomas articulares. En la exploración física tiene una TA de 100/60, con un adecuado crecimiento del feto. Analítica: hemoglobina 11,2 g/dl, leucocitos 3.600/mm³, plaquetas 175.000/mm³, tiempo de tromboplastina parcial activado (TTPA) 42 segundos (control

26 segundos), anticuerpos anticardiolipina IgG positivos e IgM negativos, creatinina 0,6 mg/dl, C3 normal y C4 descendido, proteinuria de 0,3 g/24 horas. Anticuerpos anti-Ro positivos con anti-La y anti-RNP negativos. Los anti-ADNds son positivos, en títulos bajos. Señale a continuación la respuesta INCORRECTA:

1. La utilización de aspirina y heparina de bajo peso molecular está justificada en este caso si ha habido pérdidas fetales previas.
2. La utilización de prednisona es segura durante la gestación.
3. El neonato tiene altas probabilidades de tener bloqueo cardíaco congénito.
4. La utilización de ciclofosfamida se contraindica durante la gestación.

Resp. Correcta: 3

Comentario: El comentario de esta pregunta se realiza en vídeo.

-----o-----

Mujer de 26 años que consulta por sensación de debilidad generalizada que se ha instaurado progresivamente en el curso de tres semanas, haciéndose especialmente intensa en los últimos dos días. Refiere desde hace un par de años episodios de dolor articular en las manos que han precisado de la toma de antiinflamatorios, así como la aparición de alguna lesión eritematosa de causa no aclarada en la zona del escote, principalmente en verano. En la exploración física destacan únicamente una palidez cutaneomucosa evidente y una frecuencia cardíaca de 100 lpm. En el hemograma destacan: Hb 6 g/dL, hematocrito 27%, VCM 105 fL, 3.420 leucocitos/mm³ (2.300 neutrófilos/mm³, 800 linfocitos/mm³, 250 monocitos/mm³, 50 eosinófilos/mm³, 20 basófilos/mm³), plaquetas 170.000/mm³. En la bioquímica: AST 30 UI/L, ALT 35 UI/L, GGT 59 UI/L, fosfatasa alcalina 105 UI/L, LDH 490 UI/L, urea 20 mg/dL, creatinina 0,8 mg/dL. Teniendo en cuenta la información disponible, indique cuál de los siguientes parámetros analíticos adicionales necesitaría conocer para poder tomar la decisión inmediata MÁS apropiada:

1. Vitamina B12.
2. Anticuerpos antinucleares.
3. Test de Coombs directo.
4. Anticuerpos anti-DNA.

Resp. Correcta: 3

Comentario: El caso clínico de la pregunta describe un síndrome anémico de reciente aparición en una paciente con síntomas de 2 años de evolución que sugieren un probable lupus eritematoso sistémico (LES). La analítica aportada objetiva la presencia de anemia macrocítica con LDH elevada, sugestivo de anemia hemolítica en el contexto descrito, así como leucopenia y linfopenia, esperables en una paciente con LES. La decisión inmediata más apropiada es confirmar el origen autoinmune de la anemia hemolítica que padece la paciente, de cara a poder indicar el inicio de tratamiento con corticoides en caso de confirmarse anemia hemolítica autoinmune. Para poder confirmar el origen autoinmune de la anemia hemolítica, es necesario realizar un test de Coombs (respuesta 3 correcta). La realización de ANAs o anticuerpos anti-DNA apoyaría la sospecha diagnóstica de LES, pero confirmar este diagnóstico no es la decisión inmediata más apropiada que requiere esta paciente. Respecto a la vitamina B12, el contexto descrito sugiere anemia hemolítica, no anemia megaloblástica.

-----O-----
¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas es más característica de la artritis reumatoide?

1. Dolor típicamente con el movimiento, que mejora en reposo.
2. Dolor en reposo sin presentar prácticamente signos flogóticos en las articulaciones.
3. Dolor continuo, que se exacerba en actividad, con signos inflamatorios.
4. Dolor continuo, que se exacerba en reposo, con signos inflamatorios.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La clínica habitual de la AR suele comenzar con dolor de ritmo inflamatorio que se exacerba con el reposo e inflamación articular (con derrame y/o hipertrofia sinovial) en las articulaciones afectadas.

-----O-----
Una mujer de 84 años acude a nuestra consulta por dolor crónico en la zona media de la columna vertebral torácica, que aumenta al sentarse y al levantarse. A la exploración se detecta una marcada cifosis y contractura de la musculatura paravertebral. ¿Cuál es la causa MÁS probable del dolor?

1. Aneurisma abdominal con erosión vertebral acompañante.
2. Estenosis de canal lumbar.
3. Osteoporosis con aplastamiento vertebral.
4. Enfermedad de Paget.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Se trata de un caso típico de osteoporosis; mujer de edad avanzada que presenta dolor a nivel lumbar (región de mayor carga) y de forma asociada presenta cifosis, que muy probablemente se encontrará en relación con acúñamientos vertebrales asociados a fracturas a dicho nivel (respuesta 3 correcta).

-----O-----
Con respecto al tratamiento de la artritis reumatoide, es FALSO que:

1. Es altamente recomendable realizar ejercicio diario para mantener la morbilidad articular y evitar la atrofia muscular.
2. Los antiinflamatorios no esteroideos son útiles para el control de los síntomas sin embargo Su uso está más limitado por los efectos secundarios, por ello se emplean también los antiinflamatorios selectivos de la COX-2 aunque su uso está limitado por su toxicidad renal.
3. En el tratamiento farmacológico y la piedra angular son los FAME siendo de ellos el más empleado el metotrexato.
4. Los corticoides constituyen un tratamiento muy efectivo, aunque está limitado debido a la aparición de efectos secundarios.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Pregunta relativamente sencilla sobre el tratamiento y manejo de la artritis reumatoide. Debes saber que los AINEs, selectivos o no de la COX-2, no son el tratamiento de entrada en estos pacientes (opción 2 falsa, por lo que la marcamos).

-----O-----

Un hombre de 41 años acude a Urgencias por cuadro de tres días de evolución de tumefacción y dolor en la rodilla derecha, con impotencia funcional y febrícula. Dos semanas antes había tenido un cuadro de diarrea autolimitada. En la exploración existe derrame articular, por lo que se procede a realizar una artrocentesis y se obtienen 50 cc de líquido de color turbio, con viscosidad disminuida y los siguientes parámetros analíticos: leucocitos 40.000/mcL (85% de neutrófilos), glucosa 40 mg/dL, ausencia de cristales, tinción de Gram: no se observan microorganismos. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre este paciente es INCORRECTA?

1. Se debe iniciar tratamiento con cloxacilina y ceftriaxona en espera del resultado del cultivo del líquido.
2. Es aconsejable realizar artrocentesis diarias para aliviar los síntomas y evitar la destrucción articular.
3. Si el cultivo es negativo, es probable que se trate de una artritis reactiva.
4. La negatividad de la tinción de Gram descarta que se trate de una artritis séptica.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Pregunta que nos habla del manejo de la monoartritis aguda. Según lo que nos presenta la pregunta, se podría tratar de un cuadro de artritis reactiva (antecedente de cuadro de diarrea autolimitada, monoartritis de miembro inferior, paciente joven), aunque los resultados del líquido no son los característicos de un líquido séptico (no más del 90% de neutrófilos, no más de 50.000 células). Sí nos dan algún dato que nos hace dudar, como la disminución de la viscosidad, de ahí que iniciar un tratamiento antibiótico empírico es útil. Resulta muy evidente lo que nos dice la opción de respuesta 2, ya que el manejo de toda monoartritis aguda debe incluir la realización de artrocentesis; por todo lo expuesto anteriormente la opción de respuesta falsa es la 4, ya que un gramnegativo no descarta una artritis séptica.

-----O-----

La marcada calcificación y osificación de los ligamentos paraespinales anteriores dando la imagen característica en "cera derretida" es típica de:

1. EA (espondilitis anquilosante).
2. Hiperostosis vertebral idiopática difusa.
3. Osteomielitis vertebral.
4. AR (artritis reumatoide).

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La imagen característica que nos describen es propia de la hiperostosis anquilosante vertebral difusa

(enfermedad de Forestier), un proceso frecuentemente asintomático propio de varones de edad avanzada. La lesión radiológica típica de la espondilitis anquilosante son los sindesmofitos, formaciones más “finas”, uniformes y simétricas. En la espondiloartrosis la lesión radiológica son los osteofitos. Y en la osteomielitis vertebral, lo típico es la destrucción del disco intervertebral. En cuanto a la Artritis reumatoide, no es propia de ella la afectación del esqueleto axial, excepto a nivel de la columna cervical.

-----O-----

Varón de 30 años, homosexual y VIH positivo, sin tratamiento en la actualidad, que acude por tumefacción dolorosa en rodilla derecha, a la que se ha añadido posteriormente hinchazón en tobillo izquierdo. En la exploración presenta además conjuntivitis, lesiones pustulosas en plantas, queratosis ungueal importante y erosiones indoloras en glande. Interrogándole, refiere que ha tenido, unos 15 días antes, disuria, polaquiuria y exudado uretral mucopurulento. Respecto a la enfermedad que probablemente presenta este paciente, señale la afirmación CORRECTA:

1. Es la forma de artritis más frecuente en los pacientes VIH.
2. Típicamente siguen un curso más indolente que las de los pacientes inmunocompetentes.
3. Las lesiones cutáneas no son una manifestación habitual en las espondiloartropatías de los pacientes VIH, y cuando aparecen, son más leves que en pacientes no VIH.
4. El tratamiento de elección son inmunosupresores.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La presencia de una monoartritis aguda debe plantearnos, como principales diagnósticos diferenciales, la artritis séptica, la microcristalina y la reactiva. Dado que el paciente es joven, no tiene antecedentes de hiperuricemia ni tiene ninguna enfermedad metabólica que predisponga al depósito de pirofosfato, la primera opción no sería una artritis por microcristales. Por otra parte, la afectación aditiva de una segunda articulación, acompañada de lesiones cutáneas características, hace muy improbable una artritis séptica. Las lesiones mucocutáneas que nos refieren son sugestivas de una queratodermia palmoplantar, balanitis circinada y onicopatía. Todo esto, unido a un antecedente de uretritis durante las últimas semanas, establece el diagnóstico de artritis reactiva. Por otra parte, la artritis reactiva es la causa más frecuente de artritis en pacientes infectados por VIH, por lo que es el diagnóstico más probable. En estos pacientes, los síntomas articulares y, sobre todo, los cutáneos, suelen tener un curso mucho más agresivo que en las personas VIH negativas. El tratamiento de elección son los AINEs, aunque el tratamiento antirretroviral también contribuye a una mejoría. Lógicamente, al tratarse de un paciente VIH positivo, debemos evitar los inmunosupresores en su tratamiento.

-----O-----

En la EMTC, ¿cuál de las siguientes es la manifestación clínica MENOS frecuente?:

1. Cutánea.
2. Muscular.
3. Renal.
4. Pulmonar.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La EMTC no es un tema importante, pero puede resultar rentable saber cuatro cosas. La primera, que es una entidad bien definida y no una entidad dudosa cuando la clínica no sugiere un diagnóstico claro. Lo segundo, es su serología imprescindible: los anticuerpos anti- RNP. Lo tercero, que reúne clínica de varias enfermedades reumatológicas, como son la esclerodermia, la miopatía inflamatoria, el LES y la artritis reumatoide. Lo cuarto, que ninguna de ellas será extensa o grave, por lo que no hay afectación visceral importante. Entre las manifestaciones lúpicas, podemos mencionar la afectación cutánea y sistémica leve, siendo muy infrecuente nefritis lúpica. De esclerosis sistémica progresiva, las manifestaciones serán leves: Raynaud, esclerodactilia, afectación esofágica y como mucho hipertensión pulmonar, como se ve, todas propias de forma localizada, nunca crisis renales esclerodérmicas. La respuesta 4 es la correcta.

El líquido pleural en los pacientes con AR suele tener:

1. Glucosa elevada y complemento bajo.
2. Glucosa alta y complemento alto.
3. Glucosa baja y complemento bajo.
4. Glucosa normal y complemento alto.

Resp. Correcta: 3

Comentario: La pleuritis es la manifestación cardiopulmonar más frecuente de la AR, aunque no es tan habitual ni tan clínicamente evidente como en el LES. Las características del líquido pleural de la AR son curiosamente muy similares a las del derrame pleural tuberculoso. En ambos casos se trata de un exudado con celularidad variable, a menudo abundante y de predominio mononuclear. También comparten ambos derrames pleurales la disminución de la glucosa y los niveles elevados de ADA (adenosin deaminasa). Desde el punto de vista teórico la diferencia radica en que los niveles de complemento en líquido pleural están disminuidos en la AR a diferencia de la TBC. La utilidad de esta diferenciación no se planteará ante un paciente con derrame pleural y síntomas articulares, ya que estos últimos son bien distintas en ambas enfermedades (poliartritis simétrica de manos vs monoartritis crónica). La utilidad radica en el estudio de un paciente, ya diagnosticado de AR que desarrolla derrame pleural y en que nos planteamos la duda de si el derrame pleural se debe a la actividad inflamatoria propia de la enfermedad o a la reactivación de una tuberculosis probablemente favorecida por el tratamiento con corticoides. El diagnóstico de certeza se realizará mediante el cultivo en medio de Lowenstein del líquido pleural y la biopsia pleural que mostrará granulomas en el caso de la TBC. El tratamiento de estas dos situaciones es obviamente bien distinto.

Varón de 58 años diagnosticado de artritis gotosa tofácea y litiasis ureteral por cálculos de ácido úrico no tratado previamente, consulta por monoartritis aguda de rodilla. El análisis del líquido sinovial obtenido por artrocentesis muestra abundantes microcristales de urato intraleucocitarios. El ácido úrico sérico es de 9,4 mg/dl (valor normal <7mg/dl) y la creatinina está en rango normal. ¿Cuál de las siguientes estrategias terapéuticas esta contraindicado en el tratamiento de la gota aguda tofacea?

1. Aumentar la dosis de alopurinol
2. Disminuir la dosis de alopurinol
3. La opción 1 y 2 estan contraindicadas
4. Colchicina

Resp. Correcta: 3

Comentario: Recuerda que en los casos de gota aguda tofacea NO debemos de modificar los niveles de

ácido úrico.

-----O-----

Paciente con colitis ulcerosa que presenta diarrea sanguinolenta y ha notado de forma aguda tumefacción dolorosa en rodillas. Respecto a la complicación que presenta este paciente, señale la afirmación CORRECTA:

1. La artritis periférica, al igual que la espondilitis tiene una predilección por el sexo masculino.
2. El factor reumatoide es invariablemente positivo en estos pacientes.
3. No hay asociación al HLA-B27 si no hay afectación axial.
4. Con frecuencia se observa artropatía destructiva con erosiones subcondrales.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La afectación articular es la complicación extraintestinal más frecuente de la enfermedad inflamatoria intestinal. Puede afectar a articulaciones periféricas (25- 30%) o al esqueleto axial (20- 25%). La afectación de articulaciones periféricas no muestra predominio sexual mientras que la afectación del esqueleto axial es más frecuente en varones. La asociación con el HLA B27 sólo se produce (70%) en las formas con afectación del esqueleto axial. Como corresponde a espondiloartropatías seronegativas no se asocia al factor reumatoide. La afectación de articulaciones periféricas es de comienzo agudo, coincidiendo con los síntomas gastrointestinales y no es erosiva.

-----O-----

Señale la afirmación FALSA en relación con la enfermedad de Behçet:

1. Se relaciona con la presencia de HLA B5 y HLA B51.
2. Se asocia a prueba de patergia positiva.
3. En mujeres es frecuente la presencia de úlceras recidivantes en la boca, siendo extraña la aparición de úlceras vulvares que, de estar presentes, suelen dejar cicatriz.
4. Asocia lesiones oculares tales como: iritis, uveítis anterior y posterior, hipopion, con riesgo incluso de ceguera.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Las aftas orales recidivantes (100% de los casos) son dolorosas, y tienen un tamaño y aspecto variable, curándose solas en un tiempo comprendido entre 1 y 3 semanas, sin dejar cicatrices. Las aftas genitales (60- 80%) se localizan en el glande y escroto en el varón y en la vulva, vagina y cérvix en la mujer, siendo dolorosas y tardando en cicatrizar en el varón, y mucho menos molestas en las mujeres. Se trata, por lo tanto, de un problema frecuente (opción 3 falsa, por lo que la marcamos). La uveítis bilateral casi siempre está presente en el 60-70% de los pacientes. A veces se asocian coroiditis, hemorragias del cuerpo vítreo, neuritis óptica, alteraciones vasculares retinianas y otras, que pueden conducir a la ceguera si no se trata la enfermedad.

-----O-----

Mujer de 52 años que acude a Urgencias por presentar desde hace varias semanas palidez de los dedos de las manos especialmente con el frío, artritis en ambas manos,

principalmente en articulaciones interfalángicas proximales, mialgias generalizadas y tumefacción de los dedos con tirantez cutánea. Se le realiza una analítica que presenta importante elevación de marcadores inflamatorios, destacando elevación de VSG, y anemia, y elevación de los anticuerpos anti-RNP a títulos muy elevados. Dados los hallazgos descritos, ¿cuál es el diagnóstico más probable?

1. Síndrome de CREST.
2. Enfermedad mixta del tejido conectivo.
3. Esclerosis sistémica.
4. Fascitis eosinofílica.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El diagnóstico de la enfermedad mixta del tejido conectivo se establece mediante una serie de criterios, siendo indispensable la elevación de títulos de anticuerpos anti-RNP por encima de 1/1.600. El resto de criterios son clínicos (edema de manos, fenómeno de Raynaud, sinovitis, esclerodactilia, miositis), y para establecer el diagnóstico se deben presentar al menos tres criterios clínicos (respuesta 2 correcta).

-----O-----

Varón de 50 años, sin antecedentes de interés, que desde hace cuatro meses presenta cefalea, pérdida de memoria, y en la última semana se ha añadido disminución del nivel de conciencia y varios accidentes isquémicos transitorios en territorios de ambas arterias cerebrales medias. En la analítica destaca solo una VSG elevada, siendo las serologías para sífilis, VIH, CMV, herpes simple, varicela y Borrelia negativas, así como los ANA y ANCA. Radiografía de tórax, ecocardiograma y estudio Doppler de troncos supraaórticos sin alteraciones. La TC y la RMN objetivan múltiples infartos en corteza y sustancia blanca. La angiografía no mostró lesiones. En la biopsia cerebral se evidenció afectación de arteriolas con lesiones vasculíticas granulomatosas. El diagnóstico que usted sospecha en este paciente es:

1. Enfermedad de Wegener.
2. Enfermedad de Eales.
3. Vasculitis primaria del SNC.
4. Enfermedad de Churg-Strauss.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta complicada, puesto que la vasculitis aislada del SNC es un proceso muy poco frecuente. Se trata de una patología grave con afectación principal de arteriolas. La clínica suele ser bastante inespecífica, aunque es típica la aparición de cefalea, deterioro progresivo de las funciones superiores y aparición de múltiples infartos distribuidos por ambos hemisferios cerebrales (respuesta 3 correcta). Dado el cuadro clínico, podemos descartar las demás opciones de respuesta:

- 1.- Wegener (infiltrados bilaterales cavitados no migratorios, afectación de vía aérea superior y frecuente afectación renal).
- 2.- Eales (vasculitis retiniana).

4.- Churg-Strauss (asma resistente a tratamiento, eosinofilia e infiltrados pulmonares no cavitados migratorios).

¿Cuál es la complicación más grave de la enfermedad de Behçet?

1. Uveítis posterior.
2. Eritema nodoso.
3. Aneurismas arteriales.
4. Tromboembolismo pulmonar.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

En este caso nos hablan de la complicación más grave del Behçet, debemos saber que no existe complicación más grave que la afectación neurológica, no obstante, esta opción no aparece entre las posibles opciones por lo tanto no podemos marcarla.

Lo que si podemos hacer es fijarnos en la afectación ocular, que nos muestra la opción 1, que es la opción más grave de las que aparecen

Rotando por el servicio de Reumatología se encuentra una hoja suelta en una mesa al lado de un ordenador, con una analítica, pero que no tiene nombre ni identificador. En el informe aparece “Inmunología positiva para ANCA específicos para la proteinasa 3, con inmunofluorescencia indirecta donde se objetiva un patrón citoplasmático granular”. ¿A qué enfermo cree usted que pertenece esa analítica?

1. Rocío, paciente de 36 con Arteritis de Takayasu.
2. Javier, diagnosticado de Granulomatosis de Wegener.
3. Pedro, paciente en estudio por una posible Granulomatosis eosinofílica con poliangéitis.
4. La paciente de la 304 que tiene una Panarteritis nodosa.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

En relación al tema de las vasculitis, la determinación con más trascendencia en el diagnóstico es la presencia de ANCA. La detección de ANCA específicos para la proteinasa 3, o **c-ANCA** (C=citoplasmáticos) es muy específica y característica de la **Granulomatosis de Wegener**. Por lo tanto, tendríamos que ir a buscar al adjunto encargado de Javier y devolverle el informe del análisis.

Una paciente de 56 años presenta poliartritis simétrica de IFP, MCF, carpos y rodillas desde hace tres meses, con rigidez matutina de 90 minutos. En la radiología de manos muestra aumento de partes blandas. El factor reumatoide es negativo, tiene una VSG de 40 (normal hasta 20) y no presenta nódulos reumatoides. ¿Qué puntuación suma esta paciente en los nuevos criterios de clasificación (2010) para artritis reumatoide?

1. Dos.
2. Siete.
3. Cinco.
4. Seis.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El diagnóstico de AR se realiza por un cuadro clínico compatible (poliartritis simétrica de más de seis semanas de evolución que afecta a pequeñas articulaciones de las manos) y nos ayudamos de los hallazgos radiológicos (erosiones, osteopenia en banda) si existen, y analíticos (FR, anti-CCP). Pero, con el fin de homogeneizar a nuestros pacientes y poder incluirlos en un ensayo clínico o cualquier tipo de estudio, empleamos los criterios de clasificación. Los últimos publicados son los de 2010, que se basan en un sumatorio:

·Afectación articular:

- 1 articulación grande afectada: 0.
- 2-10 articulaciones grandes afectadas: 1.
- 1-3 articulaciones pequeñas afectadas: 2.
- 4-10 articulaciones pequeñas afectadas: 3.
- > 10 articulaciones pequeñas afectadas: 5.

·Serología:

- FR y ACPA negativos: 0.
- FR y/o ACPA positivos bajos (< 3 VN): 2.
- FR y/o ACPA positivos alto (> 3 VN): 3.

·Reactantes de fase aguda:

- VSG y PCR normales: 0.
- VSG y/o PCR elevadas: 1.

·Duración:

- < 6 semanas: 0.
- = 6 semanas 1.

La paciente de nuestro caso clínico tiene > 10 articulaciones pequeñas inflamadas (2 carpos, 10 MCF, 10 IFP): 5 puntos + VSG elevada: 1 unto + evolución de > 6 semanas: 1 punto = 7 (respuesta 2 correcta).

-----O-----

Una de las siguientes afirmaciones sobre la artropatía psoriásica no es cierta. Señálela:

1. Es una artropatía inflamatoria y seronegativa.
2. El metotrexato es una buena opción terapéutica.
3. La psoriasis suele preceder a la artritis.
4. Es muy rara la afectación de las articulaciones interfalángicas distales.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

-----O-----

Mujer de 29 años diagnosticada de lupus eritematoso sistémico desde hace cinco años. Actualmente, se encuentra bien controlada de su enfermedad, sin requerir tratamiento. Consulta para informarse sobre la posibilidad de quedarse embarazada dada su enfermedad. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre lupus y embarazo es

VERDADERA?

1. Está terminantemente prohibido que una enferma con lupus se quede embarazada, ya que sería peligroso para madre y feto.
2. La disminución de la fertilidad en las pacientes con lupus limita mucho la posibilidad de embarazo, siendo necesario recurrir a técnicas de reproducción asistida para conseguir la gestación.
3. No está completamente demostrado que la gestación empeore el curso de la enfermedad, pero sí puede haber un empeoramiento en el puerperio. Se recomienda la gestación cuando la enfermedad esté inactiva.
4. Puede quedarse embarazada, pero sabiendo que es altamente probable que el feto desarrolle un lupus neonatal, cuadro con una elevada mortalidad.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta en la que es fácil descartar opciones de respuesta mediante técnica de examen. Veamos las opciones de respuesta:

- 1.- Es poco probable si comienza con: "Está terminantemente prohibido...".
- 2.- Nos habla de una disminución de la fertilidad como consecuencia del LES. No es cierto. Es verdad que presentan un riesgo aumentado de abortos, sobre todo en el contexto de un posible síndrome antifosfolípido o una nefritis activa durante la gestación, pero el problema no estaría en conseguir la gestación.
- 3.- No se ha demostrado que empeore el LES durante la gestación, aunque se recomienda que busquen embarazo cuando la enfermedad esté inactiva (respuesta 3 correcta). Sí que se ha descrito que la enfermedad PUEDE empeorar en el parto.
- 4.- Se parece bastante a la primera; de una forma no tan estricta, nos da a entender que el embarazo tiene riesgos que no son asumibles. Solo un pequeño porcentaje (menos del 5%) de los hijos de madres con LES portadoras de anticuerpos anti-Ro y anti-La desarrollarán un lupus neonatal, siendo en la mayoría de los casos un cuadro leve.

-----o-----

Una mujer de 40 años presenta engrosamiento en la piel de la cara, artralgias y dolor centrotorácico que aumenta con la inspiración, así como fenómeno de Raynaud; todo ello desde hace seis meses. En la radiografía de tórax hay cardiomegalia y en el ecocardiograma se objetiva derrame pericárdico. Los anticuerpos anti-SCL 70 son positivos. ¿Cuál es el tratamiento de elección?

1. D-penicilamina.
2. Aspirina 200 mg/día.
3. Prednisona.
4. Colchicina.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Del tema de esclerosis sistémica (ES), lo más importante es que sepas diferenciar las formas difusa y limitada. Este es un caso de ES difusa. Se caracteriza por afectación cutánea de cara, tronco y extremidades, con fenómeno de Raynaud de reciente comienzo (generalmente el año anterior a las manifestaciones

cutáneas). El curso es rápidamente progresivo, y el pronóstico lo marca la afectación pulmonar (enfermedad pulmonar intersticial) y renal. También puede provocar alteraciones cardíacas y gastrointestinales. Se caracteriza por la presencia de Ac anti-topoisomerasa I = anti-SCL 70. Cuando existe afectación cardíaca en forma de pericarditis (como sucede en este caso clínico), el tratamiento de elección son los corticoides a dosis bajas (15-20 mg de prednisona al día) para el tratamiento de la fase aguda, pero no está indicado su uso a largo plazo. Recuerda que en la ES no podemos administrar dosis altas de corticoides debido al riesgo de precipitar una crisis renal esclerodérmica.

Varón de 42 años que hace 7 meses comenzó con fatiga, artralgias y congestión nasal, seguido de un episodio de hemoptisis. La analítica mostró elevación de la VSG, leucocitosis, anemia, alteraciones en el sedimento urinario, así como infiltrados pulmonares. El título de c-ANCA fue de 1:128. ¿Qué tratamiento RECOMENDARÍA en este paciente?

1. Ciclosporina 0,5 mg/kg/semanal.
2. Metotrexate 1 mg/semanal.
3. Prednisona 1 mg/kg/día y ciclofosfamida 2 mg/kg/día.
4. Prednisona 0,5 mg/kg/día.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta sobre un paciente con una granulomatosis con poliangéitis, también llamada enfermedad de Wegener, cuyo tratamiento tiene una fase inicial de inducción y una fase posterior de mantenimiento. La fase inicial se basa en corticoides en dosis altas + ciclofosfamida (respuesta 3 correcta).

En la artritis periférica de las enfermedades intestinales inflamatorias, es cierto que:

1. Guarda relación con el HLA B27.
2. Aparece en más del 40% de los casos.
3. Guarda relación con los brotes digestivos.
4. Es una indicación por sí sola de tratamiento con esteroides.

Resp. Correcta: 3

Comentario: La artritis de articulaciones periféricas asociada a la enfermedad inflamatoria intestinal aparece en el 25- 30 % de los casos. Es más frecuente en los pacientes que muestran afectación del intestino grueso y complicaciones como abscesos, poliposis pseudomembranosa, lesiones perianales, hemorragias masivas, eritema nodoso, estomatitis, uveitis o pioderma gangrenoso. Suele afectar a grandes articulaciones (rodillas, tobillos) y característicamente muestra un curso paralelo al de la enfermedad intestinal, de forma que coinciden los brotes de artritis con los brotes intestinales (diarrea, rectorragia, fiebre, dolor abdominal). Cuando no haya afectación del esqueleto axial la frecuencia con la que se asocia al B27 es similar a la población general. En su tratamiento es útil cualquier medida que mejore los síntomas intestinales y no necesariamente los corticoides (aunque estos sí pueden ser útiles).

Una mujer de 63 años, trabajadora de una fábrica textil, consulta a su médico de

cabecera porque, desde hace unos meses, presenta dolor en articulaciones interfalángicas proximales y distales de ambas manos que se acentúa con los movimientos. La exploración revela deformación articular característica. La analítica es normal. Su médico recomienda antiinflamatorios, así como jubilación anticipada. Señale el enunciado INCORRECTO al respecto:

1. La capsaicina en crema puede proporcionar alivio sintomático tópico, al interferir con el neuropéptido P.
2. La patología que padece la paciente descrita es una enfermedad degenerativa sin tratamiento posible, salvo sintomático.
3. A diferencia del caso descrito, habitualmente la velocidad de sedimento globular está elevada.
4. Es necesario mantener un cierto grado de ejercicio, preferiblemente isométrico, para asegurar la motilidad articular.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Estamos ante un enunciado sencillo aparentemente con respuestas bastante rebuscadas. En este tipo de preguntas lo primero es que no cunda el pánico; debemos elegir la opción que mejor nos cuadre con nuestra sospecha diagnóstica. Dado que estamos ante un caso típico de artrosis (artrosis de IF distales y proximales) debemos tener claro solo una cosa, la VSG NO estará elevada dado que no se trata de una enfermedad inflamatoria sistémica y por tanto no tendrá ningún reactante de fase aguda elevado ni ninguna alteración analítica secundaria a la propia artrosis.

-----O-----

¿Cuál de estos NO es criterio diagnóstico de LES?:

1. Erupción malar.
2. Ulceras bucales.
3. Vasculitis leucocitoclástica cutánea.
4. Anticuerpos anti-DNA de doble hélice positivos.

Resp. Correcta: 3

Comentario: El diagnóstico de lupus eritematoso sistémico (LES) se basa en la presencia de al menos 4 de los 11 criterios que se han establecido para este fin. Los cuatro primeros son de manifestaciones cutáneas: erupción malar, erupción discoide, fotosensibilidad y úlceras orales o nasofaríngeas. Los cuatro siguientes de manifestaciones clínicas no cutáneas: artritis, serosistis (pleuritis o pericarditis), enfermedad renal manifestada por proteinuria o cilindros celulares y enfermedad neurológica (convulsiones o psicosis lúpica). Los tres últimos son manifestaciones de laboratorio: enfermedad hematológica (anemia hemolítica, leucopenia, linfopenia o trombopenia), presencia de anticuerpos característicos como anti- DNSds; anti- Sm o antifosfolípido, y por último la determinación de anticuerpos antinucleares. Como puedes comprobar, la respuesta correcta es la vasculitis leucocitoclastica cutánea.

-----O-----

¿Cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA?:

1. El factor reumatoide es un autoanticuerpo que reacciona con el fragmento Fc de la inmunoglobulina G.
2. Existen diferentes tipos de factor reumatoide.
3. Algunas infecciones víricas agudas pueden ir asociadas a la presencia de factor reumatoide.
4. La presencia de factor reumatoide en una poliartritis es diagnóstica de artritis reumatoide.

Resp. Correcta: 4

Comentario: El factor reumatoide es un criterio diagnóstico más de la artritis reumatoide, que ni es específico (aparece en otros múltiples procesos e incluso en población sana), ni aparece en todos los casos de la enfermedad (el 30% de los pacientes con AR no muestran factor reumatoide). El FR es una Ig (de diferentes tipos) que reacciona frente a la Fc de la Ig G. El más frecuentemente detectado es de tipo IgM. La opción que ofrece más dudas es la 3, ya que el porcentaje de personas sanas que muestran FR no es pequeño, se encuentra en el 5% de la población general y el porcentaje alcanza el 15- 20 % de las personas de edad avanzada.

-----O-----

Ante un paciente con una trombosis venosa profunda y con positividad en 2 determinaciones diferentes para anticoagulante lúpico y anticuerpos anticardiolipina, ¿Cuál de los siguientes sería el tratamiento más indicado?

1. Enoxaparina 40 mg diarios.
2. Ácido acetilsalicílico 100 mg diarios.
3. Medias de compresión en miembros inferiores.
4. Acenocumarol.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Ante casos diagnósticos de síndrome antifosfolípido, está indicado el tratamiento anticoagulante con acenocumarol, manteniendo un INR entre 2.5 y 3.5. En casos en los que no se pueda administrar o esté contraindicado, se pueden emplear heparinas de bajo peso molecular a dosis anticoagulantes.

-----O-----

¿Cuál de estas afirmaciones es FALSA respecto a la osteoporosis postmenopáusica?

1. La pérdida de masa ósea se inicia en el hueso cortical.
2. Es más frecuente en mujeres ooforectomizadas.
3. Se hace evidente entre los 50 y los 75 años.
4. Es más frecuente en mujeres fumadoras.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La pérdida ósea es fundamentalmente en la zona trabecular, más que en la cortical. Para recordarlo, ten presente la imagen de una densitometría, en la que se valora la pérdida de masa ósea trabecular respecto a la media poblacional. Por ello, es frecuente la fractura del cuerpo vertebral (trabecular). En cambio, aquellas en las que la pérdida cortical es más importante (fractura de cuello de fémur, por ejemplo) es más frecuente en ancianos.

-----O-----

Una de las siguientes características anatomopatológicas NO es propia de la panarteritis nodosa clásica:

1. Marcada necrosis fibrinoide.
2. Afectación parcheada, con predominio de las zonas de bifurcación.

3. Depósito de inmunocomplejos en la pared vascular.
4. Afectación de capilares y vénulas.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

-----o-----

¿Cuál de los siguientes NO es un componente del denominado síndrome CREST, manifestación típica de la esclerosis sistémica con afectación cutánea limitada?

1. Calcinosis cutánea.
2. Fenómeno de Raynaud.
3. Enfermedad pulmonar intersticial.
4. Telangiectasias.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Las manifestaciones del síndrome de CREST son calcinosis, fenómeno de Raynaud, afectación esofágica (típicamente hipomotilidad de 2/3 inferiores, y disfunción de EEI), esclerodactilia y telangiectasias (marcamos la opción de respuesta 3).

-----o-----

En relación con la fibrosis retroperitoneal relacionada con IgG4, cuál es CIERTA:

1. Debemos considerar el linfoma en el diagnóstico diferencial.
2. Suele presentar buena respuesta a corticoides.
3. Suele presentar niveles elevados de IgG4 en suero.
4. Es más frecuente en mujeres asiáticas mayores de 50 años.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La enfermedad relacionada con IgG4 predomina en general en varones de entre 50 y 70 años (respuesta 4 falsa) y la raza asiática es más frecuente en las formas limitadas de cabeza y cuello y en la forma sistémica/síndrome de Mikulicz, mientras que la raza blanca predomina en las formas pancreato-hepatobiliares y especialmente en la fibrosis retroperitoneal.

La fibrosis retroperitoneal supone el fenotipo de enfermedad relacionada con IgG4 con menor elevación de IgG4 (respuesta 3 falsa) y peor respuesta a corticoides (respuesta 2 falsa).

En los casos de masas de partes blandas retroperitoneales que rodean o engloban la aorta y/u otras estructuras no podemos asumir el diagnóstico de IgG4 sin biopsia, ya que los síndromes linfoproliferativos son indistinguibles desde el punto de vista de la imagen (respuesta 1 correcta).

-----o-----

Mujer de 53 años, con fenómeno de Raynaud de 10 años de evolución, consulta por la aparición de artralgiyas y artritis de la muñeca izquierda, así como por una

esclerodactilia, disfagia, sobre todo para alimentos sólidos, y empeoramiento de su fenómeno de Raynaud. Sabiendo que los ANA son positivos a 1:160, ¿cuál es el diagnóstico MÁS probable?

1. LES.
2. Esclerosis sistémica.
3. Enfermedad mixta del tejido conectivo.
4. Síndrome de superposición.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Nos describen un caso de esclerosis sistémica limitada. El fenómeno de Raynaud se presenta en la práctica totalidad de los pacientes, a menudo es la primera manifestación de la enfermedad, y puede preceder en años a la aparición del resto de signos y síntomas, a diferencia de lo observado en la difusa en la que la precede en meses. Las alteraciones músculo-esqueléticas se observan en la mitad de los pacientes incluyendo artralgias y artritis (puede llegar a ser similar a la artritis reumatoide). La afectación esofágica es la afectación visceral más frecuente, originando disfagia, pirosis, plenitud gástrica y dolor retroesternal. No olvides que la positividad de los ANAs es más bien inespecífica para este tipo de enfermedades, presentándose en un 95% de los pacientes con esclerosis sistémica.

-----O-----

Varón de 29 años, VIH positivo, que consulta por artritis de comienzo agudo en tobillo derecho, junto con talalgia intensa, y a la que se ha añadido tumefacción de rodilla izquierda e intensa inflamación de 2º y 4º dedos del pie izquierdo, observándose además lesiones pustulosas en plantas y queratosis ungueal intensa. El paciente presenta además conjuntivitis bilateral, astenia, anorexia y febrícula. El líquido sinovial extraído de la rodilla es amarillento y turbio, tiene una viscosidad baja, glucosa baja, proteínas altas y 50.000 PMN/mm³, y no se evidencia gérmenes en el gram. Refiere haber tenido un episodio de diarrea sanguinolenta hace 15 días aproximadamente. Ud sospecha que este paciente presenta:

1. Artritis séptica.
2. Artritis gonocócica.
3. Artritis reactiva.
4. Artritis psoriásica.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La causa más frecuente de artritis aguda en el VIH positivo es la artritis reactiva. Por otra parte, la presencia de talalgia, conjuntivitis, lesiones plantares y diarrea sanguinolenta previa sugieren fuertemente este diagnóstico.

-----O-----

Valorando un paciente, en estudio en su consulta por una artritis de pequeñas articulaciones de meses de evolución, tras una serie de pruebas le consigue realizar el diagnóstico de artritis reumatoidea. ¿Cual de los siguientes fármacos deben incluir

dentro del tratamiento de entrada?

1. Metotrexato
2. Metilprednisolona
3. Etoricoxib
4. Diclofenaco

Resp. Correcta: 1

Comentario: Debes conocer que el tratamiento de elección en la artritis reumatoide de entrada es el metotrexate

¿Cuál de los siguientes fármacos antihipertensivos sería el MENOS indicado en un paciente hipertenso con antecedentes de artritis gotosa?

1. Hidroclorotiazida.
2. Amlodipino.
3. Losartán.
4. Enalapril.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Lo más inadecuado sería la administración de diurético que eleve la uricemia mientras que, por el contrario, hay algún antihipertensivo que puede ser beneficioso para los pacientes con gota por su efecto uricosúrico, como el Losartán o los antagonistas del calcio.

¿Cuál de las siguientes descripciones de líquido articular es más compatible con el diagnóstico de artritis séptica?

1. Líquido transparente con glucosa 75 mg/dl y proteínas normales.
2. Líquido turbio con presencia de 50.000 PMN/ml y glucosa 17 mg/dl.
3. Líquido turbio con presencia de 20.000 PMN/ml y cristales con birrefringencia negativa en el examen con luz polarizada.
4. Líquido claro con glucosa 25 mg/dl y proteínas altas.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El examen fundamental es el estudio del líquido sinovial, que es de características infecciosas: aspecto turbio o purulento, recuento celular habitualmente superior a 50.000 leucocitos/mm³, de predominio polimorfonuclear y consumo de glucosa. El punto de corte de 50.000 células no permite, sin embargo, diferenciar entre artritis microcristalinas y sépticas, pues las primeras pueden sobrepasar frecuentemente dicho umbral.

¿Cual de las siguientes manifestaciones clínicas hematológicas en el lupus eritematoso

sistémico es más frecuente?

1. Esplenomegalia
2. Linfadenopatías
3. Trombopenia
4. Leucopenia

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Recuerda que las alteraciones hematológicas en el LES son muy frecuentes y dentro de ellas la anemia de trastorno crónico y la leucopenia son las más frecuentes

-----O-----

Un anciano con TBC e ICC que recibe tratamiento para ambas patologías, desarrolla un cuadro de artritis aguda en el tobillo derecho que cede a las pocas horas de la infusión i.v. de colchicina. ¿Cuál de los siguientes fármacos NO suele producir esta complicación?:

1. Hidroclorotiazida.
2. Isoniacida.
3. Piracinamida.
4. Etambutol.

Resp. Correcta: 2

Comentario: El paciente ha desarrollado un cuadro de monoartritis aguda que cede con la administración de colchicina por vía intravenosa por lo que debes suponer que se trata de una artritis por microcristales, probablemente de ácido úrico. Esta sospecha se confirma al analizar las respuestas ya que aparecen en todas ellas, excepto en la que es correcta, diversos fármacos que producen hiperuricemia al disminuir la excreción renal de ácido úrico. Entre estos fármacos están algunos tuberculostáticos como la piracinamida o el etambutol, pero no la isoniacida que es la respuesta correcta. Los diuréticos como la hidroclorotiazida, la aspirina en dosis bajas (inferiores a los 2 gramos al día) así como la ciclosporina que no aparece en esta pregunta también disminuyen la excreción renal de ácido úrico.

-----O-----

Con respecto a la afectación articular de la artritis reumatoide, es INCORRECTO que:

1. La afectación articular se produce generalmente de forma simétrica.
2. La afectación axial afecta, exclusivamente, a la columna dorsal.
3. La implicación de las articulaciones interfalángicas distales se produce de forma excepcional.
4. Se presenta habitualmente en forma de poliartritis de inicio insidioso.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Debes conocer bien la clínica de la artritis reumatoide, sobre todo las peculiaridades de la afectación articular. Generalmente se presenta en forma de poliartritis de inicio insidioso con afectación simétrica,

siendo las metacarpofalángicas y las muñecas las más frecuentemente afectadas. Recuerda que la implicación de las interfalángicas distales es excepcional (su afectación es más típica de la artropatía psoriásica). En la opción de respuesta 2 se afirma que la afectación dorsal es la típica de la enfermedad cuando, en realidad, es la cervical (opción 2 incorrecta, por lo que la marcamos).

-----O-----

¿Cuál de las siguientes situaciones se asocia a artropatía por oxalato cálcico?:

1. Hemocromatosis.
2. Hemodiálisis.
3. Hipotiroidismo.
4. Dermatomiositis.

Resp. Correcta: 2

Comentario: El depósito de cristales de oxalato cálcico puede deberse a una oxalosis primaria o a una oxalosis secundaria. La oxalosis primaria es un trastorno metabólico hereditario raro. La formación excesiva de ácido oxálico se debe al menos a dos defectos enzimáticos distintos que acarrearán hiperoxalemia y depósito de cristales de oxalato en los tejidos. La oxalosis secundaria es más frecuente que la primaria y constituye una de las muchas alteraciones metabólicas que aparecen como complicación de la insuficiencia renal terminal. Los pacientes afectados por este proceso eran dependientes de hemodiálisis o de diálisis peritoneal durante largos periodos, y muchos habían recibido suplementos de ácido ascórbico. El ácido ascórbico, al metabolizarse, produce oxalatos. Actualmente suele evitarse la administración de estos suplementos durante las sesiones de hemodiálisis, dado el incremento de incrementar la hiperoxalosis y sus consecuencias.

-----O-----

Ante la sospecha de monoartritis aguda de origen infeccioso, ¿cuál debe ser nuestra actitud inicial tras realizar artrocentesis?

1. Iniciar tratamiento antibiótico oral.
2. Iniciar tratamiento antibiótico empírico iv.
3. Esperar resultados de estudios microbiológicos.
4. Iniciar tratamiento antibiótico empírico intraarticular.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

-----O-----

Varón de 32 años que acude a consulta por la aparición de una parótida aumentada de tamaño, boca seca y queratitis seca con un test de Schirmmer positivo (ausencia de secreción lacrimal). En la biopsia parotídea se observa un infiltrado linfocitario con predominio CD8. Como antecedente de interés refiere un cuadro mononucleósico hace 2 meses. ¿Qué es lo más probable?:

1. Sarcoidosis.
2. Linfoma linfoblástico.
3. Sind. de linfocitosis difusa infiltrativa por HIV.
4. Recidiva mononucleósica.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Esta pregunta te servirá para memorizar una posible causa infecciosa de un síndrome indistinguible del Sjögren. El virus HIV puede hacer casi de todo, y ésta es una curiosidad más. La clínica es la de xerostomía y queratoconjuntivitis seca, con hipertrofia parotídea y infiltrados linfocitarios. Sin embargo el infiltrado está compuesto por linfocitos CD8, y el paciente es muy joven, además de tener un antecedente típico de primoinfección VIH (el síndrome mononucleósico). Pues, debes sospechar que hay una causa infecciosa imitando al Sjögren, capaz de crear un síndrome mononucleósico. Los linfomas a que predispone el Sjögren aparecen tras mucho tiempo de evolución de la enfermedad, y no son de linfocitos CD8+, sino de linfocitos B. La sarcoidosis presenta hipertrofia parotídea pero además disnea, parálisis facial,? otros síntomas distintos.

-----O-----

Respecto a la artritis reumatoide, señale la opción falsa:

1. La manifestación ocular más común es la escleritis pudiéndose hacías en ocasiones a un síndrome de Sjögren secundario
2. En aquellos pacientes que desarrollan modelos subcutáneos, lo más habitual es que presenten factor reumatoide positivo
3. La pleuritis es la modificación este articular más frecuente, aunque suele ser asintomática
4. Los pacientes que presentan vasculitis reumatoidea la tomé a patológica de las lesiones es muy similar a la observada y la panarteritis nodosa

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Debes conocer que la manifestación ocular más común en la AR es la conjuntivitis que estará en el 20% de los pacientes

La escleritis, es la manifestación ocular más específica, pero sólo está en el 1% de los pacientes

-----O-----

¿Cuál es la vía MÁS frecuente de producción de una artritis séptica?

1. Por contigüidad.
2. Hematógena.
3. Local a través de cortes o heridas.
4. Tras cirugías abiertas.

Resp. Correcta: 2

Comentario: La vía más frecuente en todas las artritis sépticas es la hematógena, tras bacteriemia de cualquier origen.

-----O-----

Un varón de 80 años, diabético de años de evolución, acudió a consulta por rigidez de raquis de 10 años de evolución. En la anamnesis dirigida no refería dolor alguno. La exploración física evidenció una gran disminución de la flexoextensión, flexiones

laterales y rotaciones del raquis cervical. El raquis dorsal y lumbar también estaban limitados. La radiología evidenció calcificaciones en la cara anterolateral de los cuerpos vertebrales, formando puentes óseos intervertebrales, que predominaban en lado derecho; el espacio discal estaba conservado. ¿Cuál es su diagnóstico?

1. Espondilitis anquilopoyética.
2. Artrosis de raquis.
3. Hiperostosis anquilosante vertebral de Forestier- Rotes.
4. Mastocitosis.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Es la foto típica de la hiperostosis anquilosante vertebral difusa (enfermedad de Forestier-Rotes). Esta enfermedad presenta rigidez axial (principalmente dorsal y cervical baja, sin comprometer las sacroilíacas) en pacientes de edad avanzada, indolora (o con muy poco dolor de características mecánicas) y cuyos hallazgos radiológicos descritos en la pregunta se corresponden con engrosamientos asimétricos de las corticales de las vértebras, dando un aspecto de imagen en “cera derretida”, sin presentar sindesmofitos (respuesta 3 correcta). Repasemos las demás opciones de respuesta:

- 1.- La Espondilitis anquilosante (aunque al igual que el Forestier es más frecuente en varones), suele iniciar antes de 40 años, con limitación y dolor de características inflamatorias a nivel de las sacroilíacas [sacroileitis radiológica generalmente simétrica, es hallazgo radiológico imprescindible (100% de los casos)] y que clásicamente en la radiografía de columna vertebral muestra el patrón “caña de bambú” por la presencia de cuadratura vertebral, sindesmofitos y anquilosis de las articulaciones interapofisarias.
- 2.- En la artrosis del raquis se produce dolor, limitación y además alteración en el espacio intervertebral por lesión del cartilago articular. Las vértebras que se afectan con mayor frecuencia son las cervicales y las lumbares.
- 4.- La mastocitosis en sus dos variantes, la cutánea (más frecuente) y la sistémica con afectación de varios órganos como médula ósea y/u otros órganos extracutáneos como huesos, hígado, bazo o ganglios linfáticos (70% afectación ósea), en la radiología hablarían de un patrón osteolítico u osteoblástico en varios huesos, acompañados de clínica sistémica.

-----o-----

Varón de 35 años consulta por una inflamación aguda en el tobillo izquierdo 2 días después de una tremenda borrachera, durante la cual no recuerda haberse dado ningún golpe. El líquido obtenido por punción es fluido, turbio y acuoso con 13.450 leucos/mm³ y cristales en forma de aguja con intensa birrefringencia negativa. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Sinovitis villonodular pigmentada.
2. Artropatía alcohólica aguda.
3. Artritis por cristales de oxalato cálcico.
4. Gota.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Pregunta fácil, que se responde conociendo las características de los cristales de ácido úrico (en aguja y con birrefringencia muy negativa). Se trata de un líquido articular inflamatorio. La borrachera probablemente haya sido el desencadenante del episodio de gota.

Respecto a la púrpura de Schönlein-Henoch señale la respuesta FALSA:

1. La IgG es el anticuerpo que se suele detectar en los inmunocomplejos.
2. La púrpura palpable es habitual.
3. Afecta habitualmente a niños.
4. La mayoría de los pacientes se recupera totalmente.

Resp. Correcta: 1

Comentario: La púrpura de Schönlein- Henoch o púrpura anafilactoide es un proceso que típicamente afecta a niños caracterizado por la aparición de una púrpura palpable de distribución en miembros inferiores y nalgas, artralgias, síntomas y signos gastrointestinales y alteraciones del sedimento urinario. Los anticuerpos que mas frecuentemente se detectan formando parte de los inmunocomplejos son del tipo IgA, que también se demuestra en las biopsias renales. Las manifestaciones cutáneas y articulares se observan prácticamente en todos los pacientes. Las gastrointestinales se observan en un 70% y consisten en dolor tipo cólico, nauseas, vómitos, diarrea o estreñimiento y expulsión de sangre o moco.

Señale cuál de las siguientes articulaciones se afecta con MENOS frecuencia en la artritis reumatoide:

1. Interfalángicas proximales.
2. Rodilla.
3. Codos.
4. Carpos.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Como norma general, aunque no invariable, la frecuencia con que se afectan las articulaciones en la artritis reumatoide disminuye a medida que nos desplazamos en sentido proximal de forma que entre las citadas en las opciones nos encontramos que las IFP y metacarpofalngicas se afectan en el 90 % de los casos. Los carpos se afectan en un alto porcentaje de pacientes aunque discretamente inferior. Las rodillas son asiento habitual (50%). Entre las mencionadas las menos habituales son los codos que se afectan en algo más del 20% de los casos.

La enfermedad de Behçet se caracteriza por:

1. Artritis, uretritis y conjuntivitis.
2. Aftas en la boca, úlceras en genitales y brotes de iritis.
3. Artritis, manifestaciones digestivas y HLA-B12 positivo.
4. Queratoconjuntivitis y artritis.

Resp. Correcta: 2

Comentario: La enfermedad de Behçet es una enfermedad que afecta sobre todo a varones jóvenes y se caracteriza fundamentalmente por la aparición de aftas orales de repetición junto con la posible a parición de aftas genitales, lesiones cutáneas (eritema nodoso, lesiones acneiformes..), afectación ocular(uveítis anterior o posterior, vasculitis retiniana..), afectación digestiva (aftas a nivel del tracto digestivo), artritis de grandes articulaciones no erosiva e, incluso, afectación del sistema nervioso central y mayor incidencia de

trombosis venosas superficiales y profundas . se asocia al HLA B51.

¿Cuál de los siguientes hallazgos radiológicos es característico de la Espondilitis anquilosante?:

1. Rarefacción de la diáfisis ósea.
2. Osteofitosis vertebral.
3. Separación y engrosamiento del periostio.
4. Sindesmofitosis vertebral.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El hallazgo radiológico más frecuente (constante) en la espondilitis anquilosante es la sacroileitis. Entre las opciones que se te ofrecen los sindesmofitos son sin duda característicos de la enfermedad. Se trata de formaciones óseas finas, simétrica y uniformes que unen las vertebrae dando lugar a un aspecto característico. Cuando a esto se añade la osificación del ligamento vertebral común posterior aparece el aspecto característico de columna en caña de Bambú.

Paciente de 60 años diabético. Ingreso hospitalario hace 2 semanas por descompensación hiperosmolar. Consulta al Servicio de Urgencias por dolor y tumefacción en rodilla derecha. Exploración física: Tª 37,2°C, frecuencia cardíaca 100 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 18 por minuto, signos de artritis en las articulaciones referidas. Analítica: hemograma con 18000 leucocitos/mm3, ácido úrico 8,11 mg/dl, creatinina 1,4 mg/dL. Líquido sinovial: 20000 leucocitos/mm3 con 85% de polinucleares, no se observan microcristales y la tinción de gram no muestra gérmenes. ¿Cuál sería la actitud MÁS CORRECTA?

1. Practicar infiltración intraarticular con triamcinolona de la articulación afecta.
2. Iniciar tratamiento ambulatorio con amoxicilina más ácido clavulánico y valorar la respuesta en una semana.
3. Indicar ingreso y tratamiento antibiótico parenteral inmediato hasta resultado del cultivo.
4. Tratamiento con corticoides a dosis bajas y alopurinol.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Nos presenta un caso de un paciente diabético, que presenta una monoartritis aguda de rodilla derecha. Se realiza artrocentesis que evidencia un líquido inflamatorio con predominio de polimorfonucleares. No se evidencian cristales al microscopio y la tinción de Gram no muestra gérmenes. En este caso la actitud a seguir sería instaurar antibioterapia endovenosa hasta resultado de cultivo. Si bien el líquido infeccioso normalmente tiene celularidad >50000 células, nos dan datos que apoyan la posibilidad de que se trate de una infección tales como el predominio de polimorfonucleares en el líquido sinovial, la leucocitosis, febrícula, y el hecho de que el paciente sea diabético. La ausencia de gérmenes en la tinción de Gram NO descarta que se trate de una artritis séptica, por lo tanto habría que tratarla como tal (es decir con antibioterapia endovenosa) por la potencial gravedad de la misma hasta que obtengamos el resultado del cultivo.

La presencia en una biopsia de músculo estriado de un infiltrado inflamatorio intersticial y perivascular, con zonas de fibras degeneradas alternando con zonas de regeneración muscular, es característica de:

1. Miopatía esteroidea.
2. Esclerodermia.
3. Polimiositis.
4. Miositis de cuerpos de inclusión.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Esta pregunta profundiza en la anatomía patológica de las polimiositis, que si bien no es muy importante, tampoco es difícil de contestar. Debes saber que no es un trastorno primario muscular como las distrofias musculares (en las que no existe infiltrado inflamatorio intenso), sino que se debe a la propia inmunidad del individuo, por lo que el músculo es sano y capaz de defenderse, buscando la regeneración de fibras que fueron destruidas por los anticuerpos, linfocitos y células inmunes; estos agentes inmunes llegaron desde el vaso nutriente, de ahí que la distribución sea perivascular. La miositis por cuerpos de inclusión, aunque sea una miopatía inflamatoria, tiene una AP bien típica: gránulos basófilos en los bordes de vacuolas citoplasmáticas musculares. La miopatía de la esclerodermia es por desuso (contracturas por tirantez cutánea) en principio, sin existir destrucción de fibras. La miopatía esteroidea no es necrótica.

-----O-----

Mujer de 80 años con dolor en cintura pélvica y escapular de varias semanas de evolución, que presenta desde hace pocos días intensa cefalea que no cede con analgesia convencional. En la analítica solicitada a su llegada presenta elevación de VSG y de proteína c reactiva. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

1. Poliangeítis microscópica.
2. Enfermedad de Horton.
3. Granulomatosis de Wegener.
4. Arteritis de Takayasu.

Resp. Correcta: 2

Comentario: La arteritis de la temporal o enfermedad de Horton aparece típicamente en pacientes mayores de 55 años, cursando generalmente con un cuadro inespecífico astenia, anorexia, artralgias y malestar general, con cefalea refractaria a tratamientos habituales, siendo típica la asociación con la polimialgia reumática.

-----O-----

Varón de 66 años, fumador de 30 cigarrillos diarios durante más de 30 años, acude por presentar cuadro de pérdida ponderal involuntaria de 12 kg en los últimos tres meses. A la exploración inicial usted objetiva la presencia de osteoartropatía hipertrófica. Dado el anterior hallazgo, ¿cuál es el diagnóstico más probable?

1. Tuberculosis diseminada.
2. Cáncer de pulmón.
3. Neoplasia de vejiga.
4. Cáncer de colon.

Resp. Correcta: 2

Comentario: La osteoartropatía hipertrófica o acropaquias ("dedos en palillos de tambor") puede ser primaria, o más frecuentemente, secundaria, asociada principalmente a patología neoplásica torácica (pulmón, pleura), aunque la patología crónica pulmonar también puede producirla.

-----O-----

Respecto a los factores reumatoides, una de las siguientes afirmaciones NO es cierta:

1. Pueden aparecer en personas sanas.
2. Son inmunoglobulinas de la clase IgM, IgG o IgA.
3. La prueba del látex detecta factor reumatoide de clase IgG.
4. Son anticuerpos específicos para el fragmento Fc de la IgG.

Resp. Correcta: 3

Comentario: EL factor reumatoide es un autoanticuerpo dirigido contra epítopes localizados en el fragmento Fc de la inmunoglobulina G. Suelen ser anticuerpos de clase IgM, aunque pueden darse isotipos IgG, IgA e IgE. Existen otras enfermedades, aparte de la artritis reumatoide y el sde de Sjögren en donde puede observarse FR positivo: hepatopatías autoinmunes, sarcoidosis, endocarditis bacteriana subaguda, sífilis, leishmaniasis, paludismo, mononucleosis, tuberculosis..etc. La prueba de látex es una prueba de aglutinación mediante la cual se detecta Factor reumatoide IgM, que resulta una prueba muy poco específica, actualmente se prefieren métodos que permiten detectar y cuantificar los factores reumatoides

-----O-----

En la enfermedad relacionada con IgG4 se distinguen cuatro fenotipos según datos clínicos, epidemiológicos, serológicos y de respuesta al tratamiento. Cuál de los siguientes no es uno de ellos:

1. Enfermedad pancreática y hepato-biliar.
2. Fibrosis retroperitoneal y/o periaortitis.
3. Enfermedad limitada al tórax.
4. Forma sistémica (síndrome de Mikulicz).

Resp. Correcta: 3

Comentario:

ACR/EULAR definió en 2019, juntos con unos nuevos criterios clasificatorios, cuatro fenotipos clínicos con características diferenciales. Las cuatro formas son: enfermedad pancreática y hepato-biliar, fibrosis retroperitoneal y/o periaortitis, enfermedad limitada a cabeza y cuello (opción 3 correcta) y forma sistémica similar al síndrome de Mikulicz. Todas las formas son más frecuentes en varones mayores de 50 años excepto la forma limitada a cabeza y cuello, más frecuente en mujeres jóvenes. La elevación de IgG4 sérica es máxima en la forma sistémica y mínima o normal en la fibrosis retroperitoneal. La respuesta al tratamiento es buena en la afectación pancreática y hepato-biliar y la forma sistémica, mientras que los otros grupos suelen ser refractarios con persistencia/progresión de enfermedad fibrosante.

-----O-----

La marcada calcificación y osificación de los ligamentos paraespinales anteriores dando la imagen característica en "cera derretida" es típica de:

1. EA (espondilitis anquilosante).
2. Hiperostosis vertebral idiopática difusa.
3. Espondiloartrosis.
4. Osteomielitis vertebral.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La imagen característica que nos describen es propia de la hiperostosis anquilosante vertebral difusa (enfermedad de Forestier), un proceso frecuentemente asintomático propio de varones de edad avanzada (respuesta 2 correcta). Repasemos las demás opciones de respuesta:

- 1.- La lesión radiológica típica de la espondilitis anquilosante son los sindesmofitos, formaciones más “finas”, uniformes y simétricas.
- 3.- En la espondiloartrosis la lesión radiológica son los osteofitos.
- 4.- En la osteomielitis vertebral lo típico es la destrucción del disco intervertebral.

-----O-----

Mujer de 55 años que acude a su consulta por sequedad ocular y oral en los últimos seis meses. Usted solicita una serie de pruebas, cuyos resultados son: anticuerpos anti-Ro positivos, test de Schirmer de 2 mm en ojo izquierdo y 4 mm en ojo derecho, flujo salivar de 0,05 mL/minuto y biopsia de glándula salival menor con sialoadenitis linfocitaria focal. En cuanto al tratamiento, señale la opción CORRECTA:

1. Debe iniciarse un FAME lo antes posible, priorizando metotrexato.
2. Los colirios con ciclosporina mejoran la xeroftalmía.
3. Los anti-TNF han demostrado eficacia en formas graves.
4. La pilocarpina suele ser bien tolerada.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El síndrome de Sjögren (cuyos criterios diagnósticos definitorios cumple la paciente) no tiene un tratamiento estandarizado a diferencia, por ejemplo, de la artritis reumatoide. Se tratan por separado los diferentes síntomas. En el caso de los síntomas de sequedad mucosa, se utilizan lubricantes para cada mucosa. A nivel ocular el uso de colirios con ciclosporina se utiliza en los casos con insuficiente control con lágrimas artificiales (respuesta 2 correcta). Los anti-TNF no han demostrado eficacia en esta entidad, siendo rituximab de elección en caso de manifestaciones graves. La pilocarpina es un secretagogo de mecanismo colinérgico que suele presentar efectos adversos antes de alcanzarse las dosis máximas (rinorrea, sudoración, diarrea, urgencia miccional).

-----O-----

Mujer de 18 años con historia de asma bronquial, que consulta ante púrpura cutánea, artralgias y edemas en miembros inferiores. Presenta elevación de reactantes de fase aguda, filtrado glomerular normal y proteinuria en rango no nefrótico. En la radiología se observa un velamiento de los senos paranasales. Los anticuerpos anti citoplasma de neutrófilos (ANCA) y anticuerpos antinucleares (ANA) son negativos. ¿Cuál es el diagnóstico MÁS probable?

1. Lupus eritematoso sistémico con afectación renal.

2. Vasculitis tipo EGPA (granulomatosis eosinofílica con poliangeitis o síndrome de Churg-Strauss).
3. Púrpura de Schönlein-Henoch.
4. Granulomatosis con poliangeitis (enfermedad de Wegener).

Resp. Correcta: 2

Comentario: Pregunta compleja sobre vasculitis. Se presenta el caso de una chica joven con antecedentes de asma bronquial (asociación típica con la entidad presentada), púrpura palpable, artralgias, proteinuria y sinusitis aguda, con una inmunología negativa. La primera opción descartable es la nº1, puesto que no nos dan clínica sugestiva de LES y los ANA son negativos. El Schönlein-Henoch explicaría parte de la clínica pero no justificaría la sinusitis, tampoco se relaciona con los antecedentes y no nos explican un hecho concurrente que actúe como precipitante (fármacos, infecciones, etc). Entre la respuesta nº2 y la nº4 debemos inclinarnos más hacia la primera, pues la presencia de una granulomatosis eosinofílica es más probable en un paciente joven, nos justifica la clínica presentada y hasta en un 60 % de los casos los ANCA son negativos. En cambio, la granulomatosis con poliangeitis acostumbra a presentarse en pacientes más añosos, se relaciona con patología crónica de vía aérea superior (NO con asma bronquial) y acordaros que acostumbra a ser c-ANCA positiva (es raro que los ANCA sean negativos en ésta entidad).

-----o-----

¿Cuál NO es mecanismo causante de anemia en la ES?:

1. Déficit de hierro por hemorragias digestivas.
2. Anemia de trastornos crónicos.
3. Anemia hemolítica microangiopática.
4. Infiltración de la médula ósea por linfocitos T.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Esta pregunta no refleja lo más importante del tema, pero puede ayudarte a introducirte en él. Debes tener claro que la esclerosis sistémica progresiva es un proceso autoinmune en cierto sentido, pero no existe expansión clonal desmesurada de células inmunes como los linfocitos,? los fibroblastos son normales pero producen colágeno excesivo. Si existe anemia, será por ferropenia como en la población general; al tratarse de un trastorno crónico, puede darse esta anemia multifactorial; la anemia microangiopática es propia de las crisis renales esclerodérmicas, que cursan con HTA maligna; por último, el intestino delgado tiene un tránsito enlentecido, lo que facilita el íleo con sobrecrecimiento bacteriano, y las bacterias así desconjugan la unión de B12 al factor intrínseco o consumen factores fundamentales de la hematopoyesis.

-----o-----

Señale cuál de las siguientes asociaciones NO es correcta:

1. HLA-DR4 - AR.
2. HLA-DR3 - nefropatía por sales de oro.
3. HLA-B5 - enfermedad de Behçet.
4. HLA-B17 - espondilitis anquilosante.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La asociación de determinadas enfermedades con haplotipos del sistema HLA es una prueba la influencia que la predisposición genética tiene en la aparición de diferentes enfermedades.

Todas las espondiloartropatías se asocian al HLA-B27, entre ellas el síndrome de Reiter o la espondilitis

anquilosante (EA), y no a HLA-B17 [respuesta 5 correcta]. El aspecto concreto de ellas que parece asociarse más estrechamente al B27 es la extensión de la enfermedad en el esqueleto axial, especialmente en las sacroilíacas; así pues, siendo en la EA la afectación sacroilíaca constante, en esta enfermedad la asociación con el B27 es muy estrecha (90% de los casos son HLA-B27+).

La AR se asocia al DR4 y en menor medida al DR1.

La enfermedad de Behçet se asocia la HLA-DR5 y B5.

-----o-----

Mujer de 68 años, sin antecedentes de interés, que refiere dolor mecánico crónico en la rodilla derecha. Acude por mal control del dolor con paracetamol, metamizol y tramadol. A la exploración destaca derrame articular discreto. Usted solicita una analítica, una radiografía simple y realiza una artrocentesis diagnóstica. ¿Cuál de los siguientes es MENOS compatible con gonartrosis?

1. PCR y VSG normales.
2. Pérdida de la línea interarticular.
3. Pérdida de la filancia del líquido sinovial.
4. Glucosa 90 mg/dL en el líquido sinovial.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La artrosis u osteoartritis se caracteriza a nivel radiológico por una pérdida de la línea interarticular (tendencia al contacto entre superficies óseas), esclerosis subcondral, osteofitos y en algunos casos geodas. La analítica es anodina, con RFA con valores normales. La artrocentesis muestra un líquido de características normales o mecánicas (menos de 2.000 células/mm³ con predominio mononuclear, transparente, viscosidad conservada y niveles normales de glucosa - similar a la glucemia -, proteínas y lactato). La filancia permite medir cualitativamente la viscosidad y es la capacidad de un líquido de extenderse formando hilos; el líquido sinovial normal o mecánico es filante, propiedad que pierde cuando existe un proceso inflamatorio o infeccioso (marcamos la opción de respuesta 3).

-----o-----

¿Cuál de los siguientes sucesos puntúa MÁS en la escala de ACR/EULAR (2010) para la clasificación de la artritis reumatoide?

1. Afectación de entre 2 y 10 grandes articulaciones.
2. FR y/o Anti-CCP positivos a título bajo (< 3 veces del valor normal).
3. Duración de los síntomas $\geq$ 6 semanas .
4. VSG y/o PCR elevadas.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Pregunta puramente teórica. Las opciones de respuesta 1, 3 y 4 puntúan 1 punto, mientras que la positividad a título bajo de FR y/o anti-CCP puntúa 2 puntos (respuesta 2 correcta).

-----o-----

Un paciente de 80 años ingresa en el hospital por dolor lumbar de un mes de evolución, continuo, progresivo, que aumenta con los movimientos del tronco y en los últimos días se irradia por la cara externa del muslo hasta rodilla junto con febrícula de 37,5°C. Presenta antecedentes de hipertrofia prostática benigna y un ingreso hospitalario de sepsis de origen urinario dos meses antes. Sería urgente descartar:

1. Pielonefritis aguda.
2. Osteomielitis vertebral con absceso epidural.
3. Obstrucción de la vía urinaria con infección.
4. Proceso infeccioso retroperitoneal.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La osteomielitis implica la presencia de un foco séptico intraóseo. Las más frecuentes son las de origen hematógeno, pero en ocasiones se producen por focos infecciosos contiguos, como tal vez haya ocurrido en este caso clínico (a partir de una pielonefritis, ya que nos hablan de una sepsis de origen urinario hace dos meses). El carácter irradiado del dolor hace pensar en una posible afectación radicular, lo que da soporte a la sospecha diagnóstica de osteomielitis vertebral. El resto de las opciones tienen poco o ningún sentido, por las razones siguientes:

- R1: La pielonefritis difícilmente se llamará aguda después de dos meses de duración.

- R2: Un nuevo episodio de sepsis no duraría tampoco dos meses y la fiebre sería franca, con mucha mayor clínica sistémica.

- R4 y R5: Difícilmente explicarían la irradiación del dolor (tampoco lo hacen las otras dos respuestas falsas).

-----O-----

Un varón de 32 años refiere dolor, tumefacción e impotencia funcional en tobillo derecho en las últimas horas. En la exploración presenta fiebre de 38.2° C, aumento de volumen y temperatura y dolor a la palpación en la interlínea articular, limitación de la movilidad en todos los planos. La radiología sólo muestra aumento de partes blandas. Se realiza una artrocentesis en la que se obtienen 30 c.c. de líquido de aspecto turbio cuyo análisis demuestra 82.000 células/ml. de predominio polimorfonuclear, proteínas de 8 mg/dl, y glucosa de 5 mg/dl. No se observan cristales en el microscopio de luz polarizada ni microorganismos en la tinción de GRAM. La actitud correcta en este paciente sería:

1. Corticoides intrarticulares.
2. Alopurinol.
3. Antiinflamatorios no esteroideos.
4. Antibióticos intravenosos.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Es importante que sepas el diagnóstico de presunción de artritis séptica y la actitud a seguir. Ante un adulto joven con una monoartritis aguda y fiebre, debes pensar ya en una posible artritis séptica, y en concreto la gonocócica, sin olvidar que está a la par con el S.aureus. La artrocentesis es la primera prueba

a practicar, y muestra un evidente líquido infeccioso: turbio, con >50.000 células, mayoría neutrófilos, glucosa muy baja y proteínas elevadas por la intensa inflamación séptica. Aunque no se observen microorganismos con la tinción de gram, no se descarta el diagnóstico, se debe cultivar el líquido. La radiología no es un método de diagnóstico fiable, de presentar hallazgos estos serán tardíos. La clínica y el líquido compatible deben servir para iniciar un tratamiento empírico antibiótico i.v., nunca intraarticular, y debe drenarse el derrame diariamente por artrocentesis. No se han observado cristales de ácido úrico ni el líquido es meramente inflamatorio como para pautar AINES o colchicina o administrar corticoides (contraproducentes aquí). El alopurinol es tratamiento de base del paciente gotoso.

-----O-----

Una mujer de 23 años, con examen clínico normal el año previo, debuta con clínica de seis semanas de evolución de astenia progresiva y aumento de 5 kg de peso, edemas, HTA, hematuria, cilindros hemáticos, proteinuria (> 6 g/día), hipoalbuminemia y aumento del colesterol. La creatinina sérica es de 2,9 mg/dL. Los ANA y anti-DNA son positivos en títulos altos, junto a un descenso de los niveles del complemento. En la biopsia renal, señale cuál es el hallazgo MÁS esperable:

1. Glomerulonefritis proliferativa difusa.
2. Nefritis lúpica proliferativa focal.
3. Nefropatía membranosa.
4. Glomerulosclerosis focal y segmentaria.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Dentro de la nefropatía lúpica, la forma más grave es la proliferativa difusa, que también es la más frecuente en pacientes sintomáticos, como en este caso (respuesta 1 correcta). Recuerda que la más frecuente en asintomáticos es la GN lúpica mesangial.

-----O-----

Paciente de 27 años que acude a consulta con una historia de un año de duración de dolor en ambos glúteos, irradiado por cara posterior del muslo hasta su porción media. El dolor es peor al amanecer. Se acompaña de rigidez lumbar y mejora con el ejercicio. ¿Cuál de los siguientes procedimientos aportaría MÁS información diagnóstica en este paciente?

1. La velocidad de sedimentación y los niveles de proteína C reactiva.
2. La resonancia magnética de columna lumbar.
3. El tipaje HLA-B27.
4. La radiografía de las articulaciones sacroilíacas.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Cuadro clínico compatible con espondilitis anquilosante: varón joven con afectación de esqueleto axial (dolor en región glútea bilateral típicamente inflamatorio: peor en reposo y que mejora con el movimiento). Dado que la presencia de sacroileítis radiológica es imprescindible para el diagnóstico de EA, debemos solicitar en primer lugar una Rx de sacroilíacas (respuesta 4 correcta). En caso de ser normal, plantearíamos realizar una RMN, pero de articulaciones sacroilíacas. La VSG y PCR son inespecíficas, el tipaje HLA-B27

no es necesario para el diagnóstico, aunque también puede aportar información.

-----O-----

Mujer de 51 años con fenómeno de Raynaud de evolución progresiva en el contexto de esclerosis sistémica. Asocia componente de esclerodactilia y úlceras en los pulpejos de los dedos. Ha realizado tratamiento con amlodipino, crema con nitroglicerina, y se ha intentado tratamiento con sildenafil y bosentán que no ha tolerado por hipotensión. ¿Cuál de las siguientes considera la MEJOR opción para esta paciente?

1. Simpatectomía.
2. Epoprostenol.
3. Toxina botulínica.
4. Apixabán.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Caso clínico sobre una paciente con fenómeno de Raynaud y lesiones tróficas secundarias. Veamos las opciones de respuesta:

- 1.- La simpatectomía es un procedimiento invasivo, no exento de riesgos, por lo que parece adecuado intentar un tratamiento conservador.
- 2.- El epoprostenol es una prostaglandina con acción vasodilatadora que probablemente la paciente no tolere debido a sus antecedentes.
- 3.- Parece adecuado intentar un tratamiento conservador y que ha demostrado buenos resultados como es la inyección periódica de toxina botulínica (respuesta 3 correcta).
- 4.- El apixabán podemos descartarlo, ya que el fenómeno de Raynaud es un fenómeno vasomotor y no está indicada la anticoagulación por este motivo.

-----O-----

Con respecto a la enfermedad relacionada con IgG4, es FALSO que:

1. Se manifiesta como masas pseudotumorales.
2. Los niveles séricos de IgG4 pueden ser normales.
3. La falta de respuesta a corticoides debe hacernos replantear el diagnóstico.
4. Es más frecuente en mujeres en edad fértil.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La enfermedad relacionada con IgG4 engloba manifestaciones heterogéneas con implicación de diferentes órganos, con el rasgo común de presentarse como masas de aspecto neoplásico que resultan no serlo (masas pseudotumorales). A diferencia de la mayoría de las enfermedades autoinmunes, predomina en varones de 50-70 años (opción 4 falsa, por lo que la marcamos) aunque uno de los fenotipos de forma excepcional sí es más frecuente en mujeres jóvenes, especialmente asiáticas (forma limitada a cabeza y cuello). Los niveles séricos de IgG4 pueden ser normales, especialmente en formas fibrosantes predominantes (fibrosis retroperitoneal) o enfermedad avanzada en fase fibrótica. La falta total de respuesta a corticoides, aunque es posible en algunos fenotipos (fibrosis retroperitoneal), debe hacernos replantear el diagnóstico.

En los pacientes con osteoporosis esta enfermedad suele dar la cara por una parte por la aparición de fracturas tras traumatismos de bajo impacto (fracturas por fragilidad) pero ¿cuál es la fractura más frecuente?

1. Fractura de cadera
2. Fractura vertebral
3. Fractura de diáfisis de húmero
4. Fractura de Colles

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Pregunta muy sencilla sobre las fracturas asociadas a la osteoporosis, debes saber que su orden de frecuencia es:

vertebral > fémur > colles

-----O-----

Una paciente diagnosticada de esclerosis sistémica con positividad de anticuerpos anti-SCL-70 le pregunta sobre su enfermedad. Señale la afirmación FALSA:

1. Si el fenómeno de Raynaud no se controla con betabloqueantes, se pueden utilizar de forma compasiva otros vasodilatadores.
2. No tiene tratamiento específico.
3. Existe riesgo aumentado respecto la población general de desarrollo de hipertensión pulmonar.
4. Existe riesgo aumentado respecto la población general de adenocarcinoma de esófago.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La esclerosis sistémica (ES) no tiene tratamiento específico que altere la historia natural de la enfermedad porque su etiopatogenia, como en muchas enfermedades autoinmunes, es todavía incierta. En la práctica, se trata cada uno de los síntomas o complicaciones orgánicas. El fenómeno de Raynaud se trata con medidas higiénicas (evitar el frío) y fármacos vasodilatadores, siendo de inicio los calcioantagonistas, y después otros (inhibidores PDE 5 como sildenafil, antagonistas de la endotelina como bosentán). Los betabloqueantes están contraindicados porque son vasoconstrictores y empeoran la enfermedad (opción 1 falsa, por lo que la marcamos). Entre las complicaciones más frecuentes en la ES se encuentra el desarrollo de hipertensión pulmonar primaria o secundaria a EPID y las complicaciones derivadas de la hipotonía del esfínter esofágico inferior (ERGE grave, Barrett y adenocarcinoma de esófago).

-----O-----

Una paciente con AR seropositiva de larga evolución ha recibido tratamiento con D-penicilamina, Metotrexato, Leflunomida e hidroxicloroquina como tratamientos de base, con irregular control, precisando corticoides y AINEs de forma habitual. Presenta, desde hace meses, episodios diarreicos cada vez más habituales, astenia y adelgazamiento. Se le realiza una analítica por este motivo, en la que destaca un ligero empeoramiento de la función renal y proteinuria de 5 g diarios. ¿Qué opción le parece MÁS probable?

1. La paciente presenta una AR de larga evolución y mal control, probablemente ha desarrollado una amiloidosis secundaria.
2. El consumo de AINEs ha llevado a este empeoramiento de la función renal.
3. Probablemente presenta deshidratación en el contexto del cuadro diarreico.
4. El tratamiento con D-penicilamina ha desencadenado una glomerulonefritis de forma diferida.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La amiloidosis hay que sospecharla como complicación tardía de las enfermedades inflamatorias, especialmente aquellas con mal control a lo largo del tiempo. En la AR es típica la presentación como GMN membranosa y proteinuria en rango nefrótico, pudiendo afectar a otros órganos como el intestino (diarrea), o el hígado (colestasis).

-----O-----

Los cristales de oxalato calcio se observan en el microscopio de luz polarizada con:

1. Birrefringencia negativa.
2. Birrefringencia débilmente positiva y forma de aguja.
3. Birrefringencia fuertemente positiva y forma piramidal.
4. Sólo se observan en microscopio electrónico.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Los derrames sinoviales producidos por cristales de oxalato cálcico no suelen ser inflamatorios y hay menos de 2.000 células/mm³. En la mayoría de los casos los cristales son extracelulares pero también se han identificado dentro de los neutrófilos. El aspecto y birrefringencia de los cristales de oxalato cálcico es variable. Lo más frecuente es que sean bipiramidales y con birrefringencia muy positiva. Recuerda que la enfermedad que con más frecuencia se asocia a su depósito es la insuficiencia renal terminal.

-----O-----

¿Cuál es la causa más frecuente de oligoartropatía inflamatoria en un varón joven?:

1. La artritis reumatoidea.
2. La artritis gonocócica.
3. El síndrome de Reiter.
4. La hidrartrosis intermitente.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Puesto que la artritis reumatoide predomina en mujeres y suele comenzar entre los 35 y los 50 años la duda se establece entre la artritis gonocócica (que también predomina en mujeres y no es demasiado frecuente y la que es correcta que es la artritis reactiva. El reumatismo palindrómico se define por la presencia de ataques recurrentes de tumefacción dolorosa articular que suelen comenzar a partir de la tercera década de la vida. La hidrartrosis intermitente es un proceso poco habitual caracterizado por episodios recurrentes de tumefacción con una periodicidad fija sin evidencia de inflamación local ni sistémica. Suele encontrarse en mujeres jóvenes relacionado con la menstruación.

-----O-----

Deberemos iniciar tratamiento con corticoides sistémicos a dosis altas en el caso de:

1. Pinzamiento del seno costofrénico.
2. Uveítis posterior.
3. Afectación articular.
4. Lesiones cutáneas.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

-----O-----
Un ejemplo clásico de anfiartrosis lo constituye:

1. Articulación fémoro-tibial.
2. Articulación atlo-axoidea.
3. Sínfisis pubiana.
4. Articulación escapulo-humeral.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Las articulaciones cartilaginosas o anfiartrosis son aquellas que tienen poca movilidad, el ejemplo típico lo constituyen las sínfisis (compuestas por fibrocartilago), como son la pubiana y los discos intervertebrales. Sin embargo las articulaciones de huesos del cráneo son articulaciones inmóviles (sinartrosis), mientras que el resto de articulaciones que se mencionan en la pregunta son articulaciones sinoviales, o lo que es lo mismo: diartrodiales, que son articulaciones con gran movilidad.

-----O-----
¿Cuál de los siguientes es un antecedente próximo que se registra con cierta frecuencia en los pacientes con una fascitis eosinofílica?:

1. La ingesta de barbitúricos.
2. Una infección de vías respiratorias altas.
3. Una ingesta excesiva de alcohol.
4. Un ejercicio físico agotador no habitual.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Esta entidad no es importante dentro de los síndromes con esclerodermia. De recordar algo, esta pregunta es útil: tras un esfuerzo físico extenuante se presenta la fascitis en dos fases: la primera es de mera inflamación, y la segunda de franca esclerosis hasta capas profundas, con induración de la zona que acaba por comprimir el compartimento o generar contracturas. Todo ello se acompaña de eosinofilia en sangre, pero el diagnóstico certero se obtiene por biopsia desde la piel hasta la fascia. La ingesta de barbitúricos desencadena las crisis de porfiria aguda intermitente.

-----O-----
En un paciente de 50 años con condrocalcinosis, hipercalcemia de 14 mg/dl, proteínas de 6,2 mgr/dl y VSG de 7 mm/1ª hora pensaría en:

1. Mieloma múltiple.
2. Ocronosis.
3. Hiperparatiroidismo primario.
4. Hipofosfatemia.

Resp. Correcta: 3

Comentario: La mayoría de los pacientes que presentan condrocalcinosis son ancianos sin ninguna enfermedad asociada que presenten depósito de estos microcristales. Sin embargo, en sujetos de menos de 55 años debemos sospechar la presencia de una enfermedad metabólica que induce el depósito de estos cristales. Entre estas patologías se encuentran las "cuatro H": hiperparatiroidismo primario, hemocromatosis, hipofosfatasa e hipomagnesemia. La presentación del cuadro con hipercalcemia marcada es característica del hiperparatiroidismo primario. La única duda la puedes plantear con el mieloma pro date cuenta que el paciente no tiene elevación de proteínas ni de VSG.

¿Qué test serológico es el más específico de la artritis reumatoide?

1. ANA.
2. Anti DNA ds.
3. FR.
4. Anti CCP.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Señale la FALSA:

1. La artritis gotosa es muy rara en mujeres premenopáusicas.
2. El hallazgo radiológico de "erosiones óseas" es patognomónico de artritis gotosa.
3. La diarrea es un efecto secundario frecuente de la colchicina.
4. En la insuficiencia renal hay que disminuir la dosis de alopurinol.

Resp. Correcta: 2

Comentario: La primera respuesta nos recuerda que los estrógenos tienen un efecto uricosúrico y que por lo tanto la hiperuricemia es poco habitual en las mujeres premenopáusicas. En la segunda respuesta aparece el alcohol como sustancia que aumenta la producción de ácido úrico. Recuerda que las dietas hipercalóricas o ricas en purinas también lo hacen. La respuesta 3 es evidentemente la correcta, ya que la aparición de erosiones óseas no es patognomónica de la artritis gotosa ya que otras enfermedades inflamatorias articulares como la artritis reumatoide producen erosiones. La respuesta 4 nos recuerda que el efecto secundario más habitual de la administración de colchicina es la diarrea, y en la 5 que la dosis de alopurinol debe ajustarse al aclaramiento de creatinina. Cuando este es del 10- 50% la dosis se reduce un 50% y cuando el aclaramiento es menor del 10% se reduce al 25%.

Los siguientes fármacos pueden producir un síndrome parecido al Lupus Eritematoso Sistémico, EXCEPTO uno:

1. Desferrioxamina.
2. Isoniacida.
3. Hidralacina.
4. Procainamida.

Resp. Correcta: 1

Comentario: El cuadro de lupus inducido por fármacos es una situación derivada de la toma de un fármaco (con más frecuencia procainamida e hidralacina) que al cabo de unos meses genera la producción de anticuerpos y en algunos sujetos síntomas similares al lupus eritematoso sistémico. Otros fármacos que se han relacionado con menor frecuencia son la isoniazida, clorpromazina, D- penicilamina, metildopa, quinidina, interferon alfa, hidantoinas, etosuximida y anticonceptivos orales. Estos síntomas suelen ser generalmente leves (astenia, febrícula, artritis, serositis o alteraciones hematológicas) careciendo de manifestaciones graves como la nefritis, afectación pulmonar o neurológica.

-----O-----

No es propia de la esclerosis sistémica cutánea difusa una de las siguientes características:

1. Fenómeno de Raynaud de reciente aparición.
2. Curso lentamente progresivo.
3. Asociación con anticuerpos anti SCL-70 (antitopoisomerasa).
4. Enfermedad pulmonar intersticial como principal causa de muerte.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

-----O-----

Señale la verdadera sobre la PAN clásica:

1. Hasta un 30% presentan antígeno HBs positivo.
2. Los microaneurismas en arterias viscerales son patognomónicos de PAN clásica.
3. La HTA es poco frecuente.
4. En series de autopsias la afectación muscular es más frecuente que la renal.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Esta es una pregunta bastante sencilla con respecto a la PAN clásica. Recuerda que es una enfermedad asociada con al VHB en un 30% (más que la PAN microscópica), al VHC en un 5% y que se han descrito casos asociados a tricoleucemia. Es una vasculitis de pequeño y mediano vaso en la que la afectación mas frecuente es la renal, con desarrollo de una isquemia glomerular, con HTA e insuficiencia renal y la musculoesquelética; sin embargo, la mayoría de las veces sólo se presenta como artralgias o mialgias, por lo que no se demuestra afectación patológica, aunque pueden presentar una verdadera miopatía y artritis. Los microaneurismas son bastante característicos de esta enfermedad, ayudando al diagnóstico ante cuadros compatibles en aquellos casos en los que no podemos tener un diagnostico anatomopatológico, pero en absoluto son patognomónicos de la enfermedad. En cuanto a la afectación neurológica, mientras que la aparición de neuropatía periférica es una de las más frecuentes (aprox. un 50%), la afectación del SNC es extremadamente rara.

-----O-----

¿Cual de las siguientes complicaciones no se asocia a espondilitis anquilosante?

1. Luxación atloaxoidea
2. Uveítis anterior
3. Fibrosis pulmonar biapical

4. Dilatación de raíz aórtica

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Es muy importante que sepas que la subluxación atloaxoidea es una complicación típica de la AR no de la espondilitis anquilosante, por ello la opción que debes marcar en esta pregunta es la 1

-----O-----

Una mujer de 75 años consulta por lesiones violáceas en manos y cuello junto a debilidad muscular progresiva de tres meses de evolución. ¿Qué prueba diagnóstica, entre las que se indican, puede ser de utilidad para el diagnóstico?

1. Determinación de aldolasa sérica.
2. Electroencefalograma.
3. Biopsia de tejido celular subcutáneo.
4. Determinación de anticuerpos antimúsculo liso.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Plantean en esta pregunta a una paciente con debilidad muscular y lesiones cutáneas asociadas de coloración violácea. Las lesiones más características en esta enfermedad son el eritema en heliotropo que describen en esta pregunta y las placas de Gottron, de aspecto eritematoso sobre la superficie extensora de los dedos. Ante esta presentación, la sospecha es una dermatopolimiositis, por lo que en primer lugar deberemos determinar enzimas musculares como la aldolasa (que estarán elevadas), y realizar posteriormente un electromiograma y una biopsia muscular para confirmar el diagnóstico. Por lo tanto la opción de respuesta correcta es la 1, primera prueba a realizar en este caso.

-----O-----

Leyendo los antecedentes de un paciente, describen una vasculitis de pequeño vaso con anticuerpos ANCA negativos. ¿Cual de las siguientes enfermedades no sospecharía como antecedente del paciente?

1. Púrpura de Schönlein-Henoch.
2. Vasculitis leucocitoclástica.
3. Poliangeítis microscópica.
4. Vasculitis crioglobulinémica.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Las vasculitis de pequeño vaso ANCA negativo son la vasculitis IgA o púrpura de Schönlein-Henoch, la vasculitis crioglobulinémica y la vasculitis cutánea leucocitoclástica. La poliangeítis microscópica afecta a vasos de pequeño calibre, sin embargo es ANCA positivo.

-----O-----

Respecto a la epidemiología del LES, ¿cuál de los siguientes grupos es el más afectado?:

1. Varones mayores de 50 años.

2. Mujeres de raza negra.
3. Mujeres de raza blanca.
4. Niños menores de 7 años.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad que aparece con mayor frecuencia en mujeres jóvenes en edad fértil, aunque también se observan casos en niños, varones o ancianos. El marcado predominio femenino global de la enfermedad (9:1) se atenúa en estas situaciones (5:1 en la infancia y 3:1 en los mayores de 65 años). La enfermedad tiene una distribución mundial, aunque no todas las razas presentan la misma frecuencia. En Estados Unidos, se ha observado que el LES es tres veces más frecuente, y también más agresivo, en la raza negra. Por lo tanto, la respuesta que indica mayor afectación en las mujeres de raza negra es la correcta.

-----O-----

Mujer de edad media con historia de asma infantil que, tras una infección respiratoria de vías altas, es remitida a Urgencias por crisis de broncoespasmo grave. Se le realiza una radiografía de tórax que objetiva infiltrados pulmonares bilaterales y una analítica que demuestra una proteinuria y anemia. La presencia de una intensa eosinofilia en sangre periférica, junto con el carácter fugaz de los infiltrados en control radiológico posterior evolutivo, nos orienta a una entidad diagnóstica. Señálela la opción CORRECTA:

1. Angéitís alérgica o granulomatosa de Churg-Strauss.
2. Síndrome de Loeffler.
3. Aspergilosis broncopulmonar alérgica.
4. Granulomatosis de Wegener.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La eosinofilia podría hacernos pensar en las opciones de respuesta 1, 2 y 3, aunque clínicamente encajaría con una enfermedad de Churg-Strauss, ya que es la única que explicaría la anemia y la proteinuria (respuesta 1 correcta).

-----O-----

Acude a consultas Mariano, un varón de 81 años, refiriendo que desde hace unos meses se encuentra más cansado y ha perdido peso. Nos comenta que cada vez le cuesta más levantarse del sofá y que no llega a coger los botes de las estanterías más altas de la cocina. En la analítica refleja un aumento de la VSG y una hemoglobina de 8,6 g/dl, el factor reumatoide y anti CCP son negativos. Señale la respuesta verdadera respecto a la enfermedad que padece Mariano.

1. Cuando esta enfermedad aparece aislada, sin estar asociada a la arteritis de la temporal, es muy característica la afectación ocular sin afectación visceral.
2. Cuando esta enfermedad aparece aislada, sin estar asociada a la arteritis de la temporal, debe ser tratada con esteroides a altas dosis, para prevenir el desarrollo de complicaciones oculares.

3. La presencia de factor reumatoide o anti CCP van a favor del diagnóstico de polimialgia reumática, por lo que en este paciente debemos descartarla.
4. La respuesta al tratamiento con corticoides es espectacular, pero son frecuentes las recidivas con la bajada de dosis.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Se trata de un paciente con una polimialgia reumática, que presenta impotencia funcional de cintura escapular (no lleva a coger los botes de las estanterías altas) y pelviana (le cuesta levantarse desde la sedestación); aumento de la VSG y anemia. Cuando se asocia con la arteritis de la temporal es cuando hay afectación ocular (respuesta 1 falsa) y el tratamiento se basa en corticoides a altas dosis (respuesta 2 falsa). La presencia de factor reumatoide o anti CCP van en contra del diagnóstico de esta enfermedad (respuesta 3 falsa). La respuesta 4 es verdadera.

-----O-----

¿Cuál de las siguientes enfermedades no se corresponde con una espóndiloartritis?

1. Artritis psoriásica.
2. Espondilitis anquilosante.
3. Enfermedad de Horton.
4. Artritis reactiva.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Las espondiloartropatías incluyen las siguientes enfermedades:

- Espondilitis anquilosante.
- Artritis reactiva.
- Artritis psoriásica.
- Artritis de la EII.
- Espondiloartritis de inicio en la infancia.
- Espondiloartropatías indiferenciadas.
- Síndrome SAPHO.

La enfermedad de Horton o arteritis de la temporal se trata de una vasculitis.

-----O-----

Ante una paciente con artritis reumatoide, la aparición de sensación de cuerpo extraño en la garganta, ronquera, dolor en la cara anterior del cuello y disfagia hace sospechar la presencia de:

1. Artritis cricoaritenoidea.
2. Nódulos reumatoides en laringe.
3. Tiroiditis autoinmune.
4. Artritis temporomandibular.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La afectación cricoaritenoidea en pacientes con AR produce dolor en la cara anterior del cuello y ronquera. Aparece en un 30% de los casos. En fases avanzadas, la limitación de la movilidad puede favorecer la broncoaspiración. La obstrucción de la vía respiratoria superior también es posible si coexiste con infecciones respiratorias. La tiroiditis de Hashimoto puede coexistir con otros procesos autoinmunes como la AR y especialmente con el Síndrome de Sjögren. La clínica podría ser parecida pero no encontraríamos ronquera y sí bocio palpable y doloroso. La afectación de la columna cervical suele producir dolor en la parte posterior del cuello y puede dar lugar a síntomas de compresión medular o bien a disfunción de fosa posterior (síntomas cerebelosos, como disartria, etc...). Los nódulos reumatoides, que pueden localizarse (aunque infrecuentemente) en la laringe suelen ser indolores.

-----o-----

Un paciente varón, drogadicto por vía parenteral y en tratamiento con zidovudina, 3TC (lamivudina) y saquinavir ingresa con cuadro febril de origen desconocido. Los hemocultivos, incluidos los de larga incubación, son negativos. Es instaurada antibioterapia empírica de amplio espectro y finalmente anfotericina B intravenosa por sospecha de inmunodepresión. Como complicación, presenta monoartritis séptica de rodilla. Señale la opción incorrecta: INCORRECTA:

1. El diagnóstico probable es artritis candidiásica que, junto con la blastomicótica, es de rápida progresión. En el resto de las artritis micóticas el diagnóstico puede demorarse meses.
2. En caso de histoplasmosis, se observa una poliartritis migratoria con eritema nudoso.
3. En la blastomycosis, es frecuente la manifestación articular aislada. Rara vez en el contexto de un síndrome pulmonar-cutáneo-artrítico.
4. En caso de extensa formación de pannus granulomatoso articular, es útil el tratamiento quirúrgico.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Pregunta difícil sobre infecciones oportunistas del inmunodeprimido. Blastomyces dermatitidis es un hongo que causa infecciones similares a Histoplasma capsulatum. Su clínica característica es, al contrario de lo que se afirma en la respuesta 3, un síndrome pulmonar-cutáneo-artrítico, caracterizado por:

- Afectación ósea lítica, que produce dolor óseo o articular
- Infección respiratoria tipo neumonía aguda, neumonitis crónica o SDRA
- Lesiones ulceradas en piel, con pequeñas úlceras en los márgenes

-----o-----

El colágeno predominante en el hueso, membrana sinovial y tendones es de tipo:

1. I.
2. II.
3. IV.

4. V.

Resp. Correcta: 1

Comentario: La membrana sinovial se compone de una capa de tejido conectivo formada por colágeno tipo I y III aparte de otros componentes y una capa de células o sinoviocitos. El hueso está formado por una matriz celular y células; las fibras de colágeno tipo I constituyen el 90% de la matriz. El tipo I también es el principal tipo de colágeno de estructuras tendinosas, mientras que el tipo II es el principal tipo de colágeno del cartílago articular.

-----o-----

Enferma de 32 años que cuando acude a la consulta refiere que hace unos 20 días, después de una exposición solar, le aparece en la zona externa, hombros, brazos y región escapular, unas lesiones anulares, eritematoedematosas en su borde y con regresión central, algunas confluentes de dos o tres centímetros de diámetro que apenas le ocasionan molestias. El diagnóstico sería:

1. Eritema polimorfo.
2. Liquen plano.
3. Porfiria hepatocutánea.
4. Lupus eritematoso cutáneo subagudo.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Mujer joven y fotosensibilidad nos debe hacer pensar en LES. Eso no quiere decir que lo tenga (porque para el diagnóstico es necesario un número mínimo de criterios clínicos y de laboratorio que en el enunciado no vienen), pero orienta el caso y la pregunta. La localización y características de las lesiones que describe este caso son típicas del lupus eritematoso cutáneo subagudo.

-----o-----

¿Cuál de estos NO es criterio admitido por el ACR para la clasificación de la AR?:

1. Rigidez matutina de más de una hora.
2. Factor reumatoide positivo.
3. Derrame pleural.
4. Radiografía de manos y muñecas con osteoporosis yuxtaarticular y erosiones óseas.

Resp. Correcta: 3

Comentario: El diagnóstico de AR se establece por la coexistencia de 4 de los 7 criterios diagnósticos propuestos por la ACR para el diagnóstico de la enfermedad. Estos son : - Rigidez articular después de la inactividad de al menos 1 hora de duración. - Afectación poliarticular (al menos tres áreas articulares de forma simultánea) - Distribución simétrica de la afectación articular. - Participación de las articulaciones de las manos (MCF, IFP, Carpo). - Nódulos subcutáneos. - Presencia de Factor Reumatoide. - Alteración radiológica (erosiones, osteoporosis yuxtaarticular). La única manifestación extrarticular que es un criterio diagnóstico son los nódulos reumatoideos.

-----o-----

El hueso, eso es respecto rígido, es un tejido dinámico, entonces la actividad para el

remodelado óseo. Respecto remodelado óseo ¿cuál de las siguientes afirmaciones es falsa?

1. El marcador principal de los osteoclastos es la fosfatasa alcalina
2. Las células principales de la fase de formación son los osteoblastos
3. Los osteofitos son los principales reguladores de la fase de mineralización
4. La vitamina D tiene especial relevancia en la fase de mineralización

Resp. Correcta: 1

Comentario: Pregunta muy sencilla sobre los aspectos más básicos de la fisiología del hueso, por lo tanto, si has fallado esta pregunta debes acudir nuevamente al manual y repasar estos conceptos

-----O-----

Una mujer de 45 años consulta por fiebre, disnea, tos, *rash* cutáneo, diarrea y disminución de sensibilidad en la pierna derecha de dos meses de duración. Tiene antecedentes de rinitis y asma con control difícil desde hace 15 años. Sigue tratamiento con corticoesteroides orales frecuentemente, con buena respuesta. En la exploración presenta nódulos subcutáneos en superficies extensoras de miembros superiores, sibilancias en la auscultación respiratoria y déficit sensitivo en pierna derecha. En el hemograma presenta: hematocrito 36%, leucocitos 12.500 con un 38% de eosinófilos. La función renal y el análisis de orina son normales. En la radiografía de tórax se aprecian infiltrados alveolares parcheados. ¿Cuál de los siguientes diagnósticos es el MÁS probable?

1. Granulomatosis alérgica de Churg-Strauss.
2. Neumonía eosinófila crónica.
3. Síndrome hipereosinófilo.
4. Poliartritis nodosa.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Caso clínico típico de enfermedad de Churg-Strauss (recuerda que también se denomina angeítis y granulomatosis alérgica). La paciente presenta asma de difícil control, eosinofilia, infiltrados bilaterales migratorios no cavitados y presencia en este caso de mononeuritis (respuesta 1 correcta).

-----O-----

Los anticuerpos c-ANCA son anticuerpos dirigidos contra la proteinasa 3, mostrando patrón citoplasmático. ¿En que enfermedad típicamente se elevan, presentando una buena sensibilidad y especificidad para su diagnóstico?

1. Granulomatosis eosinofílica con poliangeítis.
2. Panarteritis nodosa.
3. Granulomatosis con poliangeítis.
4. Enfermedad de Horton.

Resp. Correcta: 3

Comentario: Los anticuerpos c-ANCA presentan una sensibilidad y especificidad del 90% para el diagnóstico de la granulomatosis de Wegener o granulomatosis con poliangéitis; aunque también pueden elevarse en la micro PAN, la policondritis recidivante o en algunas glomerulonefritis.

-----O-----

Paciente de 35 años diagnosticada de esclerosis sistémica desde hace 3 años. Acude por encontrarse notablemente más cansada desde hace 48 horas, justo desde que recibió una dosis de corticoides por una reacción alérgica. En la analítica, nos llama la atención una hemoglobina de 10 g/dl y a la exploración se ausculta un roce pericárdico. Dada la posibilidad diagnóstica ¿cuál sería la actitud terapéutica?

1. Ninguna. Todos los síntomas actuales son consecuencia del fenómeno alérgico parecido.
2. Aumentar la dosis de corticoides.
3. Ante la posibilidad de una crisis hipertensiva esclerodérmica, comprobar cifras de tensión arterial. Si estuvieran elevadas, tratamiento con IECAS
4. Se trata de una serositis aislada en el contexto de su enfermedad de base. Tratamiento con corticoides e inmunosupresor.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Nos describen una posible crisis hipertensiva en el contexto de una paciente con esclerosis sistémica. Estas crisis pueden estar desencadenadas por tratamientos con dosis bajas de corticoides, siendo hace años la primera causa de muerte en estas enfermas. La aparición de anemia hemolítica y de pericarditis (nos hablan de un supuesto roce pericardio a la exploración) pueden preceder a la crisis. El tratamiento con IECAS ha mejorado notablemente la mortalidad de esta complicación.

-----O-----

Con respecto a la afectación articular en la AR, señale cuál de las siguientes afirmaciones es FALSA:

1. La afectación articular suele ser simétrica.
2. Las articulaciones IFP (interfalángicas proximales) y MCF (metacarpofalángicas) son las primeras en afectarse.
3. Las IFD (interfalángicas distales) se afectan con frecuencia.
4. La sinovitis de la muñeca es habitual a lo largo de la enfermedad.

Resp. Correcta: 3

Comentario: La afectación articular de la AR es la manifestación clínica mas trascendente y común de la enfermedad. Como norma general recuerda que las articulaciones más frecuentemente afectadas son las distales, especialmente las articulaciones de las manos (metacarpofalángicas, interfalángicas proximales y carpos, por este orden). Curiosamente las interfalangicas distales no se suelen afectar. La afectación del carpo puede producir compresión del nervio mediano dando lugar al síndrome del tunel del carpo, caracterizado por las parestesias y el dolor en los tres primeros dedos y el borde radial del cuarto dedo.

-----O-----

Mujer de 19 años que acude a Urgencias por un cuadro de varios días de evolución. El proceso comenzó hace una semana con la inflamación de la rodilla derecha, que

terminó por resolverse. Posteriormente presentó inflamación de cadera izquierda y tobillo derecho, resolviéndose estos también. Coincidiendo con dichos episodios la paciente refiere fiebre elevada y unas lesiones que nos enseña a través de una foto identificándose como vesiculopústulas. Actualmente, el dolor está limitado a la cadera derecha, habiendo desaparecido las lesiones cutáneas. ¿Cuál sería la MEJOR prueba diagnóstica?

1. Cultivo en medio Thayer Martin del exudado cervical.
2. Cultivo en medio Thayer Martin de los hemocultivos extraídos.
3. Serología para *Chlamydia trachomatis*.
4. Artrocentesis y visualización de los posibles cristales con el microscopio óptico.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

Caso clínico típico de una artritis gonocócica. El perfil de la paciente ya nos da una pista: mujer de 19 años. Inicialmente nos cuentan una primera fase diseminada: artritis migratoria, con fiebre elevada y vesiculopústulas. En un segundo momento, nos cuentan cómo la paciente termina presentando una monoartritis aguda en cadera derecha, desapareciendo las lesiones cutáneas. Teniendo claro el diagnóstico, descartamos la artritis reactiva y la artritis por microcristales. Entre las opciones de respuesta 1 y 2, nos preguntan cuál es la MEJOR prueba. Tanto en la fase diseminada como en la localizada, lo más adecuado, si se puede, es hacer un exudado cervical/uretral (respuesta 1 correcta). Además la opción 2 no tendría sentido en este caso, ya que parece que la fase diseminada ya ha concluido (y los hemocultivos serían negativos).

-----O-----

Siguiendo en consulta a un paciente diagnosticado de enfermedad de Behçet, tratado previamente con AINEs, no presenta buena evolución clínica, por lo que decide inicio de metotrexato. En la siguiente revisión aprecia que el paciente no presenta la evolución clínica esperada. ¿Qué tratamiento emplearía en el momento actual para el control de la enfermedad?

1. Anti-IL1.
2. Anti-TNF.
3. Anti-CD20.
4. Anti-IL6.

Resp. Correcta: 2

Comentario: En casos leves de enfermedad de Behçet está indicado el tratamiento con AINEs o colchicina. Cuando no existe un correcto control con estos fármacos el siguiente escalón consiste inmunosupresores como ciclosporina o metotrexato. En los caso refractarios a estos fármacos está indicado el tratamiento con anti-TNF.

-----O-----

¿Cuál de los siguientes criterios diagnósticos es compartido por el LES y el síndrome antifosfolípido?:

1. Determinación mediante ELISA de anticuerpos anticardiolipina.
2. Trombocitopenia.

3. Trombosis venosa profunda.
4. Exantema malar.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

El diagnóstico del síndrome antifosfolípido se basa en la presencia de una manifestación clínica y una alteración analítica entre los siguientes criterios:

Manifestaciones clínicas:

- Trombosis arterial o venosa
- Abortos o muertes fetales de repetición

Alteraciones analíticas:

- Anticuerpos anticardiolipina IgG o IgM
- Anticoagulante lúpico
- Anti-beta2-glicoproteína 1

De entre las opciones que nos ofrece la pregunta, el diagnóstico de lupus eritematoso también incluye la determinación de anticuerpos anticardiolipina, que es la forma habitualmente utilizada de detectar los anticuerpos antifosfolípido. La cardiolipina es el fosfolípido que está más presente en el organismo, y por ello se utiliza como sustrato para la determinación de anticuerpos antifosfolípido.

-----o-----

En la enfermedad de Paget las manifestaciones articulares se caracterizan por tener un dolor:

1. Inflamatorio.
2. Nocturno.
3. Continuo.
4. Lancinante.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Esta es una pregunta difícil de la enfermedad de Paget, enfermedad importante de la que debes quedarte con lo básico. El dolor óseo inicial es lancinante (recuerda que esta era una característica típica de la neuralgia del trigémino), aunque puede no existir dolor en absoluto y ser detectado de forma casual por la elevación de fosfatasa alcalina, factor de formación ósea. Además del dolor lancinante, no relacionado con el movimiento, localizado en espalda, extremidades y cabeza, recordar que se aprecia calor local y deformidades en fases avanzadas. El dolor nocturno es típico de la espondilitis anquilosante, el dolor inflamatorio de la artritis reumatoide, y el dolor mecánico de la artrosis (que mejora con el reposo y empeora con el movimiento). El aumento de dolor debe alertarnos de osteosarcoma.

-----o-----

Si tuviéramos que clasificar la arteritis de la temporal; ¿cuál sería la forma más correcta de hacerlo?

1. Vasculitis de gran vaso necrotizante.
2. Vasculitis de mediano vaso granulomatosa.

3. Vasculitis de gran vaso granulomatosa.
4. Vasculitis de gran vaso granulomatos y necrotizante.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

-----O-----

Delos siguientes casos, ¿cuál es diagnóstico de síndrome antifosfolípido?

1. Varón de 50 años con trombosis venosa profunda de repetición.
2. Mujer de 32 años con 2 abortos espontáneos en las semanas 7 y 9, y determinación única de antibeta2 glicoproteína 1 positiva.
3. Mujer de 29 años con trombosis venosa profunda, 1 aborto espontáneo en la semana 4 y una única determinación de anticoagulante lúpico positivo.
4. Varón de 55 años con trombosis venosa profunda y dos determinaciones positivas de anticuerpos anticardiolipina.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El diagnóstico del síndrome antifosfolípido se establece mediante los siguientes criterios:

Criterios clínicos:

- Trombosis arterial o venosa.
- Abortos (1 o más abortos después de la semana 10; 3 o más abortos consecutivos antes de la semana 9; 1 o más abortos después de la semana 34 debido a eclampsia o preeclampsia).

Criterios analíticos:

- 2 o más determinaciones positivas espaciadas al menos 12 semanas de anticuerpos anticardiolipina, anticoagulante lúpico o anti-beta2-glicoproteína 1.

Para establecer el diagnósticos son necesarios al menos 1 criterio clínico y 1 criterio analítico.

-----O-----

En consulta acude una mujer de 56 años para estudio de osteoporosis. Dentro de las pruebas que le solicita se realiza una densitometría ósea donde presenta un T-score de -2.3. Ante este resultado, ¿Cómo lo interpretaría y que tratamiento recomendaría?

1. Se considera un resultado normal, por lo que no requiere tratamiento específico.
2. El resultado es compatible con osteopenia, por lo que el tratamiento consistiría en evitar factores de riesgo y en mantener una dieta equilibrada.
3. El resultado es compatible con osteoporosis, por lo que comenzaría tratamiento con denosumab.
4. El resultado es compatible con una osteoporosis grave, por lo que comenzaría tratamiento inmediato con bifosfonatos.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La prueba de elección para el diagnóstico de osteoporosis es la densitometría ósea. Con esta prueba se obtiene un resultado, denominado T-score, siendo normal cuando se encuentra entre +1 y -1, osteopenia entre -1 y -2.5, osteoporosis por debajo de -2.5, y osteoporosis grave cuando se encuentra por debajo de -2.5 y se acompaña de fractura por fragilidad. El tratamiento de elección para la osteoporosis son los bifosfonatos.

-----o-----

En relación con la artrogriposis múltiple congénita, es FALSO que:

1. Los niños con artrogriposis tienen una sensibilidad e inteligencia anormal.
2. Es frecuente que los codos estén en extensión y las muñecas con importante contractura.
3. Los pies casi siempre están afectados, lo más frecuente es un pie zambo rígido.
4. Las rodillas se encuentran normalmente en extensión o en algún caso en flexión.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Esta pregunta es realmente difícil y la artrogriposis no es un tema relevante, no le prestes demasiada atención. La artrogriposis se caracteriza por la sustitución de músculo estriado por tejido fibroso, y por la presencia de contracturas de tejidos blandos. Ello ocasiona la pérdida de movimiento que llega a ser incapacitante en muchas articulaciones, acompañado de luxación de cadera y pie zambo severo. Los codos están fijados en extensión y las muñecas en flexión. Los músculos respiratorios al afectarse pueden desembocar en una insuficiencia respiratoria. Como es un problema ajeno al sistema nervioso, la sensibilidad y la inteligencia son normales.

-----o-----

Acude a Urgencias un varón de 56 años, sin antecedentes de interés, que refiere dolor e inflamación de la rodilla derecha desde hace 6 horas. Niega traumatismo previo. A su valoración presenta clara inflamación de la rodilla derecha, siendo el resto de la exploración anodina. ¿Qué pruebas solicitaría a continuación para el diagnóstico del paciente?

1. Examen de líquido sinovial.
2. Hemograma y bioquímica de sangre, con determinación de reactantes de fase aguda.
3. Radiografía simple de rodilla.
4. Resonancia magnética de rodilla.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

-----o-----

Un varón de 37 años de edad comienza en el seno de un brote de su enfermedad lúpica con alteraciones del comportamiento. Un psiquiatra valora el cuadro como presunta psicosis lúpica. Por favor, señale el enunciado INCORRECTO respecto a lo citado, entre los siguientes:

1. Hasta el 60% de los pacientes con LES presentan algún tipo de alteración del sistema nervioso.
2. El LCR suele mostrar elevación de proteínas y células mononucleares.

3. En el caso de déficit neurológico focal, la TAC y la angiografía pueden ser diagnósticas.
4. Una vez tratado correctamente el proceso, no se observan recidivas.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

El 60% de los pacientes con LES presentan alguna alteración del sistema nervioso, pudiéndose afectar cualquier región del encéfalo, meninges, médula espinal y nervios craneales o periféricos. En el 50% de los pacientes, se observan alteraciones en el LCR con elevación de proteínas y células mononucleares.

La RMN es la técnica más sensible para detectar lesiones agudas o crónicas en el LES. Los pacientes con lesiones focales tienen más posibilidades de que la RMN sea positiva que aquellos con manifestaciones difusas. La TAC es útil para descartar hemorragia o una lesión ocupante de espacio. La angiografía permite detectar vasculitis y oclusiones o émbolos vasculares.

Habitualmente, los problemas neurológicos mejoran con el tratamiento (con excepción de los déficits secundarios a infartos). Sin embargo, las recidivas se observan en la tercera parte de los pacientes. Esto podrías haberlo intuido con relativa facilidad, ya que el lupus es una enfermedad que cursa en brotes.

-----O-----

En el estudio histopatológico de la sinovial reumatoide es muy característica la presencia de:

1. Vasculitis necrosante.
2. Hiperplasia de condrocitos.
3. Infiltración de linfocitos y células plasmáticas.
4. Granulomas de cuerpo extraño.

Resp. Correcta: 3

Comentario: La anatomía patológica de la AR muestra hiperplasia e hipertrofia de las células de la membrana sinovial, alteraciones vasculares locales o segmentarias como la neoformación vascular o la trombosis), edema e infiltración por células mononucleares principalmente linfocitos T (CD4). Tanto las células CD4 como CD8 expresan el antígeno de activación inicial CD69. Además en la membrana sinovial de la AR se encuentran linfocitos B que se diferencian hacia células plasmáticas productoras de anticuerpos.

-----O-----

¿Cómo se denominan los nódulos artrósicos que aparecen en articulaciones interfalángicas distales en manos?

1. Nódulos de Heberden.
2. Nódulos de Bouchard.
3. Nódulos de Montgomery.
4. Nódulos reumatológicos.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La forma nodal se caracteriza por la presencia de nódulos de Heberden (a nivel de IFD) y de Bouchard (a nivel IFP). Las dos últimas opciones no existen.

Cuál de las siguientes afirmaciones acerca de las vasculitis de pequeño vaso es falsa:

1. La vasculitis leucocitoclásica se presenta como púrpura palpable y es ANCA negativa.
2. La granulomatosis eosinofílica con poliangeítis (GEPa) suele presentarse como un paciente con asma de difícil control e infiltrados pulmonares migratorios.
3. La poliangeítis microscópica (PAM) suele presentar p-ANCA y afecta en forma de capilaritis pulmonar y glomerulonefritis a pacientes de edad avanzada.
4. La vasculitis IgA suele presentarse como dolor articular, dolor abdominal, púrpura palpable y afectación renal en forma de síndrome nefrítico.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Las vasculitis de pequeño vaso (VPV) más frecuentes, con diferencia, son las predominantemente cutáneas (conocidas como leucocitoclásticas) que se manifiestan como púrpura palpable en miembros inferiores con autoinmunidad negativa y sin afectación visceral (respuesta 1 correcta). Las VPV graves son las que asocian daño visceral: cuando asocian daño renal grave (glomerulonefritis con síndrome nefrítico) y/o pulmonar (hemorragia alveolar) debemos sospechar una vasculitis ANCA positiva. Entre ellas encontramos la GEPa, que asocia eosinofilia, asma e infiltrados pulmonares migratorios, y la PAM, que asocia daño reno-pulmonar en personas de edad avanzada; estas dos entidades se asocian específicamente con p-ANCA (respuestas 2 y 3 correctas). Por otro lado, las VPV con daño visceral y ANCA negativos son de una gravedad intermedia y se trata principalmente de la vasculitis IgA. Esta entidad presenta sintomatología digestiva como distensión y a nivel renal produce una afectación insidiosa (microhematuria con o sin proteinuria y solo en algunos casos deterioro de función renal progresivo, siendo muy raro el síndrome nefrítico; respuesta 4 falsa y por tanto la que debemos marcar).

En un paciente con hiperuricemia, hiperaciduria, cálculos de ácido úrico, coreatetosis y automutilaciones deberá sospechar:

1. Déficit parcial de hipoxantina fosforribosiltransferasa
2. Sobreactividad de fosforribosilpirofosfato sintetasa
3. Déficit completo de hipoxantina fosforribosiltransferasa.
4. Sobreactividad de adenilato sintetasa

Resp. Correcta: 3

Comentario: Los datos clínicos que te aportan son muy característicos de una enfermedad congénita asociada al cromosoma X: el síndrome de Lesh- Nyhan. Este síndrome se incluye dentro de las causas hereditarias de hiperuricemia y se debe a un déficit completo de la enzima hipoxantina fosforribosil transferasa. Además de la hiperuricemia presentan afectación neurológica que cursa con coreoatetosis y automutilaciones. Debes diferenciar este síndrome del de Seegmiller- Kelley, por déficit parcial de la misma enzima, que cursa con hiperuricemia pero sin clínica neurológica.

En las formas generalizadas de la granulomatosis de Wegener suele detectarse en un alto porcentaje de casos:

1. ANA.

2. c-ANCA.
3. Factor reumatoide.
4. Anti-DNA.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Los anticuerpos dirigidos contra el citoplasma de los neutrófilos aparecen fundamentalmente con dos patrones: un patrón perinuclear (P- ANCA), en el que el antígeno más habitualmente detectado es la mieloperoxidasa o la elastasa y uno difuso citoplásmico (C- ANCA) en el que el antígeno más habitualmente identificado es la proteinasa 3. Los p- ANCA pueden aparecer en múltiples enfermedades, fundamentalmente en la PAN microscópica, pero también en otras vasculitis sistémicas, en la enfermedad inflamatoria intestinal, y en hepatopatías autoinmunes. Sin embargo los C- ANCA son más específicos de la enfermedad de Wegener, detectándose en un 50- 90% de enfermos ; siempre teniendo en cuenta que también puede aparecer en otras enfermedades aunque en un menor porcentaje (como en la PAN- m o en la policondritis recidivante)

-----o-----

De los siguientes hallazgos señale el que NO es típico de la panarteritis nodosa:

1. Inflamación necrotizante de arterias de pequeño y mediano calibre.
2. Infiltración de polimorfonucleares en la fase aguda.
3. Granulomas en la pared vascular de células gigantes.
4. Necrosis fibrinoide.

Resp. Correcta: 3

Comentario: LA Panarteritis nodosa clásica es una vasculitis necrotizante que afecta a arterias musculares de pequeño mediano calibre sin afectar a vénulas. En las fases precoces de la enfermedad se observa un infiltrado por neutrófilos de todas las capas de la pared vascular, produciéndose después proliferación de la intima y degeneración de la pared del vaso. En fases mas avanzadas de la enfermedad se observan infiltrado por células mononucleares y necrosis fibrinoide de la pared del vaso, que se acompañan posteriormente de estrechamiento de la luz del vaso, trombosis e infarto de los tejidos irrigados. Las lesiones de la PAN son segmentarias y tienden a afectar más a las bifurcaciones arteriales. Es típico de esta enfermedad la formación de dilataciones aneurismáticas de hasta 1 cm.

-----o-----

En un paciente con infección por HIV y artritis reactiva NO está indicado el tratamiento con:

1. Zidovudina.
2. Metotrexate.
3. Indometacina.
4. Corticoides intrarticulares.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La artritis reactiva es la causa más frecuente de artritis en pacientes con infección por VIH. Además, estos pacientes tienden a desarrollar formas especialmente agresivas de la enfermedad, sobre todo en cuanto a las manifestaciones mucocutáneas. El tratamiento de estos pacientes incluye los AINE y, si son precisos, los corticoides intrarticulares. El metotrexate no suele usarse en estos pacientes inmunodeprimidos, ya que

puede desencadenar un sarcoma de Kaposi o un sida fulminante [respuesta 2 correcta]. Sin embargo, lo que sí suele mejorar los síntomas de estos pacientes es el uso de AZT (zidovudina).

-----o-----

En pacientes con lupus eritematoso sistémico aparecen lesiones cutáneas de lupus eritematoso subagudo en:

1. 10%.
2. 25%.
3. 45%.
4. 85%.

Resp. Correcta: 1

Comentario: La afectación cutánea en el lupus eritematoso sistémico (LES) la observamos en el 80% de los casos, pudiendo aparecer en forma de lesiones agudas, subagudas o crónicas. Las lesiones subagudas se observan en el 10% de los pacientes. Se trata de lesiones eritematosas anulares confluentes (anular policíclico), en las que en ocasiones predomina la descamación (psoriaciforme). Aparecen en zonas de exposición solar como cuello, escote, brazos y se asocian a la aparición de anticuerpos anti- Ro.

-----o-----

¿Ante el hallazgo en una biopsia cutánea de vasculitis leucocitoclástica con depósito de IgA detectada por IFD, en qué enfermedad pensaría?:

1. Vasculitis secundaria a fármacos.
2. Crioglobulinemia mixta esencial.
3. Vasculitis secundaria a linfoma no Hodgkin.
4. Púrpura de Henoch-Schönlein.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La leucocitoclasia o hallazgo de restos nucleares de los PMN fragmentados en la pared de los vasos, se observa en vasculitis de pequeño vaso, llamadas también por hipersensibilidad o predominantemente cutáneas. Pueden ser secundarias a fármacos, a enfermedades linfoproliferativas, aparecer en el contexto de una crioglobulinemia o en otras conectivopatías, como ocurre en el sde de Sjögren, en el Lupus Eritematoso o en la Artritis reumatoide. También pueden aparecer vasculitis leucocitoclásticas en infecciones (endocarditis bacteriana subaguda, VIH, VHB, VHC, VEB) En la púrpura de Schölein- Henoch, también el hallazgo anatomopatológico es una vasculitis leucocitoclástica de pequeño vaso, pero, además esta enfermedad se caracteriza por el depósito de Ig A, que aparece en vasos de la piel y del riñón, y la aparición de inmunocomplejos circulantes IgA, dato que no aparece en las otras enfermedades.

-----o-----

¿Cuál de las siguientes manifestaciones cutáneas NO califica criterio ARA para el diagnóstico de lupus eritematoso sistémico?:

1. Lesiones discoides.
2. Rash malar
3. Úlceras orales.
4. Telangiectasias periungueales.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Las preguntas de patologías reumatológicas con manifestaciones cutáneas están adquiriendo gran importancia en las últimas convocatorias. En el lupus eritematoso sistémico son criterio diagnóstico las manifestaciones cutáneas: rash malar, lupus discoide, y úlceras orales. Las telangiectasias periungueales son típicas de la dermatomiositis, no del lupus eritematoso sistémico y aunque se ven en el LES, no son criterio.

-----O-----

Queremos realizar un ensayo clínico con un nuevo inmunosupresor en pacientes diagnosticados de enfermedad mixta del tejido conectivo (EMTC). ¿Cuál es el porcentaje de individuos reclutados que deben tener positividad a títulos altos (>1/1600) para anticuerpos anti U1-RNP en suero?

1. 50%.
2. 100%.
3. 75%.
4. 90%.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La existencia de anticuerpos anti-U1 RNP es requisito indispensable para cumplir los criterios clasificatorios de la enfermedad mixta de tejido conectivo (criterios de Alarcón-Segovia). Aunque en la práctica clínica en las enfermedades autoinmunes pueden realizarse aproximaciones diagnósticas y terapéuticas sin cumplirse los criterios clasificatorios de forma estricta, en los estudios experimentales es preciso cumplirlos para asegurar una homogeneidad de los individuos a evaluar. Por tanto, el 100% de los reclutados deberían tener positividad para los anti-RNP a títulos altos (respuesta 2 correcta).

-----O-----

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el tratamiento del LES NO es correcta?:

1. A veces, la artritis lúpica responde a antipalúdicos.
2. Las manifestaciones potencialmente mortales deben ser tratadas con glucocorticoides.
3. Las artritis, mialgias y fiebre mejoran con AINE, pero no con corticoides.
4. La toxicidad de los AINE, como el aumento de las enzimas hepáticas, la meningitis aséptica y la afectación renal, son más frecuentes en el LES.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Los corticoides producen mejoría de los síntomas osteomusculares, tanto o más que los AINEs (respuesta 3 falsa). De hecho, en ocasiones los AINEs no bastan y nos obligan a recurrir a los esteroides sistémicos. Recuerda que los corticoides tienen un papel especialmente importante para el tratamiento de las manifestaciones graves o mortales del LES, como la nefropatía lúpica severa (sobre todo la proliferativa difusa).

-----O-----

¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la artritis reumatoide es falsa?

1. Es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta principalmente a articulaciones periféricas.
2. Su etiología es desconocida.
3. Su evolución es variable, desde afectación mínima hasta deformidades limitantes.
4. Es muy habitual la afectación sistémica.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La artritis reumatoide (AR) es una enfermedad inflamatoria crónica que afecta de forma predominante a las articulaciones periféricas, produciendo una sinovitis inflamatoria de distribución simétrica que provoca destrucción del cartílago, con erosiones óseas y deformidades articulares en fases tardías. Puede presentar ocasionalmente una afectación sistémica que puede dañar órganos internos. Su etiología es desconocida, aunque existe una predisposición genética de base reconocida, junto a agentes ambientales no aclarados. Su evolución es variable, desde un proceso con lesiones articulares mínimas, hasta una poliartritis progresiva con deformidades articulares importantes.

-----o-----

Una mujer de 46 años consulta por presentar desde hace años dolor y tumefacción en articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, carpos y rodillas, así como astenia y febrícula. Refiere además la presencia de sequedad oral y sensación de arenilla ocular. En la analítica destaca la presencia de anemia con Hb 10,9 g/l, e hipergammaglobulinemia policlonal, factor reumatoide positivo, con anticuerpos anti-Ro y anti-La negativos. La biopsia de glándula salivar menor muestra un intenso infiltrado de linfocitos que invade y destruye la glándula, y el examen oftalmológico confirma la presencia de una queratoconjuntivitis seca. En radiología de manos se aprecia osteoporosis yuxtaarticular en interfalángicas proximales y metacarpofalángicas, disminución del espacio articular y erosiones en las articulaciones citadas. El diagnóstico más probable es:

1. Síndrome de Sjögren primario.
2. Artritis reumatoide con síndrome de Sjögren secundario.
3. Linfoma de mucosas sobre síndrome de Sjögren.
4. Síndrome de Sjögren primario con pseudolinfoma.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

-----o-----

Laura B. es una mujer de 35 años con historia de tres meses de evolución de dolores articulares que le afectan manos, hombros y, en menor grado, rodillas y pies. Refiere rigidez matutina de tres horas de evolución, astenia intensa hasta el encamamiento, sudoración nocturna y pérdida de 3 kg de peso. En la exploración presenta tumefacción articular dolorosa en las articulaciones interfalángicas proximales (IFP), metacarpofalángicas (MCF), muñecas, hombros, rodillas y articulaciones metatarsianas (MTF). Tiene adenopatías periféricas cervicales y axilares indoloras no

adheridas, así como un nódulo en la superficie de extensión del antebrazo izquierdo. Los análisis de laboratorio muestran VSG 55 mm/hora, FR 1: 1.280, Hb 10,5 g/dL y aumento de proteínas totales a expensas de hipergammaglobulinemia policlonal. Las radiografías de manos y muñecas mostraron osteopenia yuxtaarticular, así como erosiones marginales precoces, afectando a la cuarta IFP de la mano derecha. Fue iniciado tratamiento con AINEs, prednisona en dosis bajas (5 mg/día) y metotrexato (7,5 mg/semana). En esta paciente, la forma de presentación de la enfermedad induce a tratar precozmente y de forma agresiva la enfermedad. Señale cuál de las siguientes afirmaciones NO es correcta:

1. Los pacientes femeninos de raza blanca cursan con sinovitis de carácter más persistente y enfermedad erosiva más rápidamente progresiva que los varones.
2. Los pacientes que presentan títulos altos de FR, PCR y haptoglobina tienen un peor pronóstico.
3. La presencia de nódulos subcutáneos, como en el caso descrito, así como la de erosiones radiológicas, es índice de severidad pronóstica.
4. Aproximadamente el 40% de los pacientes con artritis reumatoide cursan con un proceso inflamatorio agudo que remite sin deformidades mayores.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La descripción de la paciente deja claro que se trata de un AR al cumplir todos los criterios propuestos para el diagnóstico de la enfermedad. La paciente muestra varias características sugestivas de mala evolución, como el sexo femenino y la raza blanca. Efectivamente, tiene tendencia a producir sinovitis más persistente y mayor frecuencia de erosiones, la elevación de la VSG, la presencia de erosiones, nódulos reumatoides y título elevados de FR son también datos de agresividad y mal pronóstico. No obstante, la evolución de la AR es muy variable y difícil de predecir en cada paciente, de forma que el patrón de inicio del proceso no parece tener valor predictivo respecto a la aparición de incapacidad. Las formas autolimitadas no suponen, lamentablemente, más que el 15% de los casos (opción 4 incorrecta, por lo que la marcamos).

-----O-----

Acude a urgencias un paciente varón de 35 años con inflamación del 4º dedo de la mano derecha. En la exploración existe flogosis uniforme del dedo sin aparente herida o puerta de entrada. Concluye que puede tratarse de un caso de dactilitis. Cuál de las siguientes entidades NO entraría en el diagnóstico diferencial:

1. Artritis reactiva.
2. Espondilitis anquilosante.
3. Sarcoidosis.
4. Lupus eritematoso sistémico.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La dactilitis o “dedo en salchicha” es un hallazgo importante por su baja frecuencia y a su vez su estrecha relación con determinados procesos: enfermedades inflamatorias (espondiloartropatías, sarcoidosis, gota), infecciosas (tuberculosis, sífilis) y no inflamatorias (anemia de células falciformes). Por tanto, de las respuestas ofrecidas, el lupus eritematoso sistémico es el que no se asocia a dactilitis (respuesta 4 correcta).

-----O-----

De las siguientes afirmaciones señale la que NO es cierta para la espondiloartritis anquilosante:

1. Se presenta uveítis anterior aguda en más del 20% de los pacientes.
2. Es más frecuente en los familiares de pacientes que en el resto de población.
3. La insuficiencia aórtica suele aparecer en las formas avanzadas de la enfermedad.
4. Las sacroiliacas están afectadas casi siempre. Se suele erosionar primero el cartílago del sacro y después el del iliaco.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Los procesos inflamatorios que afectan a la sacroiliaca comienzan por afectar la vertiente iliaca de la articulación y la espondilitis anquilosante no es una excepción dentro de ellas. El resto de las opciones son correctas aunque la incidencia que se atribuye a la uveítis anterior suele ser algo mayor (30%). La relación entre las espondiloartropatías y la inflamación intestinal se traduce en que en esta enfermedad es muy frecuente la presencia de lesiones inflamatorias similares a las de la EII pero habitualmente subclínicas. La insuficiencia aórtica suele aparecer en fases evolucionadas de la enfermedad.

-----O-----

Mujer de 81 años que acude a Urgencias derivada desde su Centro de Salud porque en los últimos 3 meses ha presentado un deterioro general progresivo, ha reducido su movilidad, y se han objetivado úlceras de 2-3 cm en tercio distal de ambos miembros inferiores. ¿Cuál de los siguientes datos le inclinarían en MAYOR medida hacia una vasculitis como causa subyacente?

1. Historia de diabetes mellitus e insuficiencia venosa crónica.
2. AgHBs positivo.
3. Factor reumatoide positivo.
4. Leucocitosis con neutrofilia.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Veamos las opciones de respuesta:

- 1.- Las úlceras en miembros inferiores en los pacientes ancianos son muy frecuentes debido a la elevada incidencia de inmovilidad y consiguiente estasis sanguínea, insuficiencia venosa crónica y patología micro y macrovascular derivada de la diabetes mellitus y la hipertensión.
- 2.- La aparición de úlceras en miembros inferiores en pacientes sin factores de riesgo cardiovascular con cuadro general, nos debe hacer sospechar una paniculitis, siendo expresión de algunas vasculitis, típicamente de la panarteritis nodosa asociada al VHB (respuesta 2 correcta).
- 3.- El factor reumatoide positivo es un hallazgo frecuente en pacientes ancianos, y no se asocia específicamente con vasculitis, siendo igualmente inespecífico y cobrando relevancia en determinados contextos clínicos como un cuadro sugestivo de AR.
- 4.- El hallazgo de leucocitosis con neutrofilia es inespecífico; podría deberse a cualquier etiología, por la propia lesión cutánea, sobreinfección bacteriana, etc.

-----O-----

Un paciente de 25 años consulta por dolor dorsolumbar de predominio nocturno, que

se acompaña de rigidez tras el reposo y se alivia parcialmente con la actividad física o con el uso de antiinflamatorios. La exploración física muestra limitación de la expansión torácica y de la movilidad de la columna lumbar. La radiografía muestra estrechamiento del espacio articular, esclerosis y erosiones en ambas articulaciones sacroilíacas. Al informar sobre el pronóstico y la evolución al paciente lo correcto será explicarle que:

1. El tratamiento médico agresivo (inmunosupresores) será eficaz.
2. El proceso será autolimitado.
3. El ejercicio físico moderado (natación) será la medida más útil para prevenir la limitación funcional.
4. Su enfermedad no producirá afectación visceral.

Resp. Correcta: 3

Comentario: El cuadro clínico que nos describen corresponde (y cumple criterios) a una espondilitis anquilosante. La enfermedad no es susceptible de ningún tratamiento "de fondo" ya que no hay ninguna medida que evite o retrase la evolución a la anquilosis propia de la enfermedad. La única medida eficaz para proporcionar alivio de los síntomas son los AINEs. El proceso tiende a la cronicidad en una secuencia en la que la inflamación es progresivamente sustituida por la fibrosis, lo que clínicamente se traduce por que el dolor se sustituye por limitación de la movilidad. A pesar de todo ello la mayoría de los pacientes desarrollan limitaciones funcionales que no les impide llevar una vida prácticamente normal. La medida que puede paliar esta limitación funcional es el ejercicio físico moderado, siendo la natación la actividad física más adecuada.

-----O-----

Señale entre las siguientes cual no es una complicación del tratamiento con metotrexato?:

1. Hepatopatía crónica.
2. Neumonitis.
3. Anemia hemolítica.
4. Aftosis.

Resp. Correcta: 3

Comentario: El metotrexato es el fármaco modificador de la enfermedad considerado de elección hoy en día en el tratamiento de la AR. Sus principales efectos secundarios es la toxicidad hepática que se manifiesta inicialmente por anomalías de la función hepática debido al desarrollo de una fibrosis hepática. Este proceso está relacionado con la dosis, es reversible y es la causa de que se deba de evitar este tratamiento en pacientes con hepatopatía. Son comunes la aparición de úlceras orales e incluso en ocasiones se ha observado neumonitis inducida por el metotrexato. También es curioso que en algunos pacientes la administración de metotrexato produce un espectacular aumento del número de nódulos reumatoides. Entre la toxicidad hematológica podemos encontrar leucopenia o trombopenia pero no anemia hemolítica.

-----O-----

¿Cuál de las siguientes citoquinas parece tener un papel muy relevante en la granulomatosis eosinofílica con poliangéitis (GPEA) y podría ser una diana terapéutica?

1. IL-1.

2. IFN-gamma.
3. IL-5.
4. IL-12.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

La respuesta TH2 implicada en los mecanismos de hipersensibilidad mediados por IgE y sus células efectoras (eosinófilos, mastocitos) se caracteriza por el aumento de las citoquinas IL-4, IL-5 (respuesta 3 correcta) e IL-13. Las demás citoquinas propuestas son características de la respuesta TH1.

-----O-----

Señale la respuesta correcta en la polimiositis por cuerpos de inclusión:

1. Se afectan personas ancianas, con predominio de varones.
2. El inicio de los síntomas es extremadamente rápido.
3. Presencia casi constante de autoanticuerpos.
4. La CK siempre está elevada.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

-----O-----

Paciente de 63 años que refiere, desde hace varios meses, la aparición de dolor en la base del pulgar de la mano derecha, y posteriormente en la izquierda, junto con progresiva deformidad que va haciendo adoptar a la mano un «aspecto cuadrado». El dolor cede con el reposo y se exacerba con algunas actividades, como abrir el tapón de una botella o escurrir un paño. En la exploración, la paciente presenta además nódulos de Heberden. ¿Cuál es el diagnóstico MÁS probable en esta paciente?

1. Artritis reumatoide de comienzo.
2. Rizartrrosis.
3. Síndrome del túnel del carpo bilateral.
4. Enfermedad de Dupuytren incipiente.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

Pregunta cuyo enunciado nos habla de una afectación artrósica del pulgar conocida como rizartrrosis (respuesta 2 correcta).

-----O-----

En todos MENOS en uno de los siguientes procesos puede existir osteoartropatía hipertrófica obstructiva. Señálelo:

1. Carcinoma broncogénico.
2. Enfermedad inflamatoria intestinal.

3. Endocarditis bacteriana.
4. Hipotiroidismo.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Excepto en el hipotiroidismo, en todas las demás situaciones podemos encontrar cambios de periostitis seguidos de nueva formación de hueso, característicos de la osteoartropatía hipertrófica obstructiva. Si bien las causas son múltiples, las más frecuentes son enfermedades localizadas en el tórax. Existen formas primarias más frecuentes en los varones y con una clara predisposición familiar. Las secundarias suelen serlo a procesos pulmonares (FQ; Carcinomas, mesoteliomas, infecciones crónicas, etc.), cardíacos (endocarditis, cardiopatías congénitas), intestinales (enfermedad inflamatoria intestinal, tumores, infecciones crónicas), hepáticas (cirrosis, carcinoma), mediastínicas (como el timoma o carcinoma esófago), y otras variadas causas como podría ser la enfermedad de Graves o la talasemia.

-----o-----

Una mujer de 22 años, en seguimiento y tratamiento por su médico de cabecera por historia de LES de 3 años de evolución, es remitida a su especialista para consejo terapéutico. Durante un brote de pleuropericarditis, un año antes, se detectaron hematuria, albuminuria y creatinina sérica de 1,6 mg/dl. No se realizó biopsia y siguió tratamiento de presunta nefritis lúpica con dosis altas de prednisona, que posteriormente se mantuvo 9 semanas a 10 mg/día. No obstante, la proteinuria se eleva a 1,5 mg/dl con creatinina 1,7 mg/dl. En el sedimento urinario, microhematuria y algún cilindro hemático. El complemento sérico es normal. Los antiDNA están elevados a título moderado. Rechazaron citotóxicos por el riesgo de infertilidad, pero solicitan información terapéutica sobre el mejor pronóstico para la afección renal. ¿Cuál es su respuesta?:

1. Previo a consejo terapéutico, es preceptiva la biopsia renal para establecer el grado de afección renal y su ritmo evolutivo.
2. La mejor combinación en este caso sería la ciclofosfamida oral asociada a esteroides en bajas dosis.
3. En ocasiones, pulsos intravenosos de ciclofosfamida cada 4 semanas aseguran una buena respuesta, pero aumentan la toxicidad vesical.
4. Lo más adecuado en este caso es la observación, tratando las complicaciones extrarrenales de la paciente.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Las indicaciones para la realización de la biopsia renal en el lupus eritematoso sistémico es uno de los temas más debatidos y poco claros en los libros de medicina interna. Podemos considerar que en este caso es adecuada la realización de una biopsia renal ya que cumple varias de las características que se suelen solicitar para su realización. Las indicaciones de biopsia son: - Alteración de la función renal (creatinina superior a 1,5) demostrada en dos o más ocasiones. - Proteinuria superior a 500 mg/24 h mantenida en 2 o mas ocasiones. - Alteración del sedimento urinario: hematuria o presencia de cilindros granulosos (mantenido y tras descartar infección urinaria). El resto de las respuestas son además claramente falsas. La azatioprina es un inmunosupresor que al igual que la ciclofosfamida se utiliza en la nefropatía lúpica. La utilización de ciclofosfamida en forma de bolos mensuales disminuye su toxicidad respecto a la administración diaria por vía oral. Por último, la actitud expectante no es adecuada en este caso, ya que dependiendo del resultado de la biopsia nos plantearemos un tratamiento más o menos agresivo.

-----o-----

En la esclerodermia, con respecto a la afectación esofágica, señale lo MENOS frecuente:

1. Se afectan sobre todo los 2/3 inferiores.
2. La mucosa está adelgazada.
3. Se observa un aumento de fibras de colágeno.
4. La fibrosis es muy extensa.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La afectación esofágica de la esclerodermia es la manifestación visceral digestiva más frecuente. La mayoría de los pacientes presentan disfunción esofágica con alteración de la motilidad de los dos tercios inferiores (respuesta 1 verdadera) y disfunción del esfínter esofágico inferior. Histológicamente, se advierte un adelgazamiento de la mucosa (respuesta 2 verdadera), aumento del colágeno en la lámina propia, submucosa y serosa (respuesta 3 verdadera), siendo la alteración más trascendente la ATROFIA DE LA MUSCULAR (respuesta 5 verdadera), pero sin FIBROSIS EXTENSA (respuesta 4 falsa).

-----o-----

Una paciente de 42 años refiere dolor de características inflamatorias y tumefacción en ambas muñecas, segundas y terceras metacarpofalángicas, e interfalángicas proximales de forma bilateral y tobillo izquierdo de cuatro meses de evolución, acompañados de rigidez matutina de más de una hora de duración. En la radiografía de manos se objetiva una erosión en la apófisis estiloides del cúbito en el carpo derecho. En la analítica destaca una Hb: 10 g/dL con VSG de 45 mm en primera hora, PCR 16 mg/L, factor reumatoide 160 UI/mL. Tras seis meses de tratamiento con indometacina y metotrexate, la paciente persiste con dolor y tumefacción de ambos campos, rigidez matutina de 30 minutos de duración y una analítica donde destaca una VSG 30 mm en primera hora y una PCR 9 mg/dL. Respecto a la actitud a tomar, ¿cuál de las siguientes opciones es VERDADERA?

1. Suspender el tratamiento pautado por la falta de respuesta e iniciar prednisona a dosis altas para el control de los síntomas exclusivamente.
2. Mantener la actitud terapéutica tomada, dado que solo llevamos seis meses y habría que esperar un mínimo de nueve para valorar respuesta terapéutica.
3. Si no existe contraindicación médica, valorar asociar al tratamiento un anti-TNF alfa.
4. Iniciar lo antes posible un segundo fármaco modificador de la enfermedad, dado que no se podría iniciar tratamiento con terapia biológica solo tras metotrexate.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Se plantea a un paciente con una artritis reumatoide seropositiva, tratada con AINEs y metotrexate, que presenta actividad de la enfermedad, por lo que es necesario progresar en el tratamiento. Se puede considerar añadir al metotrexate otro fármaco oral como la leflunomida, sulfasalacina o hidroxicloroquina, pero lo más eficaz es añadir un anti-TNF alfa (respuesta 3 correcta).

-----o-----

Uno de los tipos de lupus es el inducido por fármacos. ¿Cuál es el fármaco más relacionado con este tipo de lupus?

1. Hidralacina.
2. Pirazinamida.
3. Propranolol.
4. Flecainida.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Los fármacos más relacionados con el lupus inducido por fármacos son la hidralacina y la procainamida, aunque también se ha asociado al tratamiento con isoniácida, clorpromacina, D-penicilamina y fármacos anti-TNF.

-----O-----

La acumulación de cristales de oxalato cálcico en el líquido sinovial se da básicamente en una enfermedad:

1. Cirrosis hepática.
2. Insuficiencia renal crónica.
3. Amiloidosis.
4. Alcaptonuria.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

El depósito articular de oxalato cálcico puede verse en el contexto de una oxalosis primaria o secundaria:

- La oxalosis primaria es una enfermedad muy rara. La formación excesiva de ácido oxálico se debe a un defecto enzimático.

- La oxalosis secundaria es mucho más frecuente y es típica de enfermos renales, en los que está deteriorada la excreción de oxalato, con la consiguiente tendencia al depósito.

-----O-----

¿Qué tipo de cardiopatía ocasiona fundamentalmente la amiloidosis?:

1. Cardiopatía isquémica.
2. Miocardiopatía restrictiva.
3. Miocardiopatía hipertrófica.
4. Pericarditis restrictiva.

Resp. Correcta: 2

Comentario: La afectación cardíaca no es de lo más preguntado, pero es bastante típica. Debes recordar que la amiloidosis consiste en el depósito de material proteico amiloide. Si este material infiltra el corazón, fundamentalmente el miocardio (el amiloide se deposita entre los miocitos), generará una miocardiopatía restrictiva, con una imagen ecocardiográfica bien típica: "centelleo granular"; así, interfiere con la contractilidad normal, genera arritmias, bloqueos de conducción,? Debes saber también que la afectación cardíaca constituye la primera causa de muerte en la amiloidosis primaria. La miocardiopatía hipertrófica se genera por hipertrofia de miocitos por sobrecarga de presión; la afectación valvular, pericárdica y coronaria

es más rara.

-----O-----
¿Cuál de los siguientes anticuerpos no se relacionan con el síndrome antifosfolípido?

1. Aanticoagulante lúpico.
2. Anti beta-2-glicoproteína.
3. ANA.
4. Anticardiolipina.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

-----O-----
La queratodermia blenorragica, típica lesión cutánea de la forma postvenérea de la artritis reactiva, es histológicamente indistinguible de las lesiones cutáneas de:

1. LES.
2. Psoriasis.
3. Enfermedad inflamatoria intestinal.
4. Vasculitis leucocitoclástica.

Resp. Correcta: 2

Comentario:

La queratodermia blenorragica es una manifestación que a veces acompaña a la artritis reactiva. Consiste en lesiones vesículo- pustulosas que evolucionan hacia hiperqueratosis, localizadas en palmas y plantas. Histológicamente, puede ser indistinguible a otra enfermedad que puede dar pústulas palmoplantares, que es la psoriasis.

Otra manifestación que puede coexistir con la queratodermia blenorragica es la balanitis circinada. Son lesiones indoloras, también vesiculosas, que aparecen en el glande y producen erosiones cuando se rompen.

-----O-----
¿Cuál de las siguientes características clínicas NO es común entre la artritis reactiva y la artritis psoriásica?:

1. Artritis asimétrica.
2. Presencia de uveítis.
3. Lesiones cutáneas.
4. Úlceras en mucosas.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

Ambos procesos son espondiloartropatías, de modo que comparten múltiples características: asociación a HLA-B27, tendencia a la entesitis e inflamación axial, asimetría, etc. De entre las manifestaciones sistémicas, comparten lesiones cutáneas y afectación ocular (conjuntivitis, uveítis anterior) pero no las

úlceras en mucosas, que a menudo apreciamos en la artritis reactiva pero no son propias de la artropatía psoriásica.

En un paciente de 35 años con inflamación en articulaciones metacarpofalángicas y condrocalcinosis radiológica a éste nivel se realiza una biopsia sinovial que muestra depósitos de hemosiderina, debe sospechar:

1. Ocronosis.
2. Hemocromatosis.
3. Artropatía amiloide.
4. Sinovitis vellonodular.

Resp. Correcta: 2

Comentario: Al tratarse de un paciente joven, de menos de 55 años, con condrocalcinosis radiológica debes pensar en una artropatía por microcristales de pirofosfato asociada a una enfermedad metabólica o a una forma familiar. Dentro de la enfermedades metabólicas se incluyen el grupo de las "cuatro H": hiperparatiroidismo primario, hemocromatosis, hipofosfatasia e hipomagnesemia. Dispones de un dato determinante para confirmar el diagnóstico de hemocromatosis: el depósito de hemosiderina en la biopsia de la membrana sinovial.

Varón de 30 años que consulta por artritis de rodilla derecha de inicio brusco y talalgia bilateral. Las características del líquido sinovial son: 40.000 leucocitos/mm³, proteínas elevadas y glucosa normal, sin microorganismos en el Gram. ¿Qué diagnóstico le parece más probable?

1. Artritis reactiva.
2. Artritis reumatoide.
3. Artritis gonocócica.
4. Artritis infecciosa.

Resp. Correcta: 1

Comentario: Esta pregunta tiene comentario en vídeo.

Un varón de 80 años, diabético de años de evolución, acudió a consulta por rigidez de raquis de 10 años de evolución. En la anamnesis dirigida no refería dolor alguno. La exploración física evidenció una gran disminución de la flexo-extensión, flexiones laterales y rotaciones del raquis cervical. El raquis dorsal y lumbar también estaba limitado. La radiología evidenció calcificaciones en la cara antero-lateral de los cuerpos vertebrales formando puentes óseos intervertebrales, que predominaban en lado derecho; el espacio discal estaba conservado. ¿Cuál es su diagnóstico?:

1. Espondilitis anquilopoyética.
2. Artrosis de raquis.
3. Hiperostosis anquilosante vertebral de Forestier-Rotes.

4. Melorreostosis.

Resp. Correcta: 3

Comentario:

Es la foto típica de la hiperostosis anquilosante vertebral difusa (enfermedad de Forestier). Esta enfermedad presenta rigidez axial (principalmente dorsal y cervical baja, sin comprometer las sacro ilíacas) en pacientes de edad avanzada, indolora (o con muy poco dolor de características mecánicas) y cuyos hallazgos radiológicos descritos en la pregunta se corresponden a engrosamientos asimétricos de las corticales de las vértebras, dando un aspecto de imagen en “cera derretida”, sin presentar sindesmofitos. Respuesta correcta la opción 3.

En la artrosis del raquis se produce dolor, limitación y además alteración en el espacio intervertebral por lesión del cartilago articular. Las vértebras que se afectan con mayor frecuencia son las cervicales y lumbares.

La Espondilitis anquilosante (aunque al igual que el Forestier es más frecuente en varones), suele iniciar antes de 40 años, con limitación y dolor de características inflamatorias a nivel de las sacro ilíacas [sacroileitis radiológica generalmente simétrica, es hallazgo radiológico imprescindible (100% de los casos)] y que clásicamente en la radiografía de columna vertebral muestra el patrón “caña de bambú” por la presencia de cuadratura vertebral, sindesmofitos y anquilosis de las articulaciones interapofisarias.

La Melorreostosis (poco frecuente) es un engrosamiento de la cortical ósea, distribuida a lo largo del eje mayor de los huesos largos de las extremidades, de tal forma que simula el “escurrimiento de la cera de la vela” que se produce en la enfermedad de Forestier a nivel de la columna vertebral.

La Mastocitosis en sus dos variantes, la cutánea (más frecuente) y la sistémica con afectación de varios órganos como médula ósea y/u otros órganos extracutáneos como huesos, hígado, bazo o ganglios linfáticos (70% afectación ósea), en la radiología hablarían de un patrón osteolítico u osteoblástico en varios huesos, acompañados de clínica sistémica.

-----O-----

Un paciente de cincuenta años consulta por sequedad de boca, sensación de arenilla debajo de los párpados, artralgias y febrícula. ¿Cuál de las siguientes pruebas realizaría para confirmar el diagnóstico?:

1. VSG.
2. Determinación de factor reumatoide.
3. Endoscopia alta.
4. Biopsia de glándulas salivares menores del labio.

Resp. Correcta: 4

Comentario: Todas las respuestas apuntan a una entidad: el síndrome de Sjögren. No es excesivamente importante, pero debes saber reconocerlo y diagnosticarlo: la sequedad de ojos (xerofthalmía con queratoconjuntivitis seca) y boca (xerostomía) son los síntomas cardinales, por infiltración linfocitaria y desestructuración glandular. Además pueden existir manifestaciones extraglandulares como artralgias... Es cierto que un 80% de los pacientes presentan positividad para el factor reumatoide, y que los anticuerpos anti SS- A (anti Ro) y anti SS- B (anti- La) suelen ser positivos sobre todo en las formas primarias. Sin embargo, si buscamos una prueba diagnóstica confirmatoria, que sea específica, ésta ha de ser anatomopatológica (como cualquier otra enfermedad), y de elección es la biopsia de glándulas salivales menores, que evidenciará el infiltrado linfocitario y la desestructuración glandular. Si sospechamos que ha

evolucionado a linfoma, entonces practicaremos biopsia de la adenopatía más accesible.

-----O-----

Cuál de los siguientes datos asocia el peor pronóstico en una paciente de 30 años diagnosticada de lupus eritematoso sistémico:

1. Linfocitos 300/mm³ (leucocitos 2500/mm³).
2. Hemoglobina 8 g/dl con test de Coombs negativo.
3. Peritonitis aséptica.
4. Creatinina 2 mg/dl.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La mortalidad en la primera década de la enfermedad se asocia principalmente a la nefritis y las infecciones, por lo que el dato de peor pronóstico será el que nos oriente a una nefritis lúpica establecida (opción 4 correcta). La leucopenia, linfopenia, anemia crónica y las serositis no infecciosas son manifestaciones muy frecuentes, que se presentan en formas leves. El test de Coombs en un contexto clínico y analítico adecuado nos indicaría anemia hemolítica, manifestación que sí podría asociar gravedad en caso de presentarse de forma aguda e intensa, aunque es poco habitual.

-----O-----

En un paciente con diagnóstico de artritis reumatoide (AR), ¿cuál de los siguientes hallazgos es MÁS improbable?

1. Dactilitis.
2. Artritis de rodilla.
3. Pleuritis.
4. Síndrome del túnel carpiano.

Resp. Correcta: 1

Comentario:

La dactilitis o “dedo en salchicha” se debe a la afectación articular y periarticular de las articulaciones de un dedo, con un aspecto de tumefacción global del mismo. Se trata de una manifestación propia de las espondiloartropatías seronegativas y no se asocian a la artritis reumatoide (marcamos la opción de respuesta 1). La artritis de rodilla se presenta en el 60% o más de los pacientes con AR. La manifestación pulmonar más frecuente en la AR es la pleuritis con derrame asintomático. En la AR se observa una alta incidencia de síndrome de túnel del carpo, a veces bilateral, debido a la tenosinovitis de los flexores que atraviesan esta estructura anatómica.

-----O-----

Mujer blanca de 31 años, con LES desde hace seis años. Se ve aquejada fundamentalmente de rash cutáneo, artritis y fiebre ocasional. Presenta proteinuria leve desde hace 6 años. Controla su artritis con 10 mg de prednisona/día. En su primer embarazo, la analítica a las 16 semanas muestra Hb 11,2 g/dl; leucocitos 3.600/cc, plaquetas 175.000/cc, anticuerpos anticardiolipina IgG positivos, IgM negativos, anti-RO (SS1. positivos, anti-LA (SS-2. negativos, antiRNP negativos, antiDNA débilmente

positivo, junto con mialgias generalizadas. A las 24 semanas comenzó con artritis leve, sin cambios analíticos con crecimiento intrauterino normal. A las 28 semanas presenta eritema palmar, artritis franca, TA 120/90 y disminución de niveles de complemento C3 y C4. La exploración sistémica es normal. Señale el enunciado INCORRECTO:

1. El embarazo, y especialmente el parto, pueden activar un brote de la enfermedad lúpica. Si se controla ésta, y no existe afectación renal o cardíaca, el embarazo a término y sin problemas es posible en la mayoría de los casos.
2. La presencia de anti-RO (SS1. puede ocasionar lupus neonatal por paso transplacentario con rash cutáneo y raramente bloqueo cardíaco congénito permanente de forma imprevisible.
3. Los anticuerpos anticardiolipina se asocian a mayores tasas de aborto y muerte fetal, por lo que está indicado asociar aspirina en dosis bajas (75 mg) y anticoagulación con heparina subcutánea, si la paciente ha tenido abortos previos.
4. La metilprednisolona está contraindicada por ocasionar anomalías fetales tras atravesar la placenta.

Resp. Correcta: 4

Comentario:

La metilprednisolona es un corticoide que puede emplearse sin problema, ya que no atraviesa la placenta. Los que deben ser evitados son la dexametasona y la betametasona, que son capaces de atravesarla y llegarían a sangre fetal (respuesta 4 falsa).